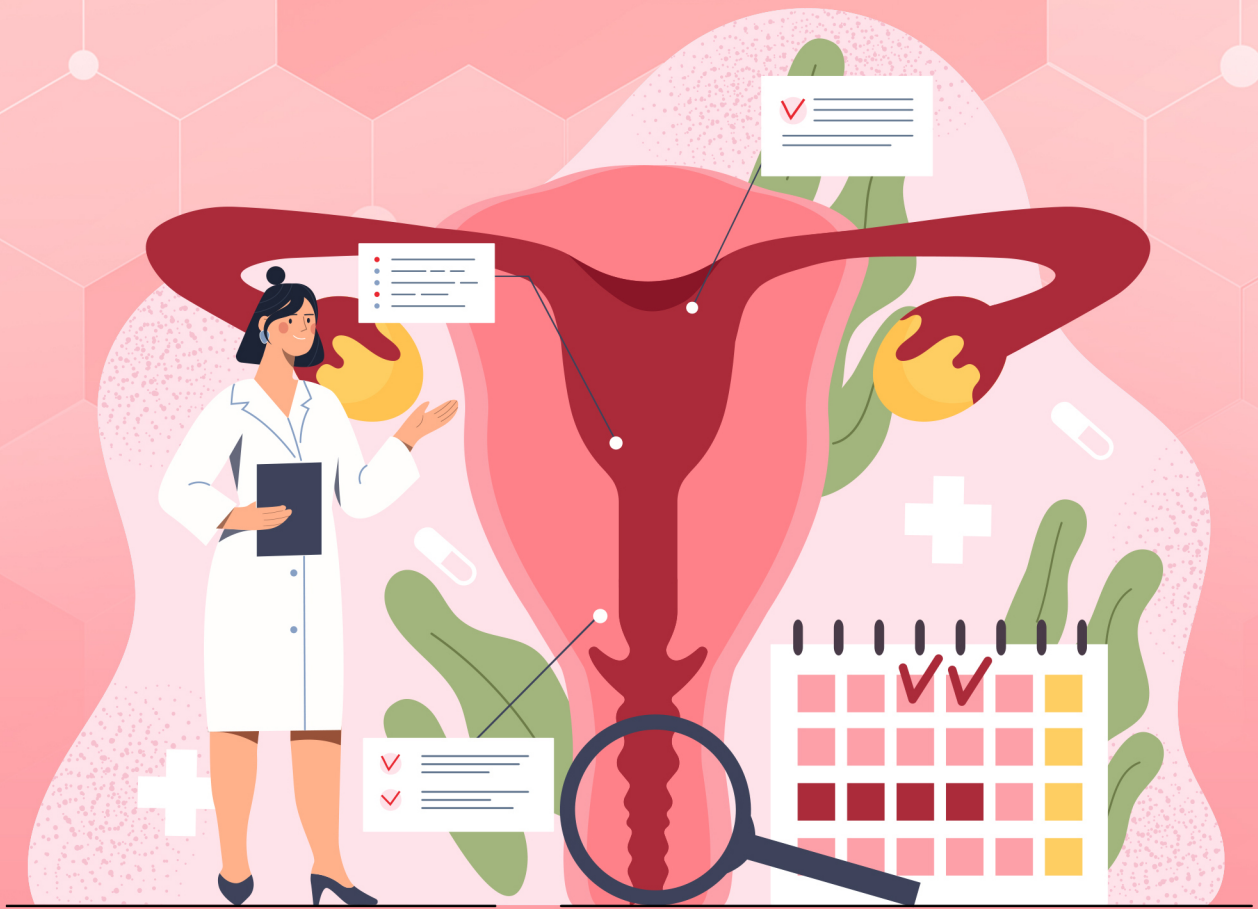




Bunga Rampai **KESEHATAN REPRODUKSI HOLISTIK**

Pendekatan Integratif Bagi Bidan, Perawat, Apoteker, Dan Ahli Gizi

Sitawati • Maria Florentina N. Kosad
Khafidhiyah Nur Insaniyah • Sriama Muliani
Ade Rahayu Prihartini • Fina Sancaya Rini
Queen Khoirun Nisa' Mairo

Editor: Ida Susila

BUNGA RAMPAI

KESEHATAN REPRODUKSI HOLISTIK: PENDEKATAN INTEGRATIF BAGI BIDAN, PERAWAT, APOTEKER, DAN AHLI GIZI

Penulis:

Sitawati, SST., M.Keb.
Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes.
Khafidhiyah Nur Insaniyah, S.Tr.Keb., M.Kes.
Sriama Muliani, SST., M.Kes.
Bdn. Ade Rahayu Prihartini, S.ST., M.Kes.
Fina Sancaya Rini, S.ST., M.Kes.
Dr. Queen Khoirun Nisa' Mairo, SST.Bdn., M.Keb.

Editor:

Bdn. Ida Susila, SST., M.Kes.



BUNGA RAMPAI KESEHATAN REPRODUKSI HOLISTIK: PENDEKATAN INTEGRATIF BAGI BIDAN, PERAWAT, APOTEKER, DAN AHLI GIZI

Penulis:

Sitawati, SST., M.Keb.
Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes.
Khafidhiyah Nur Insaniyah, S.Tr.Keb., M.Kes.
Sriama Muliani, SST., M.Kes.
Bdn. Ade Rahayu Prihartini, S.ST., M.Kes.
Fina Sancaya Rini, S.ST., M.Kes.
Dr. Queen Khoirun Nisa' Mairo, SST.Bdn., M.Keb.

Editor: Bdn. Ida Susila, SST., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7556-44-8

Cetakan Pertama : Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku bookchapter “Bunga Rampai Kesehatan Reproduksi Holistik: Pendekatan Integratif bagi Bidan, Perawat, Apoteker, dan Ahli Gizi” dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca. Buku ini lahir dari kebutuhan nyata bahwa isu kesehatan reproduksi tidak dapat lagi dipahami sebatas persoalan klinis semata, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari kesejahteraan manusia yang utuh mencakup aspek fisik, mental, sosial, budaya, dan bahkan spiritual sepanjang siklus kehidupan.

Perkembangan situasi kesehatan saat ini menunjukkan bahwa tantangan kesehatan reproduksi semakin kompleks. Peningkatan kasus anemia dan kekurangan gizi pada remaja, kehamilan tidak direncanakan, infeksi menular seksual, komplikasi kehamilan, hingga permasalahan laktasi dan kesehatan pascapersalinan adalah contoh isu yang saling terkait dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tantangan tersebut juga dipengaruhi oleh determinan sosial seperti pendidikan, ekonomi, akses layanan, norma budaya, serta literasi kesehatan yang masih beragam. Karena itu, pendekatan integratif yang menggabungkan layanan klinis, promosi kesehatan, pemberdayaan komunitas, dan dukungan psikososial menjadi semakin penting untuk memastikan layanan kesehatan reproduksi benar-benar berpusat pada individu dan keluarga.

Buku bunga rampai ini menghadirkan berbagai perspektif dan kontribusi lintas profesi bidan, perawat, apoteker, dan ahli gizi yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan reproduksi. Bidan berperan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan perempuan dan ibu-anak, perawat memperkuat asuhan holistik dan kesinambungan pelayanan, apoteker mengoptimalkan keamanan serta ketepatan penggunaan obat dan suplemen pada fase reproduktif, sedangkan ahli gizi memastikan intervensi nutrisi yang tepat untuk mendukung fungsi reproduksi dan mencegah dampak jangka panjang bagi ibu maupun anak. Kolaborasi interprofesional di antara keempat profesi ini menjadi landasan penting agar pelayanan tidak terfragmentasi, pesan kesehatan konsisten, dan keputusan klinis lebih aman serta efektif.

Dalam penyusunannya, buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang aplikatif dan kontekstual. Setiap chapter diharapkan dapat membantu pembaca

melihat keterhubungan antara teori dan praktik, serta memberi inspirasi strategi implementasi di fasilitas pelayanan kesehatan maupun komunitas. Dengan pendekatan holistik, pembaca diajak memahami bahwa kualitas kesehatan reproduksi bukan hanya ditentukan oleh tindakan medis, tetapi juga oleh edukasi yang tepat, komunikasi yang empatik, penguatan perilaku sehat, perlindungan hak pasien, serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi cakupan maupun kedalaman pembahasan, mengingat dinamika ilmu pengetahuan, regulasi, dan kebutuhan pelayanan yang terus berkembang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi kesehatan, dan pemangku kebijakan dalam memperkuat pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih manusiawi, aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis, editor, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi setiap upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi masyarakat Indonesia.

Februari, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 MANAJEMEN NUTRISI UNTUK KESEHATAN REPRODUKSI:

PRA-KONSEPSI, KEHAMILAN, DAN PASCA MELAHIRKAN..... 1

Sitawati, SST., M.Keb. 1

A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Kesehatan Reproduksi dan Nutrisi.....	2
C. Manajemen Nutrisi pada Masa Prakonsepsi	5
D. Manajemen Nutrisi Masa Kehamilan	10
E. Manajemen Nutrisi Pasca Melahirkan	25
F. Simpulan.....	33
G. Referensi.....	34
H. Glosarium.....	37

CHAPTER 2 PERAWATAN KESEHATAN MENSTRUASI (MENSTRUAL

HYGIENE MANAGEMENT) DI KOMUNITAS39

Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes.39

A. Pendahuluan/Prolog	39
B. Konsep dan Ruang Lingkup Menstrual Hygiene Management di Komunitas	40
C. Determinan Sosial dan Hambatan Terhadap Pelaksanaan MHM di Komunitas	41
D. Intervensi Edukasi dan Pemberdayaan MHM Berbasis Komunitas.....	42
E. Peran Tenaga Kesehatan Interprofesional Dalam Pendekatan Holistik MHM.....	43
F. Dampak MHM Pada Kesehatan, Pendidikan dan Kualitas Hidup	45
G. Kebijakan, Advokasi dan Arah Pengembangan Penelitian MHM.....	46
H. Simpulan.....	48
I. Referensi.....	49
J. Glosarium.....	50

CHAPTER 3 PENATALAKSANAAN GANGGUAN REPRODUKSI: PCOS, ENDOMETRIOSIS, INFERTILITAS DARI PERSPEKTIF INTERPROFESI	53
Khafidhiyah Nur Insaniyah, S.Tr.Keb., M.Kes.	53
A. Pendahuluan/Prolog	53
B. Konsep Interprofesi	54
C. Penatalaksanaan Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) Secara Interprofesi	56
D. Penatalaksanaan Endometriosis secara Interprofesi	60
E. Penatalaksanaan Infertilitas secara Interprofesi	64
F. Simpulan.....	68
G. Referensi.....	68
H. Glosarium.....	73
 CHAPTER 4 PERAN PERAWAT DAN BIDAN DALAM KONSELING KESEHATAN SEKSUAL DAN PENCEGAHAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL	75
Sriama Muliani, S.ST., M.Kes.	75
A. Pendahuluan/Prolog	75
B. Kesehatan Seksual & Infeksi Menular Seksual (IMS).....	76
C. Konseling Kesehatan Seksual.....	79
D. Pencegahan Penyakit Menular Seksual.....	82
E. Peran Perawat dan Bidan dalam Konseling Kesehatan Sosial dan Pencegahan IMS berdasarkan Kebijakan yang mengatur.....	84
F. Simpulan.....	88
G. Refrensi	89
H. Glosarium.....	92
 CHAPTER 5 GIZI REPRODUKSI REMAJA UNTUK PENCEGAHAN ANEMIA DAN KEHAMILAN USIA DINI.....	95
Bdn. Ade Rahayu Prihartini, S.ST., M.Kes.....	95
A. Pendahuluan/Prolog	95
B. Konsep Gizi Reproduksi Remaja Dalam Pendekatan Holistik.....	97
C. Hubungan Gizi Reproduksi Remaja Dengan Anemia Dan Kehamilan Usia Dini.....	99
D. Bukti Ilmiah Intervensi Gizi Reproduksi Remaja.....	101
E. Peran Profesi Kesehatan Dalam Gizi Reproduksi Remaja.....	104
F. Model Implementasi Gizi Reproduksi Remaja Di Indonesia	106

G. Etika, Budaya, Dan Hak Remaja Dalam Gizi Reproduksi	108
H. Rekomendasi Praktik Dan Kesimpulan Akhir Bab	111
I. Referensi.....	114

CHAPTER 6 KESEHATAN MENTAL DAN SEKSUALITAS DALAM TANTANGAN PELAYANAN HOLISTIK117

Fina Sancaya Rini, S,ST., M.Kes.....117

A. Pendahuluan/Prolog	117
B. Konsep Kesehatan Reproduksi Holistik dalam Kebidanan.....	119
C. Evolusi Konsep Kesehatan Reproduksi.....	119
D. Model Biopsikososial dalam Kesehatan Reproduksi.....	120
E. Kesehatan Mental dalam Pelayanan Kebidanan.....	121
F. Seksualitas dalam Perspektif Kebidanan Holistik	122
G. Tantangan Pelayanan Kesehatan Mental dan Seksualitas	122
H. Contoh Studi Kasus Kebidanan dan peran bidan dalam praktik komplementer.....	123
I. Simpulan.....	124
J. Referensi.....	125
K. Glosarium.....	125

CHAPTER 7 STRATEGI PROMOSI KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI MEDIA DIGITAL DAN EDUKASI KOMUNITAS127

Dr. Queen Khoirun Nisa' Mairo, SST.Bdn., M.Keb.....127

A. Pendahuluan/Prolog	127
B. Konsep Dasar Promosi Kesehatan Reproduksi Holistik	129
C. Landasan Teoretis Promosi Kesehatan Reproduksi	131
D. Media Digital sebagai Strategi Promosi Kesehatan Reproduksi.....	133
E. Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Komunitas	136
F. Integrasi Media Digital dan Edukasi Komunitas dalam Promosi Kesehatan Reproduksi.....	139
G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Promosi Kesehatan Reproduksi	141
H. Etika dan Tantangan Promosi Kesehatan Reproduksi di Era Digital	143
I. Monitoring dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan Reproduksi	146
J. Simpulan.....	149
K. Referensi.....	151
L. Glosarium.....	155

PROFIL PENULIS	157
-----------------------------	------------

CHAPTER 1

MANAJEMEN NUTRISI UNTUK KESEHATAN REPRODUKSI: PRA-KONSEPSI, KEHAMILAN, DAN PASCA MELAHIRKAN

Sitawati, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan Reproduksi merupakan bagian vital bagi lahirnya generasi baru yang akan menyumbang populasi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, keberlangsungan proses reproduksi manusia yang sehat sangat dibutuhkan agar dapat mendukung generasi yang sehat yang lahir dari Ibu yang sehat pula. Seorang perempuan yang akan menjalani siklus menjadi seorang ibu tentunya tidak hanya pada pemeliharaan kesehatan selama hamil saja, tetapi mulai dari masa prakonsepsi sampai memasuki masa setelah persalinan, kesehatannya juga harus dijaga dengan baik. Salah satu yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi selama masa tersebut adalah pemenuhan nutrisi yang cukup. Asupan zat gizi harus diperhatikan agar mencapai kematangan seksual untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Status gizi calon ibu pada masa sebelum terjadinya kehamilan merupakan periode penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, selain mengonsumsi makanan gizi seimbang untuk dapat meningkatkan kesuburan serta kesehatan ibu dan calon bayinya pada masa prakonsepsi mengonsumsi makanan yang mengandung berbagai multivitamin, termasuk ketika telah mengalami kehamilan, untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin yang sehat, karena gizi janin tergantung sepenuhnya kepada ibu, hingga masa setelah melahirkan, dimana nutrisi juga sangat berperan penting dalam produksi ASI.

Namun, masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan yang utama di negara berkembang termasuk Indonesia dan merupakan penyebab kematian ibu dan anak secara tidak langsung yang sebenarnya dapat dicegah. Potensi masalah gizi terbesar di Indonesia salah satunya adalah masalah gizi kehamilan, karena ibu hamil merupakan kelompok rawan maka dapat berpotensi akan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi. Salah satu masalah gizi yang sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita masa kehamilan adalah anemia. Menurut Global Anemia Estimates 2025, prevalensi anemia pada ibu hamil (usia 15–49 tahun) mencapai 35,5% pada tahun 2023. Tingkat anemia pada seluruh perempuan usia reproduktif adalah 30,7%. Hal ini menunjukkan bahwa anemia tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang serius. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023,

prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia mencapai 44%, angka ini masih di atas target eliminasi anemia yang dicanangkan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI, 2023).

Selain itu, ada juga masalah Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang didefinisikan sebagai keadaan ketika wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun. Anemia maupun KEK pada wanita usia subur (pra konsepsi) yang berlangsung secara terus menerus dan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan gangguan kesehatan reproduksi, seperti kesulitan untuk hamil, komplikasi kehamilan, seperti preeklamsia, anemia, infeksi, dan perdarahan pasca-persalinan, kelahiran prematur dan BBLR, mengganggu produksi ASI hingga hingga berperan dalam risiko terjadinya stunting pada anak. Prevalensi KEK pada kehamilan secara global World Health Organization (WHO) tahun 2022 menyatakan bahwa 35% sampai 75%. WHO juga mencatat 40% kematian ibu di negara berkembang berkaitan dengan KEK (WHO, 2023). Sedangkan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Prevalensi KEK pada ibu hamil sebesar 16,9% (Kemenkes RI, 2024).

Melihat masalah ini, maka salah satu langkah yang dapat diambil untuk mencegah gangguan kesehatan reproduksi adalah manajemen nutrisi yang tepat masa prakonsepsi, kehamilan dan masa setelah melahirkan. Manajemen nutrisi merupakan bagian dari pendekatan holistik dalam pemeliharaan kesehatan melalui proses merencanakan, mengelola, pemantauan dan pengendalian asupan nutrisi yang seimbang dan adekuat untuk mencapai kesehatan optimal dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Manajemen nutrisi yang benar, diharapkan akan menjaga kesehatan reproduksi agar dapat meningkatkan derajat kesehatan seorang perempuan dimasa mempersiapkan kehamilan, menjalani kehamilannya, dan dapat menjalani masa menyusui yang optimal, sehingga melahirkan generasi yang sehat.

B. Kesehatan Reproduksi dan Nutrisi

1. Pengertian Kesehatan Reproduksi

Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 71 ayat 1 menyatakan bahwa Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Menurut Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD), Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau

kelemahan, dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya (Wantini, dkk, 2021).

Kesehatan reproduksi holistik adalah pendekatan menyeluruh yang memandang kesehatan reproduksi bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional, mental, sosial, dan spiritual, serta lingkungan, untuk mencapai kesejahteraan utuh pada setiap fase kehidupan reproduktif. Manajemen nutrisi sebagai bagian dari kesehatan reproduksi holistik adalah pendekatan komprehensif yang menggunakan asupan makanan, zat gizi makro dan mikro, serta pola makan seimbang untuk mendukung fungsi organ reproduksi. Manajemen ini merupakan salah satu langkah dalam menjaga kesehatan reproduksi dari aspek fisik termasuk didalamnya adalah manajemen pemenuhan nutrisi pada masa pra konsepsi, kehamilan, dan pasca melahirkan, sebagian bagian dari ruang lingkup asuhan kesehatan reproduksi.

2. Pengertian Nutrisi (Gizi)

Gizi (Nutrition) adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh untuk menciptakan kesehatan yang optimal untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Zat gizi atau nutrients adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses tubuh (Mokodompit, 2025). Beberapa jenis zat gizi dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia, namun sebagian besar zat gizi lainnya harus diperoleh dari makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari.

3. Jenis Zat Gizi

Zat gizi utama dibagi menjadi dua kategori besar yaitu:

- a. Makronutrien atau zat gizi makro adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk energi dan fungsi utama tubuh, terdiri dari Karbohidrat, Protein, Lemak, yang memberi energi dan membangun tubuh.
- b. Mikronutrien atau zat gizi mikro adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil namun sangat penting untuk proses tubuh seperti pertumbuhan, kekebalan, dan metabolisme, terdiri dari Vitamin & Mineral, ditambah Air dan Serat sebagai komponen penting lainnya untuk hidrasi dan pencernaan.

Keduanya sama pentingnya; makro sebagai bahan bakar dan pembangun, mikro sebagai pengatur proses vital. Zat gizi mikro dan makro diperlukan untuk kesehatan tubuh, salah satunya untuk fungsi reproduksi pada semua daur

kehidupan. Defisiensi makro dan mikro nutrien telah dikaitkan dengan adanya risiko gangguan reproduksi (Saraswati, 2021).

Adapun zat gizi berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi 3 (Yuliani, dkk, 2025), meliputi:

a. Zat gizi sebagai sumber energi

Zat gizi yang tergolong kepada zat yang berfungsi mem berikan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Bahan pangan yang berfungsi sebagai sumber energi, antara lain nasi, jagung, dan talas. itu semua merupakan sumber karbohidrat. Margarin dan mentega merupakan sumber lemak. Ikan, daging, dan telur merupakan sumber protein. Ketiga zat gizi ini memberikan sum bangan energi bagi tubuh. Ketiga zat ini terdapat dalam jumlah paling banyak dalam bahan pangan. Namun, penyum bang energi terbesar dari ketiga unsur zat gizi tersebut adalah lemak. Dalam fungsinya sebagai zat pemberi energi, ketiga zat gizi tersebut dinamakan zat pembakar.

b. Zat gizi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh

Zat gizi ini memiliki fungsi sebagai pembentuk sel-sel pada jaringan tubuh manusia. Jika kekurangan mengkonsumsi zat ini maka pertumbuhan dan perkembangan manusia akan terhambat. Selain itu, zat gizi ini juga berfungsi untuk meng hasilkan sel-sel tubuh yang rusak dan memper tahan kan fungsi organ tubuh zat gizi yang termasuk dalam kelom pok ini adalah protein lemak vitamin dan mineral dan zat gizi yang paling memiliki sumber dominan dalam proses pertumbuhan adalah protein.

c. Zat gizi sebagai pengatur atau regulasi proses di dalam tubuh

Protein, mineral, air dan vitamin diperlukan untuk meng atur proses tubuh protein mengatur keseimbangan air di dalam sel, bertindak sebagai buffer dalam upaya meme lihara netra litas tubuh dan membentuk antibodi sebagai penangkal orga nisme yang bersifat infeksiif dan bahan-bahan asing yang dapat masuk ke dalam tubuh mineral dan vitamin diperlukan sebagai pengatur dalam proses proses oksidasi fungsi normal saraf dan otot serta banyak proses lain yang terjadi di dalam tubuh termasuk proses penuaan titik air diperlukan untuk melarutkan bahan-bahan di da lam tubuh seperti di dalam darah cairan pencernaan, ja ring an dan mengatur suhu tubuh serta peredaran darah pembuangan sisa-sisa atau ekskresi dan lain-lain di dalam proses tubuh dalam fungsi mengatur proses tubuh ini protein mineral air dan vitamin dinamakan sebagai zat pengatur.

4. Gizi Seimbang

Berdasarkan pedoman pemenuhan gizi dari Kemenkes, dianjurkan setiap kelompok umur untuk menerapkan pola gizi seimbang dengan tiga prinsip utama. Pertama, gizi seimbang adalah pola makan yang mengandung semua zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, serat) melalui konsumsi makanan dengan beraneka ragam, dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh. Kedua, didukung oleh pola hidup aktif seperti aktivitas fisik teratur, olahraga, untuk menyeimbangkan keluar dan masuknya zat gizi, terutama sumber energi utama dalam tubuh, memperlancar sistem metabolisme tubuh, tak terkecuali metabolisme zat gizi. Ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), yang dapat menghindarkan dari penyakit infeksi. Bahkan 45% penyakit diare bisa dicegah dengan mencuci tangan.

Nutrisi memegang peranan krusial dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan wanita dalam setiap tahap hidup mereka. Wanita memiliki kebutuhan gizi yang unik, yang berbeda dari pria, terutama pada beberapa tahap penting seperti pada masa kehamilan, menyusui, hingga memasuki masa menopause. Inilah mengapa nutrisi menjadi faktor utama dalam memastikan kualitas hidup mereka. Asupan nutrisi yang adekuat sangat berperan dalam meningkatkan fungsi reproduksi sehingga dapat menunjang fertilitas, kehamilan, dan pasca persalinan (Astuti, 2023).

C. Manajemen Nutrisi pada Masa Prakonsepsi

1. Pengertian Prakonsepsi

Prakonsepsi adalah masa sebelum terjadinya kehamilan atau masa sebelum bertemunya sel telur pada perempuan dan sel sperma pada laki-laki. Masa prakonsepsi sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan kesehatan reproduksi seorang wanita. Masa prakonsepsi wanita berkaitan dengan wanita usia subur (WUS) yang akan atau telah menjalani pernikahan yang dikategorikan sebagai Pasangan usia subur (PUS) yang siap menjadi seorang ibu. WUS adalah wanita yang berada dalam peralihan masa remaja akhir hingga usia dewasa awal. Karakteristik WUS yang paling utama adalah ditandai dengan peristiwa fisiologis, seperti menstruasi dan tercapainya puncak kesuburan dengan fungsi organ reproduksi yang sudah berkembang dengan baik (Astuti, dkk, 2024 ; Yani, dkk, 2024).

Periode prakonsepsi adalah rentang waktu dari tiga bulan hingga satu tahun sebelum konsepsi dan idealnya harus mencakup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Periode ini sangat penting dalam menjalani persiapan dan perencanaan kehamilan sebagai upaya dalam

meningkatkan kesehatan reproduksi untuk mewujudkan kehamilan yang sehat dan mencegah kehamilan resiko tinggi, komplikasi pada masa kehamilan, bersalin dan nifas yang meningkatkan resiko kesakitan dan kematian bagi ibu dan anak. Sebagian besar komplikasi kehamilan ini dapat dicegah dengan melakukan persiapan pra konsepsi (Hidayah, dkk, 2022; Sulastri, dkk, 2022).

2. Pemenuhan Nutrisi Masa Prakonsepsi

Masa prakonsepsi merupakan periode vital dalam mempersiapkan kehamilan dan menyusui yang optimal. Sehingga selama masa prakonsepsi disarankan agar calon ibu dapat menjaga pola hidup sehat serta pemenuhan kecukupan gizi. Gizi yang baik menunjang fungsi alat-alat reproduksi menjadi optimal seperti proses produksi sel telur, pematangan sel telur hingga proses pembuahan yang sempurna untuk menunjang kesuburan wanita. Jika terjadi kehamilan, berperan penting dalam penyediaan cadangan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, sampai menunjang keberhasilan masa produksi ASI pasca melahirkan. Sehingga ini menunjukkan bahwa pemenuhan nutrisi masa prakonsepsi menjadi kunci kesehatan Ibu serta kelahiran bayi normal dan sehat.

Pesan khusus gizi seimbang yang perlu diperhatikan dalam persiapan prakonsepsi wanita adalah mengonsumsi aneka ragam makanan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Hal tersebut meliputi konsumsi zat gizi makro dan mikro (karbohidrat, protein, vitamin dan mineral) yang akan digunakan sebagai proses pertumbuhan tubuh yang cepat, peningkatan volume darah dan peningkatan hemoglobin dalam darah yang berguna untuk mencegah anemia yang disebabkan karena kehilangan zat besi selama proses menstruasi (Kemenkes, 2014; Wantini, 2021).

Masalah gizi di periode prakonsepsi yang dapat mengganggu kesuburan adalah obesitas, gizi kurang dan kekurangan zat besi. Calon ibu yang mengalami obesitas beresiko mengalami komplikasi kehamilan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, IUFD, kelainan kongenital pada bayi. Adapun untuk menghindari obesitas calon ibu harus menjaga berat badan dengan pola makan yang sehat dan bergizi agar tetap ideal. Sedangkan calon ibu yang mengalami gizi kurang beresiko mengalami abortus, melahirkan bayi premature, berat badan lahir rendah, IUFD, cacat bawaan. Masalah kekurangan gizi yang sering dialami wanita prakonsepsi adalah anemia dan Kurang Energi Kronik (KEK), yang dapat meningkatkan risiko komplikasi serius saat kehamilan. Anemia masa prakonsepsi adalah kondisi kekurangan sel darah merah pada wanita usia subur sebelum hamil, yang sering disebabkan defisiensi zat besi/asam folat, status gizi buruk, termasuk KEK. Sedangkan KEK merupakan kondisi gizi buruk jangka panjang pada

wanita usia subur (WUS) yang ditandai dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA) < 23,5 cm Penyebab langsung masalah KEK adalah pola konsumsi yang tidak adekuat, dimana jumlah konsumsi makanan tidak sesuai dengan pola gizi seimbang dan kebutuhan gizi individu (Meyana, 2023; Fandir, dkk, 2024).

Mendorong nutrisi yang baik, diet yang memadai yang menyediakan semua mikronutrien dan makronutrien esensial dalam jumlah dan proporsi yang tepat, akan membantu memastikan kesehatan yang optimal bagi wanita, dan akan membekali dalam persiapan menjalani kehamilan.

Berikut merupakan anjuran Angka Kecukupan Gizi bagi WUS yang telah ditetapkan Kemenkes No 28 Tahun 2019 (Kemenkes, 2025):

Tabel 1.1 Anjuran Angka Kecukupan Gizi bagi WUS (Kemenkes, 2025)

Zat Gizi	WUS (tahun)	
	19-29	30-49
Energi (kkal)	2250	2150
Protein (g)	60	60
Lemak (g)	65	60
Karbohidrat (g)	360	340
Serat (g)	32	30
Air (mL)	2350	2350
Vitamin A (RE)	600	600
Vitamin D (µg)	15	15
Vitamin E (mg)	15	15
Vitamin K (µg)	55	55
Vitamin B1 (mg)	1.1	1.1
Vitamin B2 (mg)	1.1	1.1
Vitamin B3 (mg)	1.4	1.4
Vitamin B5 (mg)	5.0	5.0
Vitamin B6 (mg)	1.3	1.3
Asam folat (µg)	400	400
Vitamin B12 (µg)	4.0	4.0
Biotin (µg)	30	30
Kolin (mg)	425	425
Vitamin C (Mg)	75	75
Kalsium (mg)	1000	1000
Fosfor (mg)	700	700
Magnesium (mg)	330	330
Besi (mg)	18	18
Yodium (µg)	150	150
Seng (mg)	8	8
Selenium (µg)	24	24
Mangan (mg)	1.8	1.8
Fluor (mg)	3.0	3.0
Kromium (mg)	30	29
Kalium (mg)	4700	4700
Natrium (mg)	1500	1500
Klor (mg)	2250	2250
Tembaga (µg)	900	900

Tindakan pencegahan kekurangan gizi pada calon ibu masa prakonsepsi yaitu dengan meningkatkan konsumsi asupan makanan yang bergizi seimbang dan dengan porsi yang sesuai dengan berpedoman pada program kesehatan “Isi Piringku”. Program “Isi Piringku” merupakan pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan mengampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Dalam satu piring setiap kali makan, setengah piring diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk, sedangkan setengah lainnya diisi dengan sayur dan buah.

Berikut Pembagian dari satu porsi “Isi Piringku” berdasarkan pedoman dari Dinas Kesehatan tahun 2014:



Gambar 1.1 Poster Program “Isi Piringku” (Kemenkes, 2014)

- a. Makanan Pokok, merupakan pangan yang menjadi sumber Karbohidrat, yang sangat penting untuk menyiapkan tubuh agar sehat saat hamil, yaitu sebagai sumber energi utama agar tidak mudah lelah. Sumber karbohidrat seperti: nasi, ubi, singkong, kentang, beras merah, gandum, jagung, sagu, talas, dan produk olahan (seperti roti, pasta, mie, dll).
- b. Lauk Pauk, yang terdiri dari pangan sumber protein hewani dan protein nabati yang sangat penting untuk membangun cadangan nutrisi untuk kehamilan, memperbaiki sel dan jaringan tubuh, meningkatkan jumlah darah dan mendukung pertumbuhan jaringan rahim serta payudara yang akan berkembang saat hamil, memperkuat sistem imun, serta mendukung

pembentukan sel dan organ vital janin saat kehamilan yang krusial untuk mencegah stunting dan memastikan pertumbuhan optimal, Protein hewani bisa bersumber dari: daging kambing, sapi, ayam, bebek, ikan, termasuk hasil laut lainnya, telur dan susu. Sedangkan protein nabati, bisa bersumber dari: Tahu, tempe, kacang-kacangan.

- c. Buah-buahan, yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat pangan yang penting untuk melindungi sel reproduksi dari kerusakan, mengatur ovulasi, dan mempersiapkan rahim, mencegah cacat lahir. Buah-buahan seperti alpukat, jeruk, dan pepaya adalah sumber asam folat (vitamin B9) yang penting untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin sejak awal pembuahan. Alpukat kaya akan lemak baik dan vitamin K yang membantu menyeimbangkan hormon dan meningkatkan ketebalan dinding rahim. Kandungan vitamin C dalam buah membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan lain, yang penting untuk mencegah anemia pada calon ibu.
- b. Sayur-sayuran, merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat pangan seperti halnya dengan buah. Sayur sangat bermanfaat karena kaya asam folat, zat besi, antioksidan, serta serat yang membantu meningkatkan kesuburan, mencegah anemia, mendukung perkembangan awal janin (seperti tabung saraf), melancarkan pencernaan, dan mengatur tekanan darah, memastikan kondisi tubuh optimal untuk kehamilan dan mencegah risiko komplikasi dini.
- c. Selain itu, Isi Piringku juga memuat ajakan untuk mengonsumsi 8 gelas air setiap hari, melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari, dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan setelah makan, dan anjuran membatasi gula, garam, dan lemak, untuk mencegah penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, dengan anjuran harian (G4-G1-L5): Gula maksimal 4 sendok makan (50 gram), Garam maksimal 1 sendok teh (5 gram atau 2000 mg natrium), dan Lemak maksimal 5 sendok makan (67 gram) per orang per hari (Darmawanti, 2022).

Anjuran porsi makan dan minum menurut kecukupan energi WUS untuk konsumsi satu hari dan Contoh jenis dan takaran makanan dalam 1 porsi (Kemenkes RI, 2025)

Nasi atau Makanan Pokok	5 porsi 	1 porsi = 100 g atau ¼ gelas nasi 1 porsi = 125 g atau 3 buah jagung ukuran sedang 1 porsi = 210 g atau 2 kentang ukuran sedang 1 porsi = 120 g atau 1 ½ potong singkong 1 porsi = 70 g atau 3 iris roti putih 1 porsi = 200 g atau 2 gelas mie basah
Protein hewani seperti: ikan, telur, ayam, dan lainnya	3 porsi 	1 porsi = 50 g atau 1 potong sedang ikan 1 porsi = 55 g atau 1 butir telur ayam
Protein nabati seperti: tahu, tempe, dan lainnya	3 porsi 	1 porsi = 50 g atau 1 potong sedang tempe 1 porsi = 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur - sayuran	3 porsi 	1 porsi = 100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah - buahan	5 porsi 	1 porsi = 100 g atau 1 potong sedang pisang 1 porsi = 100 – 190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak / lemak	5 porsi Minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis, atau dimasak dengan santan	1 porsi = 5 g atau 1 sendok teh bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng menumis, santan, kemiri, mentega dan sumber lemak lainnya
Gula	2 porsi 	1 porsi = 10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue manis, teh manis dan lain-lainnya Gula dapat digunakan untuk pengolahan makanan/minuman

Gambar 1.2 Anjuran porsi makan dan minum menurut kecukupan energi WUS (Kemenkes, 2025)

D. Manajemen Nutrisi Masa Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Kehamilan merupakan kondisi terjadinya pembuahan atau fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa yang berasal dari laki-laki dan ovum atau sel telur dari perempuan, yang kemudian mengalami dan implantasi pada dinding rahim. Proses ini menandakan bahwa didalam rahim wanita sedang bertumbuh dan berkembang calon individu baru yaitu janin (Nurhayati dkk, 2023). Kehamilan adalah proses mata rantai yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, sampai pada pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai mencapai masa aterm (cukup bulan). Kehamilan merupakan suatu poses alami yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin,

lamanya kehamilan normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) di hitung dari hari pertama haid terakhir. Berlangsungnya masa kehamilan terbagi dalam 3 trimester. Trimester pertama berlangsung dalam 12 minggu, masuk trimester kedua di minggu ke-13 hingga ke-27 dan trimester tiga di minggu ke-28 hingga ke-40 (Elifiya, 2022).

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Gizi Pada Ibu Hamil

a. Pengetahuan

Pengetahuan tentang nutrisi merupakan elemen penting untuk memastikan hasil dari pemeliharaan kesehatan selama kehamilan dan merupakan bagian integral untuk mencapai perilaku diet sehat. Pengetahuan yang baik tentang pemenuhan nutrisi kehamilan, misal mengapa makanan bergizi penting (energi, pertumbuhan janin sempurna), akan memproses informasi dan menghasilkan keputusan dalam menentukan pola konsumsi makanan dan perilaku makan yang lebih baik (Maslikhah, dkk 2023)

b. Sikap

Sikap ibu hamil yang memengaruhi pemenuhan gizi meliputi persepsi dan keyakinan pribadi tentang makanan bergizi, prasangka buruk (tabu/mitos: misalnya, "makan banyak bikin bayi besar", "ibu hamil tidak boleh makan ikan" sangat memengaruhi pilihan makanan), kepercayaan diri, kecenderungan perilaku makan, serta sikap terhadap konsumsi suplemen (tablet Fe, vitamin), di mana sikap positif (percaya akan manfaat gizi) mendorong perilaku baik, sementara sikap negatif (tidak peduli, percaya mitos) bisa menghambat pemenuhan nutrisi meski pengetahuan sudah baik.

c. Status Ekonomi

Status ekonomi mempengaruhi pemenuhan gizi ibu hamil terutama melalui kemampuan membeli makanan bergizi (protein, sayur, buah), yang berdampak pada kualitas dan kuantitas asupan nutrisi. Pendapatan yang terbatas secara langsung menurunkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang meningkat selama kehamilan, yang cenderung menghasilkan pola makan yang kurang beragam, dominan karbohidrat, dan kurang protein, lemak, vitamin, dan mineral (Diantara, dkk, 2026).

d. Tingkat Pendidikan

Ibu yang berpendidikan, lebih mudah memahami pentingnya nutrisi, jenis makanan bergizi, porsi yang dibutuhkan, dan cara pengolahan yang benar, serta memfasilitasi penerimaan informasi gizi dari berbagai sumber, seperti tenaga kesehatan, yang membantu pembentukan pengetahuan dan sikap positif.

3. Komplikasi Kehamilan Karena Kekurangan Gizi

Komplikasi selama kehamilan merupakan masalah yang dapat mempengaruhi Morbiditas dan mortalitas pada Ibu dan Anak, sehingga untuk mencegah terjadinya komplikasi diperlukan pemenuhan nutrisi seimbang dan adekuat selama kehamilan. Ibu hamil dengan masalah kekurangan gizi seperti anemia dan KEK, berisiko mengalami komplikasi kehamilan seperti:

- a. Abortus, atau yang lebih sering disebut sebagai keguguran, merupakan berakhirnya kehamilan secara tiba-tiba sebelum janin mampu hidup di luar kandungan, biasanya sebelum usia kehamilan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram.
- b. Melahirkan bayi premature, yaitu kondisi bayi yang lahir terlalu dini, yaitu sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu. Saat kelahirannya, organ-organ tubuh bayi belum berkembang sempurna sehingga berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan. Semakin dini bayi lahir, semakin besar risiko komplikasi, seperti kesulitan bernapas, menyusui, atau masalah perkembangan jangka panjang.
- c. Berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu kondisi bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram (2,5 kg), sehingga lebih rentan menderita penyakit atau infeksi. Bayi dengan kondisi ini juga bisa tidak cukup kuat untuk menyusui dan mudah kedinginan karena belum memiliki lemak tubuh yang cukup.
- d. IUFD (Intrauterine Fetal Death), yaitu kondisi kematian janin di dalam kandungan pada usia kehamilan 20 minggu atau lebih, sebelum persalinan dimulai atau selama proses persalinan, sehingga bayi lahir tanpa tanda-tanda kehidupan seperti detak jantung, gerakan, atau bernapas.
- e. Cacat bawaan pada janin, atau kelainan kongenital, adalah kondisi abnormalitas struktur atau fungsi tubuh yang terjadi sejak lahir atau selama perkembangan janin di dalam kandungan, memengaruhi berbagai bagian seperti jantung, otak, tulang, atau organ lain. Kelainan yang terjadi, seperti: Bibir sumbing, kelainan jantung bawaan, kaki pengkor (club foot), atau spina bifida (gangguan tulang belakang), Sindrom Down, gangguan metabolisme (seperti hipotiroid), dll.
- f. Risiko jangka panjang pada anak, seperti terjadinya stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis (jangka panjang) dan infeksi berulang, ditandai dengan tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya, yang berdampak buruk pada perkembangan fisik dan kognitif anak serta meningkatkan risiko penyakit di masa depan. Kondisi ini terjadi sejak

dalam kandungan hingga usia 2 tahun (1000 Hari Pertama Kehidupan) (Lestari, 2023).

4. Pemenuhan Nutrisi Masa Kehamilan

a. Jenis Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil Dan Manfaatnya (Kemkes, 2022)

Selain zat gizi makro seperti karbohidrat, protein dan lemak, ibu hamil juga membutuhkan zat gizi mikro, seperti vitamin dan suplemen. Berikut adalah zat gizi penting yang harus ada dalam makanan Ibu hamil untuk memastikan kesehatan ibu dan janin dalam kandungannya.

1) Karbohidrat

Karbohidrat memegang peranan penting karena merupakan sumber energi utama. Tubuh ibu hamil memerlukan cukup persediaan energi setiap menit untuk pertumbuhan janin dan untuk membentuk sel tubuh oleh protein. Ibu hamil membutuhkan sekitar 300-400 gram karbohidrat per hari (sekitar 45-65% dari total kalori harian) untuk energi janin dan ibu, dengan kebutuhan meningkat di trimester kedua dan ketiga (tambah 300-450 kalori ekstra). Sumber karbohidrat seperti: nasi, ubi, singkong, kentang, beras merah, gandum, jagung, sagu.

2) Protein

Protein merupakan nutrisi penting yang harus dipenuhi selama kehamilan untuk memastikan pertumbuhan yang baik dari jaringan dan organ bayi, termasuk otak. Nutrisi ini membantu pertumbuhan jaringan payudara dan rahim ibu selama kehamilan, berperan dalam meningkatkan suplai darah ibu, sehingga memungkinkan untuk mengirimkan lebih banyak darah ke bayi. Kebutuhan protein ibu meningkat di tiap trimesternya. Ibu hamil perlu mengonsumsi sekitar 70 hingga 100 gram protein setiap hari, tergantung pada berat badan dan trimester kehamilan ibu. Sumber protein yang baik untuk ibu hamil meliputi daging sapi tanpa lemak, ayam, telur, ikan salmon, kacang-kacangan, selai kacang, kacang polong, dan keju cottage. Pastikan ikan dan telur sampai benar-benar masak, dan tidak dimakan mentah-mentah.

3) Lemak

Lemak sehat, seperti asam lemak omega 3 dan DHA (asam dokosaheksaenoat), mendukung perkembangan mata dan otak janin yang sehat. Asupan lemak total harus terdiri dari 20-35% kalori harian, meningkat sebanyak sekitar 2 g/hari dibandingkan dengan perempuan yang tidak hamil. Lemak yang sehat bisa didapat dari alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian dan ikan kaya lemak, seperti salmon, sarden, dan ikan tuna.

4) Zat Besi

Zat besi sangat dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah, karena meningkatnya volume darah yang dibutuhkan selama kehamilan untuk membuat lebih banyak darah untuk memasok oksigen ke bayi. Ibu membutuhkan asupan zat besi dua kali lipat dari yang dibutuhkan wanita tidak hamil, yaitu sekitar 27 miligram zat besi sehari. Kekurangan zat besi, akan menyebabkan ibu mengalami anemia defisiensi besi yang dapat menyebabkan ibu menjadi mudah lelah, meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, serta depresi pasca melahirkan. Asupan zat besi bisa didapatkan dari daging merah tanpa lemak, ikan, sayuran dan kacang-kacangan, serta suplemen tablet tambah darah (TTD). Zat besi dapat diperoleh dari makanan, seperti daging merah tanpa lemak, dan ikan, sereal, kacang-kacangan, dan sayuran.

5) Vitamin

Selama kehamilan ibu hamil membutuhkan asupan vitamin, terutama vitamin B dan D. Vitamin B, termasuk B1, B2, B6, B9, dan B12 dibutuhkan untuk memberi energi dan mengoptimalkan kondisi plasenta. Sedangkan vitamin D, terutama D3, dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tulang dan gigi janin yang kuat. Ibu hamil membutuhkan asupan vitamin D sebanyak 600 unit internasional (IU) per hari. Sumber vitamin D yang baik bisa didapatkan dari Ikan berlemak seperti salmon, susu dan jus jeruk dan termasuk sumber lain berasal dari paparan langsung sinar matahari pagi. Sedangkan untuk Vitamin B banyak terdapat dalam daging ayam, pisang, kacang-kacangan, gandum utuh dan roti. Vitamin A sangat penting untuk pembelahan dan perkembangan sel, perkembangan tulang belakang, jantung, mata, dan telinga. Anak dari ibu yang mengalami kekurangan vitamin A, memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, yang mungkin terkait dengan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Meskipun sebagian besar zat gizi mikro memiliki ambang batas toleransi yang tinggi untuk dikonsumsi, vitamin A merupakan salah satu pengecualian. Konsumsi vitamin A (dalam bentuk retinol, bukan karoten seperti yang secara alami terkandung dalam wortel) yang berlebihan (>10.000 IU atau 3.000 RE/hari), misalnya dari suplemen, dapat memberikan efek teratogenik, seperti cacat jantung, langit-langit dan rongga mulut. Secara alami, Vitamin A dapat dijumpai pada sayur dan buah berwarna hijau tua atau oranye, seperti wortel, ubi jalar, bayam, brokoli; serta dari sumber pangan hewani seperti hati ayam, telur, dan ikan. Di samping itu, asupan protein yang cukup juga dibutuhkan

untuk mendukung proses pengangkutan/transportasi vitamin A dalam darah ke organ atau jaringan tubuh yang membutuhkan.

6) Folat dan Asam Folat

Folat adalah bentuk alami dari vitamin B yang berperan penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada bayi, yaitu kelainan serius pada otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan asam folat merupakan bentuk sintetis folat yang dapat ditemukan dalam suplemen dan makanan yang bergizi. Asam folat dibutuhkan untuk pertumbuhan sel-sel tubuh dan organ pada janin, serta membantu ibu hamil mengontrol tekanan darah. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin dan gangguan kehamilan, seperti preeklamsia atau komplikasi kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) merekomendasikan ibu hamil mengkonsumsi 600-800 mcg (mikrogram folat) asam folat selama kehamilan. Ibu bisa mendapatkan asupan folat dari makanan, seperti hati, kacang-kacangan, telur, sayuran berdaun hijau tua, serta kacang polong.

7) Kalsium

Kalsium dibutuhkan dalam pembentukan tulang dan gigi janin, serta menjaga kesehatan tulang ibu hamil. Kalsium juga membantu sistem peredaran darah, otot, dan saraf ibu berjalan dengan normal dan membantu menurunkan risiko gangguan kehamilan, seperti hipertensi dan kelahiran prematur. Asupan kalsium bisa didapat dari sumber protein hewani seperti susu, produk susu (yoghurt, keju), ikan, tahu dan sayuran berwarna hijau tua. Ibu hamil membutuhkan sekitar 1000 mg kalsium per hari yang bisa dibagi dalam dua dosis 500 miligram per hari. Sumber kalsium yang baik bisa ditemukan pada susu, yoghurt, keju, ikan dan seafood yang rendah merkuri, seperti salmon, udang, dan ikan lele, tahu yang mengandung kalsium dan sayuran berdaun hijau tua. WHO merekomendasikan suplementasi Kalsium selama hamil pada populasi yang konsumsi Kalsiumnya rendah, sebesar 1.5 g-2 g per hari dibagi dalam 3 dosis (3 x 500 mg), yang dimulai pada kehamilan usia 20 minggu. Sumber utama Kalsium dalam makanan adalah adalah susu, sereal dan sayur.

8) Probiotik dan Prebiotik

Probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Salah satu mekanisme dari probiotik adalah mampu menekan atau menghambat pertumbuhan dari bakteri jahat dari dalam saluran pencernaan, khususnya

usus besar, jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Probiotik dan prebiotik dinyatakan mampu mengurangi gejala berbagai penyakit seperti diare, infeksi usus, mencegah dan mengobati eksim, flu, perlemakan hati, dan menurunkan gejala kolik pada bayi (berkurangnya crying time). Probiotik dapat ditambahkan pada produk pangan yang diproses dengan fermentasi seperti yoghurt dan dapat juga ditambahkan pada produk susu, dan produk lain dalam bentuk serbuk, cairan, maupun kapsul/tablet. Prebiotik adalah makanan yang tidak dapat tercerna oleh saluran pencernaan manusia namun bermanfaat untuk menstimulasi pertumbuhan atau aktivitas bakteri baik/probiotik. Adapun prebiotik umumnya didapatkan dari gandum utuh, kedelai, pisang, bawang merah, bombay, bawang putih, dan madu

Itulah nutrisi penting untuk ibu hamil. Selain dengan mengonsumsi makanan sehat, ibu juga bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dengan minum suplemen kehamilan

b. Pemantauan status gizi Ibu hamil

Secara normalnya, Ibu hamil akan mengalami penambahan Berat Badan (BB) karena adanya pertumbuhan dan perkembangan dari Janin, Plasenta, cairan amnion. Pemantauan Berat Badan selama Hamil merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan kondisi status gizi Ibu dan terpenuhinya asupan makanan bagi janin. Penambahan Berat Badan selama Hamil yang optimal sesuai dengan status gizi Ibu dapat diukur dengan Indeks Massa Tubuh (IMT). Pertambahan Berat Badan selama Kehamilan yang direkomendasikan sesuai IMT Sebelum Hamil adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Status Gizi Ibu Hamil berdasarkan IMT (Kemenkes, 2025)

IMT Sebelum Hamil	Pertambahan BB pada Trimester 1	Pertambahan BB per minggu pada Trimester 2 & 3	Pertambahan BB Total pada Kehamilan Tunggal	Pertambahan BB Total pada Kehamilan Ganda
Kurus ($<18.5 \text{ Kg/m}^2$)	1-3 Kg	0.5 Kg	12.5-18 Kg	
Normal ($18.5 - 24.9 \text{ Kg/m}^2$)	1-3 Kg	0.4 Kg	11.5-16 Kg	17-24 Kg

Gemuk (25.0 – 29.9 Kg/m ²)	1-3 Kg	0.3 Kg	7-11.5 Kg	14-23 Kg
Obesitas (>30.0 Kg/m ²)	0.2-2 Kg	0.2 Kg	5-9 Kg	11-19 Kg

Tabel 1.2 *Status Gizi Ibu Hamil berdasarkan IMT* (Kemenkes, 2025)

Rumus untuk menghitung IMT Ibu hamil:

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (Kg)}}{\text{Tinggi Badan (m)} \times \text{Tinggi Badan (m)}}$$

Dengan mengukur berat dan tinggi badan sebelum hamil atau di awal kehamilan (trimester pertama), lalu gunakan hasilnya untuk menentukan target kenaikan berat badan yang sehat selama kehamilan agar status gizi tetap ideal.

Contoh:

Jika berat badan sebelum hamil adalah 60 kg dan tinggi badan 1,6 m:

$$IMT = \frac{60 \text{ Kg}}{1,6 \text{ m} \times 1,6 \text{ m}} = \frac{60 \text{ Kg}}{2,56} = 23,4$$

(sesuaikan dengan kategori IMT pada tabel.2)

Berarti IMT sebelum hamil berada dalam kategori Normal Weight atau Berat Badan Normal, dengan total kenaikan BB selama hamil yang harus dicapai adalah 11,5-16,0 dengan rata-rata kenaikan BB di trimester 2 & 3 (Kg/Minggu) adalah 0,35-0,50.

Selain berdasarkan IMT, status gizi Ibu Hamil juga dapat digambarkan melalui Lingkar Lengan Atas (LiLA). Ukuran LiLA <23,5 cm mengindikasikan bahwa Ibu Hamil berisiko mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) sehingga perlu mendapatkan perhatian terkait dengan asupan selama kehamilan. Peningkatan LiLA tidak sepeka peningkatan berat badan dalam menggambarkan perbaikan status gizi Ibu Hamil, yaitu hanya sekitar berkurang atau bertambah sebesar 1 cm selama kehamilan, sehingga perubahan LiLA tidak dapat menjadi cara pengukuran yang baik untuk proses monitoring status gizi Ibu Hamil.

c. Pedoman Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil

Untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi selama masa hamil, diperlukan zat gizi dalam jumlah yang lebih besar dari pada sebelum hamil. Sama halnya pada masa prakonsepsi, kekurangan gizi juga menjadi masalah utama pada ibu hamil seperti Anemia dan KEK, sebagai dampak lanjutan dari

kondisi gangguan kesehatan khususnya kekurangan gizi di periode prakonsepsi yang tidak tertangani dengan maksimal atau pemenuhan nutrisi yang tidak adekuat ketika memasuki masa kehamilan.

Berikut adalah pedoman gizi seimbang bagi Ibu hamil (Kemenkes 2021 dan KIA 2024):

- 1) Selama hamil, sangat dianjurkan untuk makan 3 kali makanan utama ditambah dengan 1-2 kali makanan kudapan dalam sehari sesuai dengan anjuran porsi makan. Dianjurkan gunakan visualisasi “Isi Piringku” seperti pada (gambar 1), agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai zat gizi tambahan zat gizi makro dan mikro melalui keragaman pangan yaitu: Isi separuh bagian piring makan anda dengan makanan pokok dan lauk pauk, lebih banyak makanan pokoknya; dan isi separuh piring lainnya dengan buah dan sayur, lebih banyak sayurinya. Berikut Komposisi porsi makan Ibu hamil untuk kebutuhan sehari beserta contoh jenis makanan yang bisa diberikan:

Ibu Hamil Trimester 1	Ibu Hamil Trimester 2 dan 3	Contoh
5 porsi 	6 porsi 	1 porsi = 100 g atau ¾ gelas nasi 1 porsi = 125 g atau 3 buah jagung ukuran sedang 1 porsi = 210 g atau 2 kentang ukuran sedang 1 porsi = 120 g atau 1 ½ potong singkong 1 porsi = 70 g atau 3 iris roti putih 1 porsi = 200 g atau 2 gelas mie basah
4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 50 g atau 1 potong sedang ikan 1 porsi = 55 g atau 1 butir telur ayam
4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 50 g atau 1 potong sedang tempe 1 porsi = 100 g atau 2 potong sedang tahu
4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 100 g atau 1 potong sedang pisang 1 porsi = 100 – 190 g atau 1 potong besar pepaya
5 porsi Minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis, atau dimasak dengan santan	5 porsi Minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis, atau dimasak dengan santan	1 porsi = 5 g atau 1 sendok teh bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng menumis, santan, kemiri, mentega dan sumber lemak lainnya
2 porsi 	2 porsi 	1 porsi = 10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue manis, teh manis dan lain-lainnya Gula dapat digunakan untuk pengolahan makanan/minuman

Gambar 1.3 Contoh Komposisi porsi makan Ibu hamil untuk kebutuhan sehari (Kemenkes, 2025)

- 2) Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) atau suplementasi mikronutrien lainnya selama masa hamil sesuai dengan kebijakan baru (bila ada). TTD penting dikonsumsi guna meningkatkan produksi sel darah merah selama kehamilan. Anjuran Praktis Mengonsumsi TTD:
 - a) Konsumsi TTD dilakukan setelah makan malam sebelum tidur agar efek sampingnya tidak terasa.
 - b) Konsumsi TTD bersama dengan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C atau sumber protein hewani yaitu daging, ikan dan unggas (meat, fish and poultry/MFP) untuk meningkatkan penyerapan zat besi.
 - c) Jangan diminum dengan teh atau kopi atau susu karena akan menghambat penyerapan zat besi.
 - d) Jika dengan mengonsumsi TTD, tinja menjadi hitam, tidak perlu khawatir karena tidak membahayakan karena warna hitam disebabkan sisa zat besi yang tidak diserap dan dikeluarkan melalui feses. Selain itu, beberapa efek samping ini makin lama makin ringan.
 - e) Rutin menandai Kotak Kontrol Minum TTD pada Ibu Hamil pada Buku KIA setiap hari untuk membantu mengingat atau meningkatkan kedisiplinan konsumsi TTD.
- 3) Cukup minum air putih

Seiring dengan peningkatan volume darah Ibu, kebutuhan asupan air minum ibu hamil meningkat menjadi 2-3 liter atau setara dengan 8 – 12 gelas air putih sehari, juga untuk mendukung produksi cairan amnion (ketuban).
- 4) Konsumsi garam beriodium untuk: Menghindari gangguan pertumbuhan, perkembangan pada janin yang dikandungnya, serta menghindari gondok pada Ibu Hamil
- 5) Pada kondisi tertentu seperti mual pada trimester pertama (hiperemesis gravidarum) dan mudah kenyang pada trimester terakhir, maka konsumsilah makanan dalam porsi kecil tapi sering. Buah dan sayur harus masuk ke dalam menu sehari-hari.
- 6) Konsumsi makanan tambahan baik lokal maupun pabrikan Ibu hamil secara umum memerlukan energi tambahan sebesar 300 kalori karena perubahan fisik yang terjadi selama proses kehamilan dan pertumbuhan janinnya. Oleh karena itu, dianjurkan menambah 1 – 2 porsi kudapan mengandung kira-kira 300 kalori energi, yang terdapat di daerahnya. Misalnya: 2 buah pisang kepek rebus ukuran sedang bersama dengan tiga potong getuk lindri dengan kelapa parut, segelas susu, atau semangkuk bubur kacang hijau

dengan santan. Khusus untuk Ibu Hamil KEK, sebagai tambahan atas makanan sehari-hari yang dikonsumsi, pada trimester 1 konsumsilah 2 keping biskuit MT (Makanan Tambahan). Ibu Hamil sebanyak 2 keping per hari, sedangkan pada trimester 2 dan 3 sebanyak 3 keping per hari. MT Ibu Hamil dapat diperoleh di Puskesmas, Posyandu, Polindes, Kunjungan Rumah, hingga Posko Bencana.

- 7) Menghindari dari batasi beberapa bahan makan dan minuman berikut:
 - a) Batasi konsumsi kopi atau minuman berkafein lainnya. Konsumsi minuman mengandung kafein, seperti teh dan kopi pada ibu hamil dapat memberikan efek diuretik (sering buang air kecil), sehingga jika dikonsumsi berlebihan, dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil, meningkatkan risiko dehidrasi, tekanan darah, dan denyut jantung. Selain itu, kafein juga merupakan salah satu penghambat penyerapan beberapa zat gizi tertentu, salah satunya zat besi. Dengan demikian, ibu hamil dianjurkan untuk menghindari konsumsi kafein atau paling banyak setara dengan 1-2 cangkir kopi/hari sebagai batas aman.
 - b) Batasi konsumsi makanan yang mengandung tinggi gula, garam, dan lemak. Pembatasan konsumsi garam dapat mengurangi risiko terjadinya hipertensi selama kehamilan. Hal ini penting, sebab hipertensi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko gangguan kehamilan seperti pre-eklampsia, terlepasnya plasenta, gangguan pertumbuhan, hingga kematian janin. Pada sebagian ibu hamil, dapat terjadi kenaikan gula darah yang disebut sebagai diabetes gestasional. Oleh karena itu sebaiknya konsumsi gula dibatasi. Pembatasan lemak juga penting dilakukan agar risiko obesitas dan penyakit degeneratif lainnya dapat dikendalikan.
 - c) Menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman.
 - d) Membatasi makanan yang mengandung gas contoh nangka, kol, ubi jalar karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil.
 - e) Hindari konsumsi makanan yang merangsang pencernaan. Hindari makanan-makanan yang sebelum ibu hamil menyebabkan pencernaan ibu terganggu. Contohnya: makanan yang pedas, asam, dan makanan lainnya.
- 8) Rutin memantau pertambahan berat badan sebaiknya 1 (satu) minggu sekali dan mencatatnya di Buku KIA.
- 9) Disiplin dalam menjalankan prinsip keamanan pangan (Lima Kunci Keamanan Pangan) dan kebersihan diri (PBHS), seperti:

- a) Simpan makanan pada tempat yang bersih dan gunakan alat makan yang bersih
- b) Pisahkan tempat penyimpanan makanan basah dan kering untuk menghindari kontaminasi.
- c) Konsumsi hanya makanan matang sempurna, hindari makanan mentah, seperti daging, ikan, telur mentah atau setengah matang, dll.
- d) Cuci bersih sayuran, masak dan konsumsi segera untuk mempertahankan kandungan gizinya.
- e) Cuci bersih sayur (misalnya lalapan) dan buah sebelum dikonsumsi.
- f) Rajin mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan, setelah buang air, sebelum mempersiapkan makanan atau memasak, setelah membersihkan kotoran anak, dll agar terhindar dari diare dan penyakit lainnya.

d. Program pemberian suplemen Multiple Micronutrient Supplement (MMS) pada Ibu Hamil

Menyikapi tingginya angka masalah kekurangan gizi, khususnya anemia pada ibu hamil, Kemenkes bersama lembaga kesehatan dunia dan lembaga kesejahteraan anak seperti WHO dan Unicef merekomendasikan penggunaan suplemen MMS untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil sebagai pengganti Tablet Tambah Darah (TTD) konvensional untuk ibu hamil (Kemenkes, 2024). Kapsul MMN merupakan kapsul yang mengandung 15 macam zat gizi mikro dan telah terbukti mampu meningkatkan status kesehatan ibu hamil seperti mampu menurunkan risiko anemia, KEK, BBLR, Bayi Kecil pada Masa Kehamilan, kelahiran prematur, kematian bayi dan bayi lahir mati. MMS menambah sembilan vitamin dan empat mineral dari kandungan TTD dengan kandungan utama, yaitu zat besi dan asam folat. Setiap tablet MMS mengandung 10 vitamin dan 5 mineral yang penting bagi ibu hamil antara lain vitamin A, D, E, C, B1, B2, niasin, B6, B12, asam folat, zat besi, zinc, tembaga, selenium, dan iodine.

e. Program pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal pada Ibu hamil

Pemberian PMT adalah program pemerintah untuk memberikan makanan bergizi tambahan kepada ibu hamil berisiko kurang gizi (KEK), agar kebutuhan nutrisi terpenuhi, meningkatkan status gizi, mencegah anemia, serta mendukung pertumbuhan janin yang sehat. Makanan tambahan pangan lokal yang diberikan untuk memenuhi kesenjangan asupan gizi guna memperbaiki masalah dan meningkatkan status gizi pada sasaran. PMT yang diberikan berupa makanan kudapan yang bukan merupakan menu utama (makan pagi,

makan siang, makan malam), tapi makanan dikonsumsi diantara waktu makan utama yang bertujuan memenuhi kecukupan kebutuhan energi dan zat gizi harian. Kudapan dari pangan lokal, merupakan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.

Berikut komposisi porsi makan Ibu hamil untuk kebutuhan sehari (Kemenkes 2025).

**Tabel 1.3 Komposisi makanan kudapan
Ibu hamil dalam satu hari (Kemenkes, 2025)**

Zat Gizi	Makanan Lengkap		Makanan Kudapan	
Energi	500 – 700 kkal		510 – 530 kkal	
Protein (gr)	18 – 23%	29 – 34 gram	18 – 23%	23 – 27 gram
Lemak (gr)	20 – 30%	14 – 24 gram	30 – 40%	19 – 23 gram

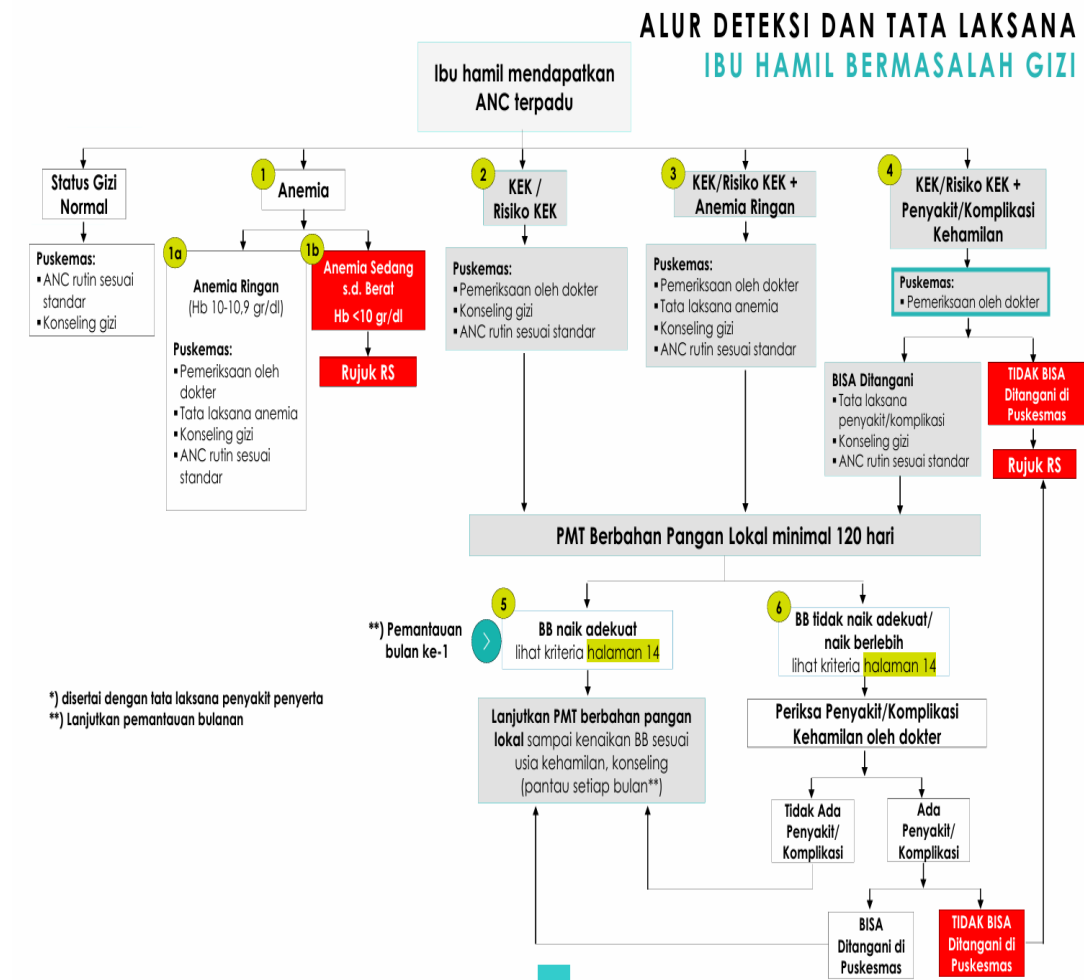
Prinsip Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil:

- 1) Berupa makanan siap santap, dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan, yang mengandung protein hewani dengan memperhatikan gizi seimbang, membatasi penggunaan gula, garam dan lemak tinggi.
- 2) Berupa tambahan asupan dan bukan pengganti makanan utama.
- 3) Pemberian makanan tambahan disertai edukasi (demonstrasi/penyuluhan/konseling)
- 4) Mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat
- 5) Lama waktu pemberian makanan tambahan: Makanan tambahan Ibu hamil diberikan selama minimal 120 hari.
- 6) Diberikan setiap hari. Dalam 1 siklus menu dapat diberikan 1 kali makanan lengkap sebagai sarana edukasi isi piringku, selain itu diberikan dalam bentuk makanan selingan/kudapan padat gizi

Catatan:

- Pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal diutamakan menggunakan bahan makanan yang terfortifikasi, seperti garam, minyak goreng, tepung terigu, dll.

- Pada daerah yang sudah melaksanakan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, PMT berbahan pangan lokal bagi ibu hamil bermasalah gizi pada hari yang sama dengan MBG diberikan dalam bentuk makanan selingan/kudapan padat gizi.
- f. Alur tata laksana ibu hamil bermasalah gizi



Gambar 1.4 Alur tata laksana ibu hamil bermasalah (Kemenkes, 2025)

Setiap ibu hamil harus mendapatkan ANC terpadu. Setiap ANC, dilakukan penapisan di Fasyankes untuk mendeteksi masalah gizi dan kesehatan pada ibu hamil. Jika hasil penapisan:

- 1) Anemia saja: Pemeriksaan oleh dokter, tata laksana anemia dan edukasi/konseling gizi.
 - a) Anemia ringan (Hb 10 – 10,9 gr/dl): tata laksana pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) 2 x 1/hari atau (1 MMS + 1 TTD)/hari.
 - Pemantauan kadar Hb ibu hamil dilakukan setelah 4 minggu

- Jika Hb meningkat: pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) 2 x 1/hari atau (1 MMS + 1 TTD)/hari dapat diteruskan hingga 4 minggu berikutnya
 - Jika Hb tetap/turun: rujuk ke RS. 1b Anemia sedang s.d berat (< 10 gr/dl): rujuk ke RS
- 2) KEK/Risiko KEK saja: Pemeriksaan oleh dokter, tata laksana dengan PMT lokal minimal selama 120 hari disertai edukasi/konseling gizi.
 - 3) KEK/Risiko KEK + Anemia ringan: Pemeriksaan oleh dokter, tata laksana dengan PMT lokal minimal selama 120 hari, tatalaksana anemia disertai edukasi/konseling gizi.
 - 4) KEK/Risiko KEK + penyakit/komplikasi kehamilan: lakukan pemeriksaan oleh dokter. Apabila BISA ditangani di puskesmas, tata laksana dengan PMT berbahan pangan lokal minimal selama 120 hari, tatalaksana penyakit/komplikasi kehamilan, disertai edukasi/konseling gizi. Rujuk ke RS 5 jika tidak dapat ditangani di Puskesmas.
 - 5) Jika pada pemantauan bulan pertama BB naik adekuat, kenaikan BB berdasarkan IMT atau grafik peningkatan BB sesuai usia kehamilan pada Buku KIA, lanjutkan PMT berbahan pangan lokal, disertai edukasi/konseling gizi dan lakukan pemantauan rutin setiap bulan.
 - 6) Jika pada pemantauan bulan pertama BB Tetap/BB Tidak Naik/BB Naik Tidak Sesuai Tabel atau Grafik: Periksa ada atau tidaknya penyakit/komplikasi kehamilan oleh dokter. Jika hasil pemeriksaan:
 - a) Ada penyakit/komplikasi kehamilan yang tidak dapat ditangani di Puskesmas: rujuk ke RS.
 - b) Ada penyakit/komplikasi kehamilan yang dapat ditangani di Puskesmas: tata laksana penyakit/komplikasi kehamilan, lanjutkan PMT lokal dan lakukan pemantauan rutin setiap bulan.
 - c) Tidak ada penyakit/komplikasi kehamilan: lanjutkan PMT lokal dan lakukan pemantauan rutin setiap bulan
- Catatan: Gunakan data IMT dan/atau LiLA sasaran terbaru, setidaknya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal.

Contoh Standar Bahan Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Risiko KEK yang disiapkan untuk 1 kali makan (Makanan Kudapan/Makanan Lengkap)

Tabel 1.4 Tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Risiko KEK (Kemenkes, 2025)

Bahan Makanan	Makanan Kudapan		Makanan Lengkap	
	Berat (gram)	Ukuran Rumah Tangga (URT)	Berat (gram)	Ukuran Rumah Tangga (URT)
Makanan Pokok (beras)	40	½ gelas	75	½ gelas
Lauk hewani 1 (telur)	60	1 butir besar	Ikan 75 g/ ayam 60 g/	1 ekor/ 1 potong besar/
Lauk hewani 2 (ayam/ikan/daging)	30 - 50	½ potong sedang	telur 60 g/ daging 60 g	1 butir besar/ 1 potong besar
Lauk Nabati (kacang-kacangan/tempe/tahu)	25	3 sdm/ ½ potong sedang	50	2 potong sedang
Sayur	50	½ gelas ukuran 250 ml	100	1 gelas
Buah	60	1 buah ukuran sedang	100	1 buah ukuran besar/ 2 potong sedang
Minyak/lemak	5	1 sdt	5	1 sdt

E. Manajemen Nutrisi Pasca Melahirkan

1. Pengertian Masa Nifas

Masa nifas atau masa pasca melahirkan merupakan masa yang dimulai segera setelah bayi lahir sampai perubahan fisiologis dan anatomis ibu kembali ke keadaan sebelum hamil yang berlangsung hingga enam minggu (42 hari) (Astuti, 2024). Selama masa nifas, organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan dan pemulihan seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan organ reproduksi ini disebut involusi. Asuhan selama periode nifas khususnya dalam pemenuhan nutrisi, perlu mendapat perhatian karena kematian ibu dapat terjadi pada periode ini. Selain pemulihan kesehatan fisik ibu, masa nifas juga erat kaitannya dengan proses Laktasi atau menyusui yang memiliki peran krusial dalam mendukung kesehatan dan perkembangan optimal bayi baru lahir. Pemberian ASI (Air Susu Ibu) merupakan bentuk pemberian makanan yang paling disarankan oleh organisasi kesehatan dunia seperti WHO (World Health Organization).

2. Pemenuhan Nutrisi Masa

Selama minggu ke-2 pertama setelah kelahiran, pedoman nutrisi berfokus pada penyembuhan fisik dan stabilitas setelah kelahiran dan persiapan laktasi. Ibu menyusui memiliki nutrisi tambahan (Yuliani, dkk, 2025). Seperti Ibu Hamil, Ibu Menyusui juga memiliki kebutuhan energi dan gizi yang lebih tinggi, yakni sebesar 330 kkal/hari untuk 6 bulan pertama dan 400 kkal/hari untuk 6 bulan kedua dibandingkan dengan orang dewasa lain yang tidak hamil. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan volume rata-rata ASI yang diproduksi per hari, yakni 780 mL (berkisar 450 – 1200 mL), mengingat kandungan energi dalam ASI adalah sebesar 67 kkal/100 mL. Tidak hanya dari jumlah produksi ASI, menyusui dianggap berhasil jika bayi mengalami peningkatan berat badan yang sesuai. Jika kebutuhan gizi ibu selama menyusui tidak terpenuhi, maka kenaikan berat badan bayi yang optimal akan sulit dicapai, sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi pada bayi dan semakin menurunkan napsu makan atau menyusunya. Pada akhirnya anak sulit naik berat badan dan meningkatkan risiko terhambatnya pertumbuhan, termasuk sehingga anak berisiko mengalami stunting.

Untuk mendukung keberhasilan menyusui, Ibu Menyusui membutuhkan tambahan protein sebesar 20 g/hari pada 6 bulan pertama dan 15 g/hari pada 6 bulan kedua selama menyusui, dan tambahan lemak sebesar 2 g/hari dibandingkan perempuan tidak hamil. Khusus untuk kebutuhan zat gizi mikro, Secara umum, ibu menyusui membutuhkan tambahan vitamin A, vitamin E berbagai vitamin B, dan vitamin C. Sedangkan kebutuhan mineral yang meningkat selama menyusui adalah Ca, Iodium, Seng, Selenium, Mangan, Chromium, Kalium, dan Tembaga. Ibu menyusui membutuhkan tambahan 350 RE vitamin A menjadi 950 RE/hari (lebih tinggi 50 RE dibandingkan saat hamil) dan 100 mcg Folat menjadi 500 mcg/hari (100 mcg lebih rendah dibandingkan saat hamil) per hari. Karenanya, disarankan agar Ibu menyusui terus mengonsumsi vitamin prenatal setiap hari selama menyusui. Meskipun demikian, berbeda dengan Ibu Hamil, Ibu Menyusui tidak membutuhkan tambahan zat besi untuk bayinya dibandingkan saat sebelum hamil oleh karena zat besi tidak dapat disalurkan melalui ASI. Namun demikian ibu menyusui perlu menambah konsumsi besi melalui asupan makanan yang seimbang selama menyusui dan konsumsi TTD selama masa nifas, untuk mengganti simpanan besi yang menurun saat hamil, atau memperbaiki status Hb-nya bila ibu menyusui mengalami anemia.

Secara umum, Ibu Menyusui lebih rentan terhadap kekurangan zat gizi mikro dibandingkan dengan kekurangan protein atau energi. Sebagian zat gizi

mikro cenderung mempengaruhi komposisi ASI dan perkembangan status gizi bayi. Suplementasi atau intervensi makanan lainnya dapat meningkatkan sekresi berbagai zat gizi tersebut melalui ASI, sehingga pada akhirnya dapat memperbaiki status gizi bayinya. Pada umumnya, kadar zat gizi di dalam ASI dipengaruhi oleh asupan vitamin yang larut dalam air, sedikit dipengaruhi oleh vitamin yang larut dalam lemak, dan tidak dipengaruhi oleh kandungan mineral dan status mineral ibu. Pada sebagian zat gizi mikro, seperti folat, sekresi dalam ASI baru terpengaruh pada keadaan defisiensi ibu yang berat atau asupan yang sangat rendah. Dalam hal ini, status gizi ibu menurun selama menyusui sedangkan konsentrasi zat gizi dalam ASI dijaga (Kemenkes, 2021).

3. Anjuran dan Pesan Khusus untuk Ibu Menyusui (Kemenkes 2021 dan KIA 2024)

a. Biasakan Mengonsumsi Anekaragam Pangan yang Lebih Banyak

- 1) Selama menyusui, makanlah 3 kali makanan utama ditambah dengan 2 kali kudapan dalam sehari. Dianjurkan gunakan pedoman “Isi Piringku”, agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai zat gizi tambahan zat gizi makro dan mikro melalui keragaman pangan yaitu: Isi separuh bagian piring makan anda dengan makanan pokok dan lauk pauk, lebih banyak makanan pokoknya; dan isi separuh piring lainnya dengan buah dan sayur, lebih banyak sayurnya.
- 2) Konsumsi beragam jenis pangan lokal setiap hari sesuai kemampuan, misalnya roti, telur, dan tomat untuk sarapan, nasi, ikan, dan sayur bening bayam untuk makan siang, serta sayur lodeh dengan tempe, ubi dan ayam untuk makan malam, dilengkapi dengan jeruk/pepaya/pisang, dan sebagainya.

b. Selama menyusui, makanlah 3 kali makanan utama ditambah dengan kudapan yang bergizi dalam sehari sesuai dengan anjuran porsi makan.

Tabel 5. Porsi makan dan minum Ibu menyusui untuk kebutuhan sehari
(Kemenkes, 2024)

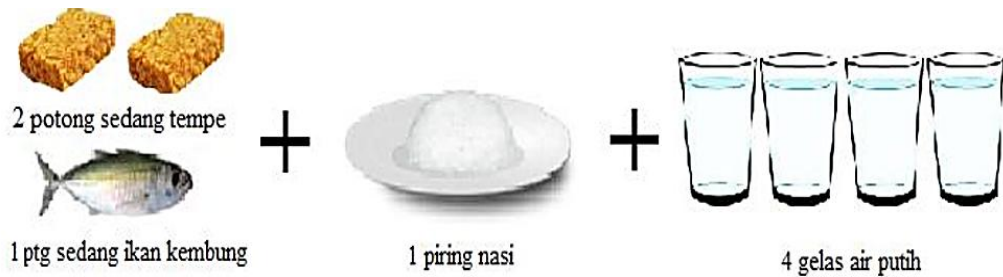
Porsi Makan dan Minum Ibu Menyusui Untuk Kebutuhan Sehari

Bahan Makanan	Ibu Menyusui 0 - 12 Bulan	Keterangan per porsi
Nasi atau Makanan Pokok	6 porsi      	• 100 g atau $\frac{3}{4}$ gelas nasi • 125 g atau 3 buah jagung ukuran sedang • 210 g atau 2 kentang ukuran sedang • 120 g atau 1 $\frac{1}{2}$ potong singkong • 70 g atau 3 iris roti putih • 200 g atau 2 gelas mie basah
Protein Hewani Ikan, Telur, Ayam dan Lainnya	4 porsi    	• 50 g atau 1 potong sedang ikan • 55 g atau 1 butir telur Ayam
Protein Nabati Tempe, Tahu, dan Lainnya	4 porsi    	• 50 g atau 1 potong sedang tempe • 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur-sayuran	4 porsi    	100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah-buahan	4 porsi    	• 100 g atau 1 potong sedang pisang • 100-190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak/Lemak	6 porsi      	5 g atau 1 sendok teh, bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, santan, kemiri, mentega dan sumber lemak lainnya. Minyak/lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis atau dimasak dengan santan
Gula	2 porsi  	10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue-kue manis, minum teh manis dan lain-lainnya
Minum Air Putih: 14 gelas/hari di 6 bulan pertama dan 12 gelas/hari pada 6 bulan kedua.		

- c. Tambahkan Porsi Anjuran Makan untuk Ibu Menyusui 6 bulan pertama (tambahan 330 kkal energi dan 800 ml air) yang dapat dipenuhi dengan beberapa contoh berikut:

Contoh 1:

1 Porsi Protein Hewani (1 potong sedang ikan kembung) + 1 Porsi Protein Nabati (2 potong sedang tempe) + 1 Porsi Karbohidrat (1 piring nasi) + 1 Porsi Lemak + 4 gelas air putih



Gambar 1.5 *Contoh 1:* Makanan tambahan untuk Ibu Menyusui 6 bulan pertama (Kemenkes, 2024)

Contoh 2:

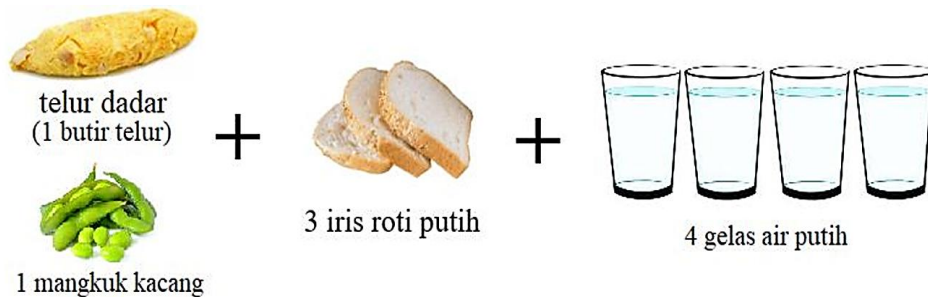
1 Porsi Protein Hewani (1 potong sedang ayam) + 1 Porsi Protein Nabati (2 potong sedang tahu) + 1 Porsi Karbohidrat (2 buah sedang kentang) + 1 Porsi Lemak + 4 gelas air putih



Gambar 1.6 *Contoh 2:* Makanan tambahan untuk Ibu Menyusui 6 bulan pertama (Kemenkes, 2024)

Contoh 3:

1 Porsi Protein Hewani (1 buah telur dadar) + 1 Porsi Protein Nabati (1 mangkuk kacang) + 1 Porsi Karbohidrat (3 iris roti) + 1 Porsi Lemak + 4 gelas air putih



Gambar 1.7 Contoh 3: Makanan tambahan untuk Ibu Menyusui 6 bulan pertama (Kemenkes, 2024)

- d. Anjuran Makan untuk Ibu Menyusui 6 bulan kedua (tambahan 400 kkal energi dan 650 ml air) yang dapat dipenuhi dengan beberapa contoh berikut:

Contoh 1:

1 Porsi Protein Hewani (1 potong sedang ayam) + 1 Porsi Protein Nabati (1 mangkuk kacang) + 1 Porsi Karbohidrat (2 buah sedang kentang) + 1 Porsi Lemak + 3 ¼ gelas air putih



Gambar 8. Contoh 1: Makanan tambahan untuk Ibu Menyusui 6 bulan Kedua (Kemenkes, 2024)

Contoh 2:

1 Porsi Protein Hewani (1 butir telur) + 1 Porsi Protein Nabati (2 potong sedang tempe) + 1 Porsi Karbohidrat (1 piring nasi) + 1 Porsi Lemak + 3 ¼ gelas air putih



Gambar 9. *Contoh 2:* Makanan tambahan untuk Ibu Menyusui 6 bulan Kedua (Kemenkes, 2024)

- e. Disiplin dalam menjalankan prinsip keamanan pangan dan kebersihan diri (Lima Kunci Keamanan Pangan dan PBHS), seperti:
- 1) Simpan makanan pada tempat yang bersih dan gunakan alat makan yang bersih
 - 2) Pisahkan tempat penyimpanan makanan basah dan kering untuk menghindari kontaminasi
 - 3) Konsumsi hanya makanan matang sempurna, hindari makanan mentah, seperti daging, ikan, telur mentah atau setengah matang, dll
 - 4) Cuci bersih sayuran, masak dan konsumsi segera untuk mempertahankan kandungan gizinya
 - 5) Cuci bersih sayur (misalnya lalapan) dan buah sebelum dikonsumsi
 - 6) Rajin mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan, setelah buang air, sebelum mempersiapkan makanan atau memasak, setelah membersihkan kotoran anak, dll agar terhindar dari diare dan penyakit lainnya
- f. Konsumsi air putih yang cukup Seiring dengan produksi ASI, kebutuhan air minum ibu menyusui sedikit lebih banyak dibandingkan ibu hamil, yakni 14 gelas air putih untuk 6 bulan pertama dan 12 gelas air putih sehari untuk 6 bulan kedua.
- g. Konsumsi Vitamin A pada masa nifas (2 kali berturut turut, dengan jeda minimal 24 jam, yakni segera setelah melahirkan dan paling lambat 6 minggu setelah melahirkan untuk memastikan agar bayi mendapatkan vitamin A dari ASI). Suplementasi vitamin A pada ibu nifas untuk menjaga kesehatan ibu, mencegah infeksi, meningkatkan kandungan vitamin A di ASI yang penting

untuk kekebalan dan pertumbuhan bayi. Vitamin A adalah salah satu zat gizi esensial yang dibutuhkan balita untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Vitamin A dalam tubuh menstimulasi produksi sel darah putih yang berperan dalam pembentukan tulang, menjaga dan mendukung pertumbuhan sel-sel tubuh, serta meningkatkan daya tahan tubuh (Indasari, dkk, 2025). Sumber vitamin A didapatkan dari sayuran berdaun hijau, tomat, wortel, buah, hati sapi, minyak ikan, telur, dan lain sebagainya.

- h. Suplementasi zat besi oral, baik secara terpisah atau dikombinasikan dengan suplementasi asam folat, dapat diberikan kepada ibu pasca melahirkan selama 6-12 minggu setelah melahirkan untuk mengurangi risiko anemia. Konsumsi TTD selama masa nifas (setelah melahirkan). Anemia yang terjadi selama nifas (kadar hemoglobin <10 gr/dL) akan menurunkan kualitas hidup dan produktivitas akibat menurunnya kecerdasan atau kemampuan kognitif, meningkatkan risiko komplikasi seperti perdarahan, infeksi, depresi pasca melahirkan, hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, konsumsi TTD setelah melahirkan dianjurkan agar terhindari dari berbagai risiko kesehatan tersebut.
- i. Batasi konsumsi kopi atau minuman berkafein lainnya Konsumsi minuman mengandung kafein, seperti teh dan kopi pada ibu menyusui dapat memberikan efek diuretik (sering buang air kecil), sehingga jika dikonsumsi berlebihan, dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil, meningkatkan risiko dehidrasi, tekanan darah, dan denyut jantung. Selain itu, kafein juga merupakan salah satu penghambat penyerapan beberapa zat gizi tertentu, salah satunya zat besi. Dengan demikian, seperti ibu hamil, ibu menyusui juga dianjurkan untuk menghindari konsumsi kafein atau paling banyak setara dengan 1-2 cangkir kopi/hari sebagai batas aman. Hal ini disebabkan, menurut Food Standards Australia New Zealand (2019), sebanyak 1% kafein yang dikonsumsi ibu menyusui dialirkan dalam ASI dan dapat menyebabkan bayi lebih rewel, mengalami kolik, gangguan tidur dan sebagainya bergantung pada tingkat sensitivitas bayi terhadap kafein, mengingat bayi membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna kafein. Oleh karena itu, ibu menyusui dianjurkan untuk tidak mengonsumsi kafein lebih dari 200 mg atau setara dengan 1 -2 cangkir kopi per hari.
- j. Bijak dalam mencari, mencerna, dan menerapkan informasi terkait gizi dan kesehatan selama kehamilan. Jadikan Buku KIA sebagai salah satu rujukan utama dan hubungi kader atau tenaga kesehatan jika membutuhkan informasi yang lengkap dan benar agar Ibu Hamil tidak mudah terbawa mitos atau informasi yang keliru.

F. Simpulan

kesehatan reproduksi merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang harus dijaga sepanjang daur kehidupan perempuan—mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, nifas, hingga menyusui—dan salah satu penentunya yang paling kuat adalah pemenuhan nutrisi yang seimbang dan adekuat. Di Indonesia, masalah gizi pada perempuan usia subur masih menjadi tantangan besar karena tingginya anemia dan Kekurangan Energi Kronis (KEK), yang bukan hanya menurunkan kualitas kesehatan perempuan, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan reproduksi (misalnya sulit hamil), komplikasi kehamilan dan persalinan (preeklamsia, infeksi, perdarahan), serta berdampak pada bayi melalui peningkatan risiko prematur, BBLR, IUFD, cacat bawaan, gangguan produksi ASI, hingga stunting. Karena itu, pemenuhan gizi harus dipahami sebagai strategi pencegahan yang paling awal dan paling efektif untuk menurunkan morbiditas–mortalitas ibu dan anak.

Manajemen nutrisi dalam kesehatan reproduksi bersifat holistik, karena kebutuhan tubuh tidak hanya dipenuhi oleh makronutrien (karbohidrat, protein, lemak) sebagai sumber energi dan pembangun jaringan, tetapi juga mikronutrien (vitamin, mineral, air, serat) yang berperan besar sebagai pengatur proses tubuh, termasuk fungsi reproduksi. Penerapan gizi seimbang melalui keragaman pangan, aktivitas fisik, dan PHBS menjadi prinsip dasar, dengan panduan praktis seperti “Isi Piringku” serta pembatasan gula–garam–lemak (G4–G1–L5) untuk mencegah PTM dan komplikasi kehamilan. Pada masa prakonsepsi, pemenuhan gizi berfungsi menyiapkan kesuburan, memperbaiki cadangan zat gizi (terutama zat besi/folat), mencegah anemia dan KEK (misalnya melalui pemantauan LiLA), serta mengoptimalkan kesiapan tubuh menghadapi kehamilan dan laktasi.

Memasuki kehamilan, kebutuhan nutrisi meningkat karena pertumbuhan janin, plasenta, dan perubahan fisiologis ibu, sehingga diperlukan penguatan asupan energi, protein, lemak sehat (termasuk omega-3/DHA), serta mikronutrien kunci seperti zat besi, folat/asam folat, kalsium, vitamin D, dan vitamin B. Pemantauan status gizi melalui IMT dan penambahan berat badan sesuai trimester serta LiLA (untuk deteksi risiko KEK) penting untuk mencegah komplikasi dan memastikan pertumbuhan janin optimal. Program nasional seperti konsumsi TTD, inovasi MMS (sebagai pengganti/alternatif TTD), serta PMT berbahan pangan lokal untuk ibu hamil KEK/risiko KEK menjadi intervensi penting yang harus disertai edukasi, pemantauan, dan tata laksana terintegrasi dalam ANC.

Pada masa nifas dan menyusui, nutrisi tetap krusial karena ibu membutuhkan energi, protein, lemak, dan mikronutrien tambahan untuk pemulihan tubuh dan produksi ASI. Kekurangan gizi pada fase ini dapat mengganggu keberhasilan menyusui dan berdampak pada pertumbuhan bayi. Karena itu, ibu menyusui dianjurkan memperbanyak ragam pangan, menjaga keamanan pangan dan

kebersihan, mencukupi cairan, menerima suplemen tertentu seperti vitamin A nifas, serta melanjutkan zat besi bila diperlukan untuk memulihkan simpanan besi dan mencegah anemia pascamelahirkan. Pada akhirnya, manajemen nutrisi yang tepat dan konsisten dari prakonsepsi hingga menyusui merupakan kunci menjaga kesehatan reproduksi perempuan, menurunkan risiko komplikasi, mendukung produksi ASI optimal, serta melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.

G. Referensi

- Astuti, dkk. (2024). *Asuhan Kebidanan pada Kesehatan Reproduksi*. Yayasan Kita Menulis
- Astuti, H., dkk. (2023). *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*. Bandung: EUREKA MEDIA AKSARA. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.penerbiteur-eka.com/media/publications/566916-gizi-dalam-kesehatan-reproduksi-4bc1e366.pdf>
- Darmawanti, B. (2022). *Program "Isi Piringku"*. Kemenkes RI. <https://ayosehat.kemkes.go.id/isi-piringku-pedoman-makan-kekinian-orang-indonesia>
- Diantara, T., Azissah, D., Surahman, F. (2026). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Ibu Hamil Di Rsud Petanang Kota Lubuk Linggau Tahun 2025. *Student Scientific Journal*, 4(1), 73–84. <https://doi.org/10.37676/ssj.v4i1.9616>
- Elifiya. (2022). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Ny. I Umur 26 Tahun G1P0A0 Usia Kehamilan 12 Minggu Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Di Ruang Arafah RSI Fatimah Cilacap Tahun 2022. Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Al-Irsyad Cilacap, pp.8–35. <http://repository.universitalirsyad.ac.id/id/eprint/183/2/ABSTRAK.pdf>
- Fandir, dkk. (2024). Efek Pemberian Multi Micro Nutrient (MMN) Dan Konseling Gizi Terhadap Status Gizi Wanita Prakonsepsi. *Media Gizi Pangan*, 31(1), 31-38 <https://doi.org/10.32382/mgp.v31i1.507>
- Hidayah, N., Rahayu, S., Prasetyawati, N. (2022). Determination And Effort Healthy Pregnancy. *Jurnal Indonesia Kebidanan*, 6(2), 76-84. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3310923>
- Indasari, dkk. (2025). Faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Pemberian Vitamin A Pada Ibu Nifas Di Wilayah Kerja Puskesmas Betung Kabupaten Ogan Ilir (OI).

- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Menkes Tekankan Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil*. Jakarta: Generasi Sehat, Masa Depan Hebat. <https://www.kemkes.go.id/id/menkes-tekanan-pentingnya-ragam-mikronutrien-bagi-ibu-hamil>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Gizi Seimbang Ibu Hamil*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/405/gizi-seimbang-ibu-hamil
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pilar Utama Dalam Prinsip Gizi Seimbang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/179/pilar-utama-dalam-prinsip-gizi-seimbang
- Menteri Kesehatan RI. (2025). Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Primer Dan Komunitas Nomor HK.02.02/B/ 576 /2025 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil Dan Balita Bermasalah Gizi
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Kemenkes RI. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun Kemenkes*. Jakarta. <https://kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2024>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Buku Saku Merencanakan Kehamilan Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. https://drive.google.com/file/d/1yoSUKQmMG0ORImzLONbCt8w_9qfvnjY3/view
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak: Panduan Lengkap untuk Mewujudkan Ibu dan Anak Sehat*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://kesprimkom.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/Buku_KIA_2024.pdf
- Lestari, E., Shaluhiah, Z., Adi, MS. (2023). Intervensi Pencegahan Stunting pada Masa Prakonsepsi : Literature Review. *Jurnal MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia)*. 6(2), 214-221. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i2.2994>

- Maslikhah, Prajayanti, H., Baroroh, I. (2023). Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pentingnya Gizi Pada Masa Kehamilan. *Jurnal Kesehatan mercusuar* , 6 (1). <https://doi.org/10.36984/jkm.v6i1.331>
- Meyana, M., Fatimah, AJ., Siswi, W., Julian, J., Ika, O., Tutik, E., Tutik, H., Aisyah, VG., Ihda, M., Fidatul, J., Arini, PS., Ni Nyoman, DW., Sriwahyuni, Yosefa, SA., Elwitri, S. (2023). *Asuhan Kebidanan Pada Pranikah dan Prakonsepsi*. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Mokodompit, H. K. N. (2025). *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*. Widina Media Utama
- Nurhayati, N., Khair, U., Amalia, R., Solama, W., Simajuntak, H., Handayani, S., Hikmandayani, Asih, RF. (2023). *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Pasang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang. <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-41-tahun-2014/>
- Saraswati, E., dkk. (2021). *Gizi, Gaya Hidup Dan Kesehatan Reproduksi*. Bandung: EUREKA MEDIA AKSARA. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.penerbiteur.eka.com/media/publications/580062-gizi-gaya-hidup-dan-kesehatan-reproduksi-1cd510f3.pdf>
- Sulastri, A., Maretta, MY & Hapsari, E. (2022). Pengaruh Edukasi Kesehatan Prakonsepsi Dengan Animasi Terhadap Pengetahuan Catin Tentang Persiapan Kehamilan Sehat. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 10(3), 121-130. <https://ejournal.akbidyo.ac.id/index.php/JIK/article/view/202/181>
- Wantini, NA., Setyaniu, RA., Riska, H. (2021). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Remaja, Prakonsepsi dan Perencanaan Kehamilan*. Yogyakarta: Respati Press. <https://repositori.respati.ac.id/dokumen/R-00002574.pdf>
- WHO. (2023). Maternal and neonatal mortality.
- WHO. (2025). *The global health observatory: Anemia in women and children*. Available <https://www.who.int>
- Yuliani, M., Ariani, A., Lubis, T. (2025). *Gizi Kesehatan Reproduksi*. Manggu Makmur Tanjung Lestari

Yani, dkk., (2024). *Buku Ajar Asuhan Pranikah dan Prakonsepsi*. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.nuansafajarcemerlang.com/media/publications/587086-buku-ajar-asuhan-pranikah-dan-prakonseps-ca84d50d.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.nuansafajarcemerlang.com/media/publications/587086-buku-ajar-asuhan-pranikah-dan-prakonseps-ca84d50d.pdf)

H. Glosarium

ACOG (American College of Obstetrics and Gynecology) = Organisasi profesional nirlaba terkemuka di Amerika Serikat yang mewakili dokter spesialis obstetri dan ginekologi (kebidanan dan kandungan).

BBLR (Berat badan lahir rendah) = Kondisi bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram (2,5 kg).

ICPD (International Conference on Population and Development) = Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan.

IMT (Indeks Massa Tubuh) = ukuran untuk menilai status gizi seseorang dengan membandingkan berat badan (kg) dan tinggi badan (meter kuadrat).

IUFD (Intrauterine Fetal Death) = Kondisi kematian janin di dalam kandungan setelah usia kehamilan 20 minggu, sebelum persalinan dimulai.

KEK (Kurang Energi Kronis) = kondisi gizi buruk akibat kekurangan asupan energi dan nutrisi dalam jangka panjang, ditandai dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA) < 23,5 cm atau IMT pra-kehamilan < 18,5 kg/m².

LiLA (Lingkar Lengan Atas) = Pengukuran keliling lengan bagian tengah untuk menilai status gizi seseorang, terutama wanita usia subur dan ibu hamil, yang mengindikasikan cadangan energi dan otot untuk mendeteksi risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) atau gizi kurang, dengan batas umum 23,5 cm sebagai penanda status gizi kurang.

PUS (Pasangan Usia Subur) = Pasangan suami istri di mana usia istrinya berada dalam rentang 15-49 tahun (atau kurang dari 15 tahun tapi sudah haid, atau lebih dari 50 tahun tapi masih haid).

PTM (Penyakit Tidak Menular) = Penyakit kronis yang tidak disebabkan oleh infeksi kuman dan tidak dapat menular dari orang ke orang.

UNICEF (United Nations Children's Fund) = Badan PBB yang bekerja melindungi hak anak di seluruh dunia, menyediakan bantuan darurat, dan memastikan anak-anak dapat bertahan hidup, berkembang, serta mencapai potensi penuhnya melalui layanan kesehatan, pendidikan, gizi, perlindungan, dan sanitasi, terutama bagi mereka yang paling rentan.

WHO (World Health Organization) = Organisasi Kesehatan Dunia adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas mengarahkan dan mengoordinasikan kesehatan masyarakat global.

WUS (Wanita Usia Subur) = wanita dalam rentang usia reproduktif (biasanya 15-49 tahun) yang masih berpotensi untuk hamil, dan organ reproduksinya berfungsi dengan baik.

CHAPTER 2

PERAWATAN KESEHATAN MENSTRUASI (MENSTRUAL HYGIENE MANAGEMENT) DI KOMUNITAS

Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Perawatan kesehatan menstruasi atau *Menstrual Hygiene Management (MHM)* merupakan komponen mendasar pada kesehatan reproduksi perempuan yang telah mengalami menstruasi secara periodik, dan berhubungan dengan berbagai macam dimensi kesehatan reproduksi perempuan dan remaja putri, antara lain aspek biologi, psikologi, sosial, budaya dan lingkungan (Hennegan et al., 2021). Semakin banyak perempuan yang menyadari betapa pentingnya kebersihan diri pada saat menstruasi dan seiring diakuinya atas hak kesehatan reproduksi, maka MHM dipandang sebagai isu kesehatan masyarakat, dalam pendidikan dan kesetaraan gender. Ruang lingkup MHM mencakup Praktik personal, akses terhadap produk menstruasi yang aman, akses sanitasi yang memadai dan lingkungan sosial yang mendukung keberlangsungan praktik tersebut tanpa stigma atau diskriminasi (Sharma et al., n.d.2025). Perawatan MHM di Komunitas memerlukan pendekatan yang holistik dan interprofesional karena dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor sehingga dapat mencapai dampak yang berkelanjutan.

Perawatan MHM di komunitas sangat berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan karena perawatan yang buruk akan berdampak pada kesehatan fisik (infeksi reproduksi), kesejahteraan mental (stigma, kecemasan), partisipasi sosial (absensi sekolah/kantor/kerja) dan martabat perempuan yang mengalami menstruasi. Dalam konteks promotif, preventif dan pemberdayaan di komunitas pemahaman yang komprehensif tentang determinan sosial, hambatan, edukasi peran tenaga kesehatan dan profesional lintas disiplin, serta rujukan kebijakan sangat penting untuk dirumuskan. Berdasarkan kerangka ini, maka bab ini menelaah praktik MHM di komunitas agar dapat memberikan panduan ilmiah dan pragmatis kepada bidan, perawat, apoteker dan ahli gizi yang terlibat dalam pelayanan primer dan pendamping masyarakat.

B. Konsep dan Ruang Lingkup Menstrual Hygiene Management di Komunitas

Manajemen Kebersihan Menstruasi (*MHM*) merupakan istilah multidimesi yang merujuk pada Upaya individu untuk mengelola menstruasi dengan bersih dan nyaman, serta lingkungan yang memungkinkan Perempuan melakukan perawatan *MHM* tanpa stigma atau hambatan struktural. *MHM* mencakup akses terhadap produk menstruasi yang bersih dan nyaman, fasilitas sanitasi layak (toilet, air bersih dan sabun), serta pengetahuan yang memadai untuk melakukan perawatan yang aman ((Hennegan et al., 2021). Konsep ini juga menekankan pada Hak Kesehatan reproduksi dan hak asasi perempuan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

MHM didefinisikan sebagai kemampuan Perempuan dan remaja putri untuk menggunakan bahan penyerap menstruasi yang bersih, menggantinya secara privat dan sesering yang dibutuhkan, menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tubuh, serta memiliki akses terhadap fasilitas pembuangan limbah menstruasi yang aman (Hennegan et al., 2021; UNICEF, 2022) Definisi ini menegaskan bahwa *MHM* mencakup aspek personal hygiene, infrastruktur dan sistem pendukung sosial dan kesehatan.

Kurangnya pemahaman tentang fisiologi menstruasi dan faktor stigma budaya di berbagai komunitas menjadi hambatan dalam memberikan Pendidikan Kesehatan yang efektif (Panda et al., 2024). Tabu sosial seringkali menjadi pengaruh yang kuat terhadap topik menstruasi, hal ini semakin memperkuat akan kebutuhan terhadap intervensi berbasis komunitas yang menempatkan *MHM* sebagai bagian integral dari program Kesehatan reproduksi dan Pendidikan Kesehatan masyarakat (Hennegan et al., 2021).

Selain itu juga, ruang lingkup *MHM* di komunitas mencakup aspek lingkungan dan sanitasi umum. Ketidaktersediaan air bersih, Sanitasi dan Hygiene (WASH) di tempat umum seperti di sekolah, atau pusat pelayanan Kesehatan membuat hambatan bagi Perempuan untuk melakukan *MHM* yang aman dan nyaman. Ketika fasilitas ini tidak tersedia, maka perawatan *MHM* yang tidak bersih bisa menyebabkan gangguan Kesehatan reproduksi dan menurunkan kualitas hidup Perempuan di komunitas tersebut (Das et al., 2015).

Pentingnya perawatan *MHM* juga merupakan dasar hak terhadap Kesehatan, Pendidikan dan kesetaraan gender. Ketidaksetaraan dalam akses produk kebersihan menstruasi berdampak tidak pada kesehatan Perempuan tetapi berdampak juga pada keberhasilan dalam Pendidikan, terutama pada remaja putri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya akses terhadap fasilitas dan produk menstruasi terkait dengan absensi sekolah yang lebih tinggi selama periode menstruasi (Sommer, et al., 2020; WHO, 2023).

MHM juga berkaitan dengan isu lingkungan, khususnya dalam pengolahan limbah pembalut sekali pakai, yang menimbulkan tantangan kesehatan lingkungan apabila tidak dikelola secara aman dan berkelanjutan (UNFPA, 2021; Kaur et al., 2022). Pendekatan komunitas perlu mempertimbangkan alternatif produk menstruasi yang ramah lingkungan serta system pembuangan yang aman.

Memahami MHM tidak hanya sebagai tindakan teknis kebersihan tetapi juga sebagai hak sosial budaya. Oleh karena itu, penting penting untuk merancang program berkelanjutan dan peka terhadap MHM dalam konteks komunitas. Intervensi akan berhasil bila melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Perempuan yang mengalami menstruasi itu sendiri, keluarga, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan local untuk mendukung perubahan norma sosial yang diskriminatif.

Peran lintas sektor, seperti sektor Pendidikan dan sanitasi juga sangat penting. Pendidikan MHM di sekolah dan komunitas dapat meningkatkan pemahaman siswa dan orang tua tentang pentingnya kebersihan yang benar dan rujukan tempat yang aman untuk MHM (Umniyati et al., 2025). Dengan demikian, MHM harusnya dipandang sebagai program kesehatan komunitas yang terintegrasi dengan berbagai layanan dan strategi Pembangunan sosial (Sommer et al., 2021; WHO, 2023).

C. Determinan Sosial dan Hambatan Terhadap Pelaksanaan MHM di Komunitas

Determinan sosial kesehatan berperan penting dalam praktik MHM, kondisi ekonomi, sosial dan structural menentukan Perempuan dan remaja putri dapat mengakses informasi, produk dan fasilitas pendukung perawatan menstruasi yang aman dan nyaman (Marmot et al., 2020; Hennegen et al., 2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Perempuan dan remaja putri dalam mengakses produk dan fasilitas menstruasi yang aman dan nyaman Adalah factor ekonomi, Tingkat Pendidikan dan status sosial Perempuan. Perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung menggunakan bahan tidak layak yang dapat meningkatkan risiko infeksi.

Norma budaya dan agama di beberapa daerah juga memandang menstruasi sebagai sesuatu yang tabu atau tidak suci, sehingga membatasi informasi, edukasi dan memperkuat stigma yang berdampak pada praktik MHM yang tidak aman (Bobel et al., 2020; Sommer et al., 2021). Keadaan ini membatasi masuknya informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Stigma tentang menstruasi ini juga berdampak terhadap kesehatan mental Perempuan.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan fasilitas sanitasi yang responsive gender, termasuk kurangnya toilet terpisah, air bersih dan tempat pembuangan

limbah menstruasi di sekolah dan ruang publik (UNICEF & WHO, 2021; Hennegan et al., 2020). Banyak fasilitas umum dan sekolah tidak menyediakan toilet terpisah, air bersih atau tempat pembuangan pembalut yang memadai, sehingga menyulitkan dalam praktik MHM.

Kurangnya integrasi MHM dalam pelayanan kesehatan primer juga menjadi tantangan, Dimana isu menstruasi belum diposisikan sebagai bahan integral dari program kesehatan ibu, remaja dan kesehatan reproduksi berbasis komunitas (WHO, 2023; UNFPA, 2021). MHM belum diprioritaskan dalam program kesehatan ibu dan anak maupun kesehatan remaja, sehingga kadang terlewatkan dalam intervensi promotive dan preventif.

Ketimpangan informasi antara daerah urban dan rural juga semakin memperbesar kesenjangan pelaksanaan MHM, terutama karena keterbatasan tenaga kesehatan dan akses terhadap media informasi yang masih sangat terbatas di daerah pedesaan.

Memahami determinan dan hambatan ini penting sebagai dasar perancangan intervensi MHM yang kontekstual, berkeadilan gender dan berkesinambungan. Khususnya dalam kerangka promosi kesehatan berbasis komunitas (marmot et al., 2020; WHO, 2023).

D. Intervensi Edukasi dan Pemberdayaan MHM Berbasis Komunitas

Edukasi kebersihan menstruasi merupakan strategi utama dalam meningkatkan pelaksanaan MHM di Tingkat komunitas, pengetahuan yang baik berhubungan dengan pelaksanaan kebersihan menstruasi yang lebih aman, sikap positif terhadap tubuh dan penurunan stigma tentang menstruasi (Hennegan et al., 2021; Sommer et al., 2020). Edukasi yang efektif juga harus memperhatikan usia, budaya dan tingkat literasi sasaran. Pendekatan partisipatif terbukti lebih efektif dibandingkan metode satu arah.

Program berbasis sekolah dan komunitas yang melibatkan remaja putri, orang tua dan tokoh masyarakat dapat membantu menormalkan diskusi tentang menstruasi dan membangun lingkungan sosial yang suportif bagi pelaksanaan MHM (UNESCO, 2021; UNICEF, 2022). Keterlibatan laki-laki dan remaja putra juga penting mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan sosial.

Pemberdayaan di komunitas melalui pelatihan kader kesehatan memungkinkan penyampaian informasi yang berkelanjutan dan kontekstual, serta memperkuat kepemilikan program oleh Masyarakat sehingga intervensi MHM dapat berkelanjutan (Geoge et al., 2021; WHO, 2023). Kader dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan pelaksanaan MHM yang aman dan bermanfaat.

Peningkatan akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau juga merupakan intervensi yang perlu dilakukan, baik melalui subsidi, distribusi berbasis komunitas maupun inisiatif produksi local yang sensitive budaya dan ekonomi (UNFPA, 2021; Kuhlmann et al., 2022). Produksi local pembalut kain atau distribusi produk menstruasi yang disubsidi dapat menjadi Solusi inisiatif di komunitas yang berpenghasilan rendah.

Aspek lingkungan haru dipertimbangkan melalui edukasi pengelolaan limbah menstruasi dan promosi produk daur ulang (dapat digunakan berulang kali), ini berhubungan dengan peningkatan perhatian global terhadap dampak limbah pembalut sekali pakai terhadap kesehatan lingkungan (UNEP, 2021; kaur et al., 2022). Pendekatan ini dapat mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus kesehatan Perempuan.

Jadi, intervensi MHM berbasis komunitas seharusnya bersifat komprehensif, mengintegrasikan edukasi, pemberdayaan, akses sumber daya dan perubahan norma sosial untuk tercapainya dampak kesehatan reproduksi yang berkelanjutan (Sommer et al, 2021: WHO, 2023).

E. Peran Tenaga Kesehatan Interprofesional Dalam Pendekatan Holistik MHM

Pendekatan dalam Pelaksanaan MHM menuntut keterlibatan lintas profesi kesehatan, ini disebabkan karena isu menstruasi tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis saja tetapi juga mencakup dimensi psikososial, budaya, lingkungan dan sistem kesehatan. Kolaborasi interprofessional menjadi dasar penting dalam meastikan bahwa intervensi MHM di komunitas bersifat komprehensif, berkelanjutan dan responsive terhadap kebutuhan individu sepanjang siklus hidup Perempuan. Model kolaborasi interprofessional saat ini mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi, khususnya pada isu yang kompleks dan multidimensional seperti MHM (WHO, 2020; nReeves et al., 2021).

Bidan memiliki peran penting dalam pendekatanholistik MHM karena kedekatan Bidan dengan Perempuan dan komunitas, khususnya pada fase remaja, kehamilan, nifas dan masa reproduktif. Bidan berperan sebagai pendidik, konselor serta advokat kesehatan reproduksi yang sensitive terhadap konteks budaya dan gender. Edukasi menstruasi yang diberikan oleh bidan terbukti meningkatkan literasi kesehatan, menurunkan stigma terhadap menstruasi dan mendorong praktik kebersihan menstruasi yang aman di tingkat komunitas (Sommer et al., 2021: UNFPA, 2022).

Perawat komunitas berkontribusi signifikan dalam penguatan MHM melalui pendekatan promotive dan prefentif berbasis keluarga dan komunitas. Peran perawat mencakup pemantauan pelaksanaan kebersihan menstruasi, deteksi dini

masalah kesehatan menstruasi seperti infeksi saluran reproduksi dan penguatan dukungan psikososial bagi remaja putri dan Perempuan dewasa. Beberapa penelitian menunjukkan keterlibatan perawat dalam program kesehatan reproduksi berbasis komunitas dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan kebersihan menstruasi dan memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat (Hennegan et al., 2021; George et al., 2022).

Apoteker memiliki peran yang tidak kalah strategisnya dalam memastikan akses yang aman dan rasional terhadap produk serta terapi pendukung MHM. Apoteker tidak hanya berperan dalam penyediaan pembalut, obat Pereda nyeri haid, suplemen tetapi juga memberikan edukasi penggunaan produk menstruasi yang aman, ramah kesehatan dan berkelanjutan. Selain itu, dalam pendekatan holistic apoteker berkontribusi dalam pencegahan penggunaan obat yang tidak rasional untuk mengatasi dimenore atau gangguan menstruasi lainnya, yang sering terjadi akibat kurangnya edukasi kesehatan (FIP, 2021; WHO, 2023).

Ahli gizi berperan penting dalam aspek nutrisi sebagai determinan biologis kesehatan menstruasi. Status gizi yang buruk, seperti anemia defisiensi besi atau kekurangan energi kronis, sangat berkaitan dengan gangguan siklus menstruasi dan penurunan kualitas hidup Perempuan. Dalam pendekatan MHM yang holistic, ahli gizi berkontribusi melalui edukasi gizi seimbang, intervensi suplemen zat besi, dan penguatan pola makan sehat berbasis pangan local. Integrasi edukasi gizi dalam program MHM komunitas terbukti dapat meningkatkan kesehatan menstruasi dan kapasitas fungsional Perempuan (UNICEF, 2021; Christian et al, 2023).

Kolaborasi interprofesioanl dalam MHM memerlukan mekanisme koordinasi yang jelas, termasuk komunikasi efektif, pembagian peran yang terstruktur, dan perencanaan intervensi berbasis kebutuhan komunitas. Model kolaoratif yang melibatkan bidan, perawat, apoteker dan ahli gizi terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan sectoral karena mampu menjawab berbagai determinan kesehatan menstruasi secara simultan. Pendekatan ini sesuai dengan kerangka *primary health care* dan *people-centered care* yang direkomendasikan oleh WHO (WHO, 2020; Reeves et al, 2021).

Peran interprofessional dalam pendekatan holistic MHM secara keseluruhan merupakan strategi kunci untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi Perempuan di komunitas. Kerjasama lintas profesi memungkinkan integrasi aspek edukasi, mpelayanan kllinis, dukungan psikososial dan pengauatan system kesehatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan, kurikulum Pendidikan kesehatan, serta program komunitas perlu secara eksplisit memasukan kolaborasi interprofessional sebagai pilar utama dalam implementasi MHM yang adil dan inklusif (Sommer et al., 2021; UNFPA, 2022); WHO, 2023).

F. Dampak MHM Pada Kesehatan, Pendidikan dan Kualitas Hidup

MHM yang tidak adekuat akan berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik Perempuan, khususnya kesehatan reproduksi dan saluran genitourinaria. Kebersihan menstruasi yang buruk, seperti penggunaan pembalut yang tidak bersih atau keterbatasan akses air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan risiko infeksi saluran reproduksi dan infeksi saluran kemih. Bukti empiris menunjukkan bahwa Perempuan dan remaja putri yang mengalami keterbatasan MHM memiliki prevalensi keluhan kesehatan reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki akses MHM yang memadai (Hennegan et al, 2021; WHO, 2022).

Selain dampak fisik, MHM juga berpengaruh terhadap kesehatan mental dan psikososial. Stigma, rasa malu dan ketakutan mengalami kebocoran darah menstruasi di ruang public dapat memicu stress, kecemasan serta penurunan rasa percaya diri. Studi kualitatif dan kuantitatif, menunjukkan bahwa ketidakamanan dalam mengelola menstruasi berhubungan dengan peningkatan distress psikologi dan rendahnya kesejahteraan subjektif pada remaja putri dan Perempuan dewasa (Critchley et al., 2021; Sommer et al, 2021) Oleh karena itu, MHM menjadi isu kesehatan mental yang sering terabaikan dalam layanan kesehatan reproduksi pada umumnya.

Dampak MHM terhadap Pendidikan, khususnya bagi remaja putri, antara lain keterbatasan fasilitas sanitasi di sekolah, kurangnya edukasi menstruasi dan absensi akibat nyeri atau rasa malu menyebabkan meningkatnya ketidakhadiran sekolah atau kerja selama periode menstruasi. Kondisi ini memberi kontribusi terhadap kesenjangan Pendidikan berbasis gender dan berpotensi mempengaruhi capaian akademik jangka Panjang. UNESCO dan UNICEF melaporkan bahwa intervensi MHM berbasis sekolah dapat secara signifikan menurunkan angka ketidakhadiran dan meningkatkan partisipasi belajar remaja putri (UNICEF, 2021; UNESCO, 2022).

Pada konteks kualitas hidup, MHM berperan penting dalam menjaga partisipasi sosial dan produktivitas Perempuan. Perempuan yang tidak memiliki akses terhadap produk menstruasi yang aman dan fasilitas sanitasi yang layak cenderung membatasi aktivitas sehari-hari, termasuk bekerja, berinteraksi sosial dan berpartisipasi dalam kegiatan di komunitas. Hasil penelitian menegaskan bahwa MHM yang memadai berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan partisipasi ekonomi Perempuan, terutama di komunitas berpenghasilan rendah (Benshaul-Tolonen et al., 2021; Hennegan et al., 2023).

Dampak MHM juga bersifat interseksional yang dipengaruhi oleh usia, status sosial ekonomi, disabilitas dan lokasi geografis. Perempuan dewasa dan remaja putri disabilitas serta Perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan atau daerah

tertinggal menghadapi risiko dampak negative MHM yang lebih besar. Beberapa hasil penelitiabn menekankan bahwa ketidaksetaraan ini memperburuk kerentanan terhadap kesehatan, sehingga pendekatan MHM perlu dirancang secara sensitive dan inklusif terhadap keragaman kebutuhan kelompok sasaran (Wilbur et al., 2021; Sommer dan Sahin, 2022).

Pendekatan secara holistic MHM yang terdiri dari edukasi, akses produk, perbaikan fasilitas WASH, serta dukungan psikososial terbukti mampu meitigasi dampak negative tersebut secara signifikan. Program MHM berbasis komunitas yang terintegrasi dengan layanan kesehatan primer menunjukkan perbaikan pada indicator kesehatan menstruasi, kehadiran di sekolah dan kesejahteraan Perempuan. Bukti-bukti ini menguatkan pentingnya MHM sebagai intervensi promotive dan preventif yang berdampak luas terhadap Pembangunan sumber daya manusia (WHO, 2022; UNFPA, 2023).

Secara keseluruhan, dampak MHM terhadap kesehatan, Pendidikan dan kualitas hidup Perempuan menegaskan bahwa isu menstruasi bukan sekedar persoalan kebersihan individu, melainkan isu kesehatan masyarakat dan keadilan sosial. Investasi pada MHM merupakan investasi strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan Perempuan, =memperkuat kesetaraan gender dan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, MHM perlu diintegrasikan secara sistimatis dalam kebijakan kesehatan reproduksi, Pendidikan dan Pembangunan komunitas melalui pen dekatan interprofessional dan lintas sektor (Sommer et al, 2021; WHO, 2023).

G. Kebijakan, Advokasi dan Arah Pengembangan Penelitian MHM

Kebijakan public memegang peran strategis dalam memastikan MHM diakui sebagai bagian integral dari kesehatan reproduksi dan kesehatan Masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, WHO menegaskan Bahwa MHM bukan hanya isu teknis sanitasi, tetapi juga isu hak asasi manusia, kesetaraan gender dan keadilan sosial. Integrasi MHM ke dalam kebijakan kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial menjadi prasyarat untuk menjamin akses yang adil terhadap informasi, produk menstruasi dan fasilitas sanitasi yang layak bagi seluruh Perempuan dan remaja putri (WHO, 2022; *United Nations Human Rights Council*, 2021).

Pada tingkat nasional, kebijakan MHM umumnya terintegrasi secara parsial dalam program kesehatan reproduksi, gizi dan WASH, tetapi belum selalu dirumuskan secara eksplisit dan komprehensif. Studi kebijakan menunjukkan bahwa ketiadaan kerangka kebijakan yang jelas sering menyebabkan fragmentasi program, keterbatasan pendanaan serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, pengarusutamaan MHM dalam kebijakan kesehatan primer dan system pelayanan

kesehatan komunitas menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program (Sommer et al, 2021; UNICEF, 2021).

Advokasi MHM berperan penting dalam mendorong perubahan kebijakan dan norma sosial yang masih menstigmatisasi menstruasi. Upaya advokasi berbasis bukti, yang melibatkan tenaga kesehatan, akademisi, organisasi Masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lokal terbukti efektif dalam meningkatkan perhatian pembuat kebijakan terhadap isu menstruasi. Pendekatan advokasi yang menekankan dampak MHM terhadap kesehatan, Pendidikan dan produktivitas Perempuan dapat memperkuat legitimasi MHM sebagai prioritas Pembangunan kesehatan (Hennagen et al., 2021; UNFPA, 2022). Peran tenaga kesehatan dalam advokasi MHM menjadi sangat penting dalam pendekatan holistic dan interprofessional. Bidan, perawat, apoteker dan ahli gizi tidak hanya bertindak sebagai pemberi layanan tetapi juga sebagai agen perubahan yang menyuarakan kebutuhan komunitas kepada pembuat kebijakan. Keterlibatan tenaga kesehatan dalam advokasi berbasis komunitas mampu meningkatkan akseptabilitas kebijakan MHM dan memastikan bahwa kebijakan tersebut responsive terhadap konteks sosial dan budaya lokal (Reeves et al., 2021; WHO, 2023).

Arah pengembangan MHM ke depan menuntut pendekatan yang lebih inovatif, inklusif dan berkelanjutan, dengan mengembangkan produk menstruasi ramah lingkungan, integrasi teknologi digital untuk edukasi menstruasi, dan pendekatan berbasis siklus hidup Perempuan menjadi tren terpenting dalam literatur terkini. Penguatan riset dalam implementasi MHM juga diperlukan untuk memastikan intervensi yang dikembangkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan komunitas yang beragam (Benshaul-Tolonen et al., 2021; Sommer & Sahin, 2022). Pengarusutamaan MHM juga perlu diselaraskan dengan kerangka Pembangunan global, khususnya tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs). MHM berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDG 3 (kehidupan yang sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan berkualitas), SDG 5 (kesetaraan gender), dan SDG 6 (air bersih dan sanitasi). Pendekatan kebijakan yang lintas sektor dan berbasis SDGs memungkinkan sinergi antarprogram dan optimalisasi sumber daya dalam pengembangan MHM di komunitas (UNESCO, 2022; WHO, 2022).

Kebijakan, advokasi dan arah pengembangan MHM merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan menstruasi yang bermartabat dan berkeadilan. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat dan advokasi berkelanjutan maka intervensi MHM berisiko bersifat sporadic dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan komitmen politik, kolaborasi lintas profesi dan integrasi MHM dalam system kesehatan dan Pembangunan komunitas menjadi Langkah strategis menuju

peningkatan kualitas hidup Perempuan secara menyeluruh (Sommer et al. 2021; UNFPA, 2023; WHO, 2023).

H. Simpulan

Menstrual Hygiene Management (MHM) merupakan isu kesehatan reproduksi yang multidimensional dan strategis, karena berkaitan erat dengan kesehatan fisik dan mental, Pendidikan, produktivitas serta kualitas hidup Perempuan di komunitas. Pendekatan holistic yang mengintegrasikan intervensi edukasi, keterlibatan komunitas, kolaborasi tenaga kesehatan interprofessional, meliputi: bidan, perawat, apoteker dan ahli gizi. Menjadi kunci dalam mengatasi determinan sosial, budaya dan sistemik yang mempengaruhi pelaksanaan MHM. Pengarusutamaan MHM dalam kebijakan kesehatan reproduksi, Pendidikan dan WASH disertai advokasi berbasis bukti dan inovasi berkelanjutan merupakan Langkah esensial untuk mewujudkan pengelolaan menstruasi yang bermartabat, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan.

I. Referensi

- Benshaul-Tolonen, A., Zulaika, G., Nyothach, E., Mason, L., Obor, D., & Phillips-Howard, P. A. (2021). Pupil absenteeism, measurement, and menstruation: Evidence from western Kenya. *Journal of Adolescent Health, 68*(3), 555–563. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.07.018>
- Christian, P., Smith, E. R., & Lee, S. E. (2023). Nutrition and women's health across the life course. *The Lancet, 401*(10379), 1147–1160. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)02500-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02500-4)
- Critchley, K. A., Gibbs, A., & Hennegan, J. (2021). Menstrual health and mental health: A systematic review. *Social Science & Medicine, 280*, 114041. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114041>
- Federation Internationale Pharmaceutique. (2021). *Pharmacists' role in sexual and reproductive health*. FIP.
- George, R., Ramasubramanian, D., & Paul, J. (2022). Community-based menstrual health interventions: A systematic review. *BMC Public Health, 22*, 1894. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14201-9>
- Hennegan, J., Winkler, I. T., Bobel, C., Keiser, D., Hampton, J., Larsson, G., Chandra-Mouli, V., & Plesons, M. (2021). Menstrual health: A definition for policy, practice, and research. *Sexual and Reproductive Health Matters, 29*(1), 1911618. <https://doi.org/10.1080/26410397.2021.1911618>
- Hennegan, J., Shannon, A. K., Rubli, J., Schwab, K. J., & Melendez-Torres, G. J. (2023). Women's and girls' experiences of menstruation in low- and middle-income countries. *BMJ Global Health, 8*(2), e010606. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-010606>
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2021). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews, 6*, CD000072. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub4>
- Sommer, M., & Sahin, M. (2022). Overcoming the taboo: Advancing the global agenda for menstrual hygiene management. *American Journal of Public Health, 112*(S2), S110–S116. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2021.306667>
- Sommer, M., Zulaika, G., Schmitt, M., Gruer, C., & Sutherland, C. (2021). Monitoring menstrual health and hygiene: Measuring progress. *The Lancet Global*

Health, 9(10), e1333–e1334. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00355-2](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00355-2)

UNESCO. (2022). *Puberty education and menstrual hygiene management*. UNESCO Publishing.

UNICEF. (2021). *Guidance on menstrual health and hygiene*. UNICEF.

United Nations Population Fund. (2022). *Menstrual health and human rights*. UNFPA.

United Nations Population Fund. (2023). *Seeing the unseen: The case for action on menstrual health*. UNFPA.

World Health Organization. (2020). *Framework for action on interprofessional education and collaborative practice*. WHO.

World Health Organization. (2022). *Guidelines on sanitation and health*. WHO.

World Health Organization. (2023). *Global strategy on women's, children's and adolescents' health*. WHO.

J. Glosarium

Absensi Sekolah = Ketidakhadiran peserta didik di sekolah yang dalam konteks kesehatan menstruasi sering berkaitan dengan nyeri haid, keterbatasan fasilitas sanitasi, atau stigma menstruasi.

Advokasi Kesehatan = Upaya sistematis untuk mempengaruhi kebijakan, norma sosial, dan alokasi sumber daya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk advokasi terkait Menstrual Hygiene Management.

Air Bersih = Air yang memenuhi standar kesehatan untuk keperluan higiene, termasuk mencuci tubuh dan membersihkan alat menstruasi.

Anemia Defisiensi Besi = Kondisi kekurangan hemoglobin akibat rendahnya kadar zat besi dalam tubuh yang dapat memperburuk gangguan menstruasi dan menurunkan produktivitas perempuan.

Dismenore = Nyeri haid yang dirasakan sebelum atau selama menstruasi yang dapat mempengaruhi aktivitas harian dan kualitas hidup.

Edukasi Menstruasi = Proses pemberian informasi dan pembelajaran mengenai fisiologi menstruasi, praktik kebersihan, dan kesehatan reproduksi secara benar, ilmiah, dan tidak diskriminatif.

Evidence-Based Practice (EBP) = Pendekatan praktik profesional yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian praktisi, serta nilai dan kebutuhan individu atau komunitas.

Higiene Personal = Praktik menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan, termasuk kebersihan selama periode menstruasi.

Infeksi Saluran Reproduksi = Infeksi yang terjadi pada organ reproduksi perempuan akibat bakteri, jamur, atau virus, yang risikonya meningkat akibat praktik kebersihan menstruasi yang tidak adekuat.

Interprofessional Collaboration = Kerja sama lintas profesi kesehatan untuk memberikan pelayanan komprehensif dan berkesinambungan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Kader Kesehatan = Anggota masyarakat yang dilatih untuk membantu penyampaian informasi kesehatan dan mendukung pelaksanaan program kesehatan berbasis komunitas.

Kesetaraan Gender = Kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, akses, partisipasi, dan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Kesehatan Reproduksi = Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi sepanjang siklus hidup manusia.

Kualitas Hidup = Persepsi individu terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Limbah Menstruasi = Sisa produk menstruasi yang telah digunakan dan memerlukan pengelolaan yang aman agar tidak berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan.

Menarche = Menstruasi pertama yang dialami seorang perempuan sebagai tanda dimulainya masa reproduktif.

Menstrual Hygiene Management (MHM) = Kemampuan perempuan dan remaja putri untuk mengelola menstruasi secara bersih, aman, dan bermartabat, termasuk akses terhadap produk menstruasi, air bersih, fasilitas sanitasi, serta dukungan sosial.

Norma Sosial = Aturan tidak tertulis dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku individu, termasuk pandangan dan sikap terhadap menstruasi.

Perawatan Kesehatan Menstruasi = Serangkaian tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan selama menstruasi guna mencegah gangguan kesehatan reproduksi.

Perempuan Usia Reproduksi = Perempuan yang berada pada rentang usia subur dan mengalami siklus menstruasi secara fisiologis.

Primary Health Care = Pendekatan pelayanan kesehatan dasar yang menekankan akses universal, pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Produk Menstruasi = Alat yang digunakan untuk menyerap darah menstruasi, seperti pembalut sekali pakai, pembalut kain, tampon, dan menstrual cup.

Sanitasi = Penyediaan fasilitas dan layanan untuk pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan, termasuk fasilitas toilet dan pembuangan limbah menstruasi.

Stigma Menstruasi = Pandangan negatif, rasa malu, atau diskriminasi terhadap menstruasi yang dapat menghambat akses informasi dan praktik kebersihan menstruasi yang sehat.

Sustainable Development Goals (SDGs) = Agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana MHM berkontribusi pada tujuan kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan sanitasi.

Wanita Usia Subur (WUS) = Perempuan yang berada pada rentang usia reproduktif dan berpotensi mengalami kehamilan.

WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) = Pendekatan terpadu yang mencakup penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan praktik higiene untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

CHAPTER 3

PENATALAKSANAAN GANGGUAN REPRODUKSI: PCOS, ENDOMETRIOSIS, INFERTILITAS DARI PERSPEKTIF INTERPROFESI

Khafidhiyah Nur Insaniyah, S.Tr.Keb., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Gangguan reproduksi merupakan kondisi kesehatan yang ditandai oleh gangguan fungsi, regulasi hormonal, struktur anatomi, atau proses biologis sistem reproduksi, sehingga menghambat kemampuan reproduksi normal. Gangguan reproduksi merupakan salah satu tantangan kesehatan penting bagi perempuan usia reproduktif. Gangguan-gangguan ini tidak hanya menyebabkan ketidaksuburan tetapi juga berkontribusi pada masalah kesehatan jangka panjang serta kualitas hidup yang menurun. Kondisi gangguan reproduksi seperti endometriosis, PCOS, atau masalah pada tuba falopi dapat menyebabkan infertilitas. *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS), endometriosis, dan infertilitas, secara signifikan memengaruhi kesehatan reproduksi dan kesejahteraan secara keseluruhan pada perempuan (Amalia et al., 2025; Azam et al., 2025).

Prevalensi PCOS diperkirakan 9,2% di seluruh dunia atau sekitar 182 juta perempuan pada usia 15–49 tahun di seluruh dunia menderita PCOS (Y. Feng et al., 2025; Salari et al., 2024). Sedangkan endometriosis secara global diperkirakan memengaruhi sekitar 6–10% perempuan usia subur, dengan jumlah penderita mencapai 176–190 juta perempuan di seluruh dunia. Tingginya prevalensi ini menunjukkan bahwa PCOS dan endometriosis merupakan masalah kesehatan reproduksi yang memerlukan penatalaksanaan yang komprehensif serta berkelanjutan (Insaniyah et al., 2023).

Gangguan reproduksi seperti PCOS, endometriosis, dan infertilitas memberikan dampak multidimensional yang meliputi aspek medis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Secara medis, PCOS berkaitan dengan disfungsi ovulasi, gangguan metabolik, serta peningkatan risiko penyakit kronis, sementara endometriosis ditandai oleh proses inflamasi kronis yang menyebabkan nyeri pelvis, dismenore berat, dan infertilitas, yang secara signifikan menurunkan kualitas hidup perempuan usia subur. Dari sisi psikologis, perempuan dengan PCOS, endometriosis, maupun infertilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi, kecemasan, stres kronis, serta gangguan citra diri akibat gejala fisik dan

ketidakpastian terhadap fungsi reproduksi. Dampak sosial juga tidak dapat diabaikan, karena gangguan reproduksi sering dikaitkan dengan stigma, tekanan budaya, konflik relasi, dan isolasi sosial, terutama di masyarakat yang memandang kemampuan reproduksi sebagai bagian penting dari identitas perempuan. Selain itu, kondisi-kondisi ini menimbulkan beban ekonomi yang signifikan karena memerlukan perawatan jangka panjang, biaya pengobatan, penurunan produktivitas kerja, serta tingginya biaya penanganan infertilitas dan teknologi reproduksi berbantu. Kompleksitas dampak tersebut menegaskan bahwa gangguan reproduksi pada perempuan memerlukan pendekatan penatalaksanaan yang komprehensif dan kolaboratif lintas profesi untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal (Dubé-Zinatelli et al., 2025; Fauziah, 2025; Maulenkul et al., 2024; Moutzouroulia et al., 2025).

Pendekatan *Interprofessional Collaborative Practice* (IPCP) atau interprofesi sangat penting dalam penatalaksanaan gangguan reproduksi karena kondisi-kondisi tersebut bersifat kompleks, multifaktorial, dan memerlukan keterlibatan berbagai disiplin ilmu untuk menjamin hasil layanan yang komprehensif dan efektif. Interprofesi melibatkan kerja sama yang terkoordinasi antara tenaga kesehatan dari berbagai profesi untuk menyediakan perawatan yang lebih terintegrasi, memaksimalkan kualitas layanan, serta meningkatkan hasil klinis pasien. Kolaborasi interprofesi telah terbukti menurunkan kesalahan klinis, memperbaiki efektivitas diagnosis dan strategi terapi, serta mempercepat pengambilan keputusan pada kasus yang membutuhkan perawatan lintas disiplin seperti gangguan reproduksi (Dashti et al., 2025; Esperat et al., 2023).

B. Konsep Interprofesi

1. Definisi Interprofesi

Interprofesi merupakan konsep yang menggambarkan keterlibatan berbagai profesi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Sedangkan *Interprofessional Collaborative Practice* (IPCP) merupakan bentuk implementatif dari interprofesi dalam praktik klinik, di mana tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang bekerja secara kolaboratif, terkoordinasi, dan berpusat pada pasien untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal (James et al., 2024; Kamil et al., 2025).

Interprofesi dalam konteks pelayanan kesehatan akan berpusat pada kerja sama yang terkoordinasi dan saling bergantung untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan pasien, keluarga, dan komunitas. Dalam praktiknya, interprofesi tidak sekadar bekerja berdampingan,

tetapi melibatkan komunikasi efektif, pengambilan keputusan bersama, serta integrasi kompetensi profesi yang berbeda untuk mencapai tujuan layanan kesehatan yang optimal. Kolaborasi ini merupakan strategi penting untuk menjawab kompleksitas masalah kesehatan yang multi-dimensional, seperti gangguan reproduksi, dengan menggabungkan keahlian klinis, edukasi, dukungan psikososial, serta faktor determinan kesehatan lain secara terintegrasi (James et al., 2024).

2. Prinsip Interprofesi

Pendekatan interprofesi dalam pelayanan kesehatan didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang bertujuan untuk mewujudkan kolaborasi lintas profesi yang efektif dan berpusat pada pasien. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk mengoptimalkan kerja sama antar tenaga kesehatan yang berbeda latar belakang serta untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Menurut (Bouton et al., 2023), prinsip interprofesi antara lain yaitu:

a. Kerja Sama yang Terkoordinasi

Interprofesi menuntut anggota tim kesehatan dari berbagai profesi untuk bekerja secara bersama dan berbagi tujuan pelayanan pasien, bukan bekerja sendiri-sendiri, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan dilakukan sebagai suatu kesatuan.

b. Penghargaan terhadap Peran Profesi Lain

Dalam kolaborasi interprofesi, setiap anggota tim harus menghormati peran, keahlian, serta kontribusi dari profesi lain, tanpa dominasi atau hierarki yang menghambat partisipasi tim.

c. Komunikasi Efektif dan Terbuka

Komunikasi antar tim yang jelas, terbuka, dan berkelanjutan sangat penting untuk koordinasi layanan yang efektif. Komunikasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi klinis dan non-klinis secara akurat, memperjelas tanggung jawab setiap profesi, dan mendukung pengambilan keputusan bersama.

d. Kepemimpinan Kolaboratif/Koordinator Tim

Interprofesi menuntut struktur kerja yang memfasilitasi koordinasi tim secara dinamis, termasuk kepemimpinan yang mendukung kolaborasi antarprofesi, pembagian tugas yang jelas, serta pemecahan masalah secara kolektif untuk menghasilkan solusi yang terbaik bagi pasien.

e. Fokus pada Kebutuhan Pasien

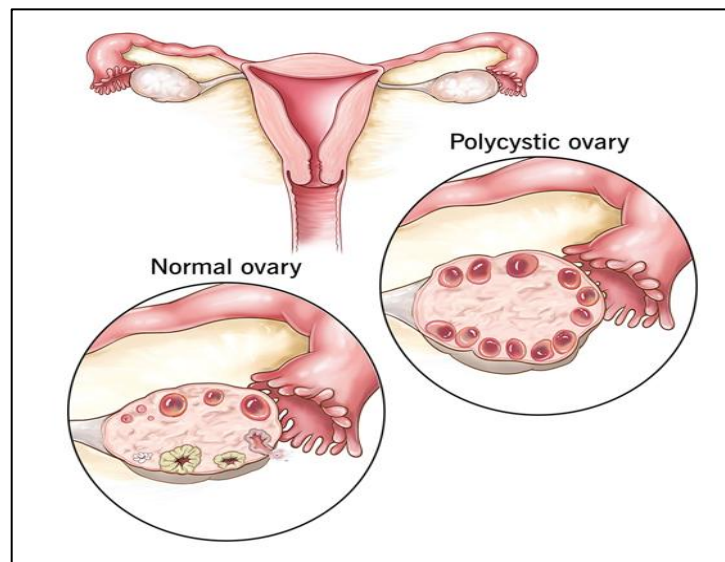
Prinsip interprofesi juga mencakup pelayanan yang berorientasi pada pasien, di mana pasien dan keluarga dilibatkan dalam proses perencanaan dan

pengambilan keputusan pelayanan kesehatan sehingga pelayanan menjadi lebih sesuai kebutuhan pasien secara menyeluruh.

C. Penatalaksanaan Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) Secara Interprofesi

1. Konsep Dasar PCOS

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) digolongkan sebagai kelainan endokrin kompleks pada perempuan usia reproduksi yang ditandai oleh adanya hiperandrogenisme, gangguan ovulasi kronik, serta perubahan morfologi ovarium berupa ovarium polikistik yang sering terdeteksi melalui pemeriksaan ultrasonografi. Secara epidemiologis, PCOS diperkirakan menimpa sekitar 10–13% perempuan usia reproduktif di seluruh dunia dan merupakan salah satu penyebab utama anovulasi dan infertilitas pada perempuan usia subur (Cîrstoiu & Mehedinpu, 2023; Teede et al., 2023).



Gambar 3.1 Ilustrasi Ovarium Wanita Normal Dan Penderita PCOS

Sumber: Cleveland Clinic, "Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)"

Etiologi PCOS bersifat kompleks dan multifaktorial, diantaranya seperti genetik, disregulasi hormon, resistensi insulin, serta lingkungan termasuk gaya hidup dan obesitas. Disfungsi aksis hipotalamus-hipofisis-ovarium pada PCOS mengakibatkan meningkatnya frekuensi pelepasan hormon *Gonadotropin-Releasing Hormone* (GnRH) yang kemudian meningkatkan rasio *Luteinizing Hormone* (LH) terhadap *Follicle Stimulating Hormone* (FSH), sehingga memicu produksi androgen berlebih oleh ovarium. Kelebihan androgen inilah yang berperan dalam gejala klinis seperti hirsutisme, jerawat, dan gangguan pertumbuhan rambut, serta berkontribusi pada gangguan pematangan folikel ovarium dan ovulasi (Cîrstoiu & Mehedinpu, 2023).

Selain gejala reproduktif, PCOS juga memiliki komponen metabolik penting, yaitu resistensi insulin dan disfungsi metabolisme glukosa yang sering terdapat pada perempuan dengan PCOS. Kondisi resistensi insulin ini memperparah *hiperandrogenisme* karena insulin tinggi mengurangi produksi *Sex Hormone-Binding Globulin* (SHBG), sehingga meningkatkan kadar androgen bebas dalam sirkulasi. Komorbiditas jangka panjang yang terkait PCOS termasuk risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular yang harus dipantau secara rutin. Selain manifestasi klinis reproduktif dan metabolik, PCOS juga berdampak signifikan terhadap kesehatan psikologis dan kualitas hidup perempuan, yang berkontribusi terhadap beban sosial dan ekonomi jangka panjang, sehingga membutuhkan pendekatan penatalaksanaan berbasis kolaborasi interprofesi. (Su et al., 2025; Teede et al., 2023).

2. Diagnosis PCOS

Diagnosis PCOS didasarkan pada kriteria klinis dan penunjang yang telah distandarisasi secara internasional, dengan pedoman terbaru merekomendasikan penggunaan *Rotterdam Criteria*. Diagnosis PCOS dapat ditegakkan bila minimal dua dari tiga kriteria utama terpenuhi, diantaranya: (1) hiperandrogenisme, baik secara klinis (misalnya hirsutisme, jerawat) maupun biokimia (kadar androgen serum tinggi); (2) disfungsi ovulasi, yang ditandai oleh oligo- atau anovulasi yang biasanya tampak sebagai siklus menstruasi jarang atau tidak teratur; dan (3) morfologi ovarium polikistik pada ultrasonografi transvaginal, yang ditandai oleh banyak folikel antral atau volume ovarium yang meningkat. Diagnosis ini juga mensyaratkan pengecualian kondisi lain yang dapat menyerupai PCOS seperti gangguan adrenal, hipotiroidisme, atau hiperprolaktinemia. Saat ini pedoman terbaru mempertimbangkan penggunaan *anti-Müllerian hormone* (AMH) sebagai indikator sifat ovarium polikistik untuk membantu deteksi subfenotip PCOS (Cîrstoiu & Mehedințu, 2023).

3. Manajemen Penatalaksanaan PCOS

Penatalaksanaan PCOS menekankan strategi komprehensif dan terintegrasi yang mencakup manajemen gaya hidup, intervensi medis, serta pemantauan risiko kardiometabolik dan psikologis. Manajemen penatalaksanaan awal dimulai dengan pendekatan gaya hidup, termasuk pengembangan pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, serta dukungan perilaku untuk optimalisasi berat badan dan kesehatan metabolik. Intervensi gaya hidup ini penting untuk hampir semua perempuan dengan PCOS karena dapat memperbaiki resistensi insulin, mengurangi risiko diabetes tipe 2, dan mendukung regulasi siklus menstruasi dan ovulasi. Tidak ada satu jenis diet atau intensitas latihan yang secara konsisten superior dibandingkan lainnya; karenanya pendekatan harus individual,

berkelanjutan, dan disesuaikan dengan preferensi pasien untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil jangka panjang (Teede et al., 2023).

Manajemen medis PCOS mempertimbangkan tujuan klinis spesifik, seperti regulasi siklus menstruasi, penurunan hiperandrogenisme, atau peningkatan peluang ovulasi dan fertilitas. Terapi hormonal kombinasi seperti kontrasepsi oral sering direkomendasikan untuk mengatur siklus dan mengurangi gejala hiperandrogen seperti hirsutisme dan jerawat, sementara induksi ovulasi (misalnya letrozole atau klomifen) dipilih untuk perempuan yang ingin hamil. Selain itu, pemantauan terhadap faktor kardiometabolik —tekanan darah, profil lipid, dan status glikemik— harus dilakukan secara berkala karena perempuan dengan PCOS memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan metabolik. Seluruh langkah ini dilakukan melalui pendekatan interprofesi yang melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, dan tenaga kesehatan lain untuk memastikan perawatan yang komprehensif dan berpusat pada pasien (Teede et al., 2023).

4. Penatalaksanaan PCOS dari Perspektif Interprofesi

Penatalaksanaan PCOS memerlukan pendekatan interprofesi karena kompleksitas klinisnya yang melibatkan aspek reproduksi, metabolik, dan psikososial. Studi literatur tentang model perawatan PCOS menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai profesi kesehatan menghasilkan hasil yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan mono-profesi, khususnya dalam hal deteksi komorbiditas dan perencanaan terapi yang holistik dalam menangani manifestasi PCOS secara menyeluruh (Teede et al., 2023).

a. Dokter

Dokter spesialis seperti ginekologi atau endokrinologi, memegang peran penting sebagai titik awal kontak pasien dan koordinator utama dalam penatalaksanaan PCOS. Mereka bertanggung jawab dalam diagnosis, evaluasi kondisi kesehatan reproduksi, serta penilaian terhadap gejala klinis utama seperti gangguan ovulasi, hiperandrogenisme, dan ketidakteraturan siklus menstruasi. Selain itu, dokter spesialis juga memberikan edukasi penyuluhan awal, merujuk pasien ke profesional lain, serta mengelola terapi sesuai kebutuhan individual, termasuk pengobatan hormonal dan penatalaksanaan komorbiditas metabolik. Peran dokter sebagai koordinator tim multidisiplin menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai profesi dalam rangka memberikan layanan komprehensif bagi pasien PCOS (Ee, 2023).

b. Bidan

Bidan memiliki peran strategis dalam penatalaksanaan PCOS sebagai tenaga kesehatan lini depan yang berfokus pada promotif, preventif, dan

pemberdayaan perempuan. Dalam pendekatan interprofesi, bidan berperan dalam identifikasi dini gangguan siklus menstruasi dan gejala hiperandrogenisme, pemberian edukasi kesehatan reproduksi, serta konseling modifikasi gaya hidup yang meliputi pola makan, aktivitas fisik, dan manajemen stres sebagai terapi lini pertama PCOS. Intervensi yang dipimpin bidan (*midwife-led care*) terbukti dapat meningkatkan pengetahuan, self-efficacy, dan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan PCOS, sekaligus memperkuat koordinasi rujukan dengan dokter, sehingga mendukung asuhan yang holistik dan berpusat pada perempuan (Kusumawati & Wahyuni, 2025; Raja et al., 2025).

c. Perawat

Perawat memiliki peran sentral dalam pendidikan pasien, pengelolaan gejala sehari-hari, serta dukungan sistematis untuk pasien PCOS. Perawat juga berperan dalam memantau gejala seperti resistensi insulin, berat badan, dan kesejahteraan psikologis pasien, serta membantu koordinasi komunikasi antarprofesi untuk tindak lanjut yang terintegrasi. Selain itu, perawat dapat memfasilitasi pelaksanaan rencana perawatan bersama, termasuk pemantauan berkala (Alenezi et al., 2024).

d. Ahli Gizi

Peran ahli gizi dalam penatalaksanaan PCOS berperan terhadap modifikasi gaya hidup, termasuk diet dan aktivitas fisik, merupakan bagian dari terapi lini pertama untuk banyak pasien, terutama dalam konteks resistensi insulin dan manajemen berat badan. Ahli gizi berperan dalam melakukan penilaian nutrisi yang komprehensif, merancang rencana diet individual yang mempertimbangkan profil metabolik pasien, serta memberikan dukungan jangka panjang untuk perubahan gaya hidup. Peran ahli gizi dalam penatalaksanaan PCOS dapat membantu menurunkan risiko komorbiditas jangka panjang (Gautam et al., 2025).

e. Apoteker

Terapi PCOS sering melibatkan penggunaan berbagai obat seperti kontrasepsi hormonal, insulin sensitizer, dan agen induksi ovulasi. Apoteker dalam tim interprofesi berperan dalam mengidentifikasi dan mencegah *drug-related problems*, mengevaluasi regimen pengobatan untuk memastikan efektivitas dan keamanan, serta memberikan konseling obat yang jelas untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan mereka (Lebanova et al., 2025).

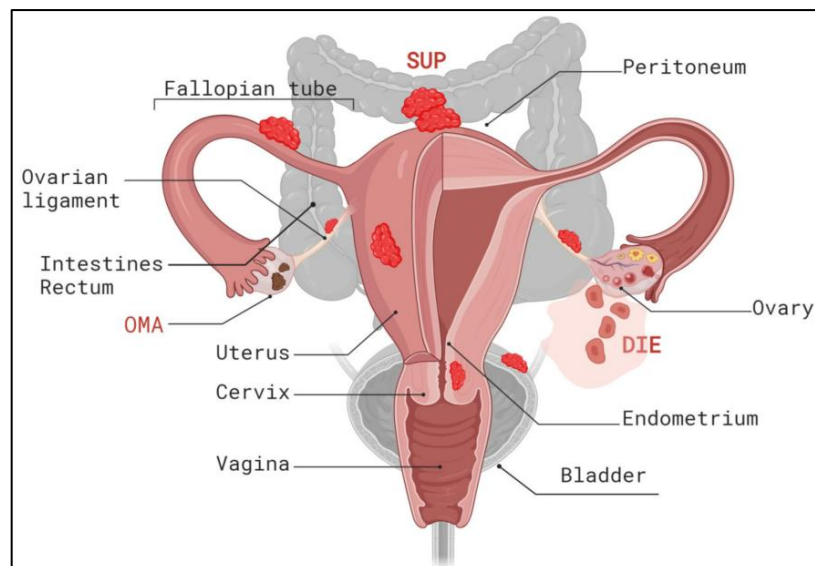
f. Psikolog

Wanita dengan PCOS juga sering berdampak pada kesehatan mental, termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan citra tubuh, karena gejala fisik dan tantangan reproduksi yang dialami pasien. Peran psikolog adalah memberikan dukungan emosional, terapi perilaku kognitif, konseling dukungan, dan strategi *coping* yang membantu pasien mengelola stres dan gangguan psikologis yang sering terjadi bersama PCOS (Percy et al., 2024).

D. Penatalaksanaan Endometriosis secara Interprofesi

1. Konsep Dasar Endometriosis

Endometriosis adalah gangguan ginekologi yang bergantung pada estrogen dan ditandai dengan adanya pertumbuhan abnormal dan disfungsi kelenjar, stroma, atau jaringan yang mirip endometrium di luar rongga uterus, seperti pada ovarium, tuba falopi, permukaan peritoneal, serta struktur panggul lainnya. Jaringan endometrium yang tumbuh secara ectopic ini mengalami siklus hormonal seperti endometrium normal, sehingga menyebabkan pendarahan berulang, inflamasi kronis, dan pembentukan jaringan parut di lokasi abnormal tersebut. Secara global, endometriosis diperkirakan memengaruhi sekitar 6–10% perempuan usia subur, dengan jumlah penderita mencapai 176–190 juta perempuan di seluruh dunia (Insaniyah et al., 2023; Monnin et al., 2023).



Gambar 3.2 Lokasi Lesi Endometriosis

Sumber: Adilbayeva & Kunz (2024)

Secara patofisiologis, endometriosis merupakan kondisi inflamasi multifaktorial di mana jaringan endometrium yang ectopic dapat berkembang

melalui beberapa mekanisme, termasuk retrograde menstruasi, transformasi metaplastik, serta kontribusi sel punca. Lesi endometriotik mempertahankan respons terhadap estrogen dan sering menunjukkan resistensi terhadap progesteron, yang memperkuat proliferasi jaringan dan pembentukan adhesi. Lingkungan mikro inflamasi juga didukung oleh aktivasi sitokin pro-inflamasi dan modulasi imun lokal, sehingga memperpanjang siklus inflamasi dan nyeri kronis pada area panggul. Jadi, endometriosis sangat bergantung pada hormon estrogen dalam mempertahankan dan memperbanyak lesi endometriotik, sementara respon inflamasi kronis memperburuk manifestasi klinisnya (Adilbayeva & Kunz, 2024).

Gejala endometriosis bersifat bervariasi dan seringkali tidak spesifik, sehingga berkontribusi terhadap keterlambatan diagnosis. Manifestasi klinis utama meliputi dismenore progresif, nyeri panggul kronis, dispareunia, dischezia, serta nyeri saat berkemih, yang umumnya memburuk seiring siklus menstruasi. Selain nyeri, endometriosis juga berhubungan dengan gangguan fertilitas, di mana sekitar 30–50% perempuan dengan endometriosis mengalami infertilitas. Beberapa pasien juga melaporkan gejala sistemik seperti kelelahan kronis, gangguan gastrointestinal, dan penurunan kualitas hidup akibat nyeri persisten serta dampak psikososial penyakit ini (Insaniyah et al., 2023).

2. Diagnosis Endometriosis

Standar emas dalam diagnosis endometriosis saat ini menggunakan laparoskopi dengan konfirmasi histopatologis, pendekatan non-invasif ini direkomendasikan untuk diagnosis awal guna mengurangi keterlambatan diagnosis. Gejala endometriosis yang bersifat heterogen dan tumpang tindih dengan gangguan ginekologi lain membuat diagnosis ditegakkan melalui kombinasi anamnesis klinis, pemeriksaan fisik, dan pencitraan, terutama ultrasonografi transvaginal dan MRI untuk mendeteksi lesi endometriosis dalam (*deep infiltrating endometriosis*). Panduan klinis terbaru menekankan pentingnya diagnosis berbasis gejala dan pencitraan sebagai bagian dari strategi manajemen yang lebih cepat dan berpusat pada pasien (Becker et al., 2022).

3. Manajemen Penatalaksanaan Endometriosis

Manajemen endometriosis mencakup penatalaksanaan yang bersifat multimodal, bertujuan meredakan gejala nyeri, meningkatkan kualitas hidup, dan menangani masalah infertilitas. Penatalaksanaan untuk nyeri yang berhubungan dengan endometriosis, pendekatan lini pertama meliputi analgesik seperti NSAID untuk gejala akut dan terapi hormonal seperti kontrasepsi kombinasi, progestogen, atau alat intrauterin levonorgestrel, yang dapat digunakan untuk menekan lesi dan mengurangi rasa sakit. Jika terapi hormonal tidak memadai,

pilihan lini berikutnya meliputi agonis atau antagonis GnRH, yang dikombinasikan dengan *add-back therapy* untuk mencegah efek samping osteopenia dan gejala hipoestrogenik. Dalam kasus yang tidak responsif terhadap terapi medis, intervensi bedah laparoskopik direkomendasikan untuk mengangkat lesi endometriotik atau melakukan *cystectomy* pada endometrioma ovarium, yang dapat membantu mengurangi nyeri kronis dan mencegah kekambuhan sekaligus memperbaiki kualitas hidup. Selain itu, pasien perlu diinformasikan mengenai kemungkinan pendekatan non-medikasi untuk meningkatkan kualitas hidup seperti pengelolaan stres, aktivitas fisik, fisioterapi dasar, dan dukungan psikososial (Becker et al., 2022).

4. Penatalaksanaan Endometriosis dari Perspektif Interprofesi

Penatalaksanaan endometriosis memerlukan pendekatan interprofesi karena kondisi ini bukan hanya manifestasi ginekologis semata, tetapi juga berdampak sistemik melalui nyeri panggul kronis, disfungsi organ panggul, gangguan fungsi seksual, serta penurunan kualitas hidup secara luas. Kolaborasi yang efektif melibatkan berbagai profesi kesehatan —seperti dokter spesialis ginekolog, bidan, perawat, fisioterapis, psikolog, dan ahli gizi— untuk menangani aspek klinis, psikologis, dan sosial pasien secara terpadu (Allaire et al., 2020; Becker et al., 2022).

a. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi berperan utama dalam diagnosis, penentuan stadium penyakit, dan penatalaksanaan medis maupun bedah endometriosis. Dokter spesialis memiliki peran mencakup evaluasi klinis, penggunaan modalitas pencitraan, pemberian terapi hormonal untuk kontrol nyeri dan progresivitas penyakit, serta tindakan bedah pada kasus tertentu seperti *deep infiltrating* endometriosis (Allaire et al., 2020).

b. Bidan

Bidan memiliki peran penting dalam deteksi dini gejala endometriosis, edukasi kesehatan reproduksi, serta konseling terkait nyeri haid abnormal dan kualitas hidup perempuan. Bidan berperan dalam pemberdayaan perempuan, memberikan informasi mengenai kondisi reproduksi, serta mengarahkan rujukan tepat waktu ke layanan spesialis. Dalam tim interprofesi, bidan berkontribusi pada aspek promotif dan preventif serta asuhan kesinambungan (Ugwumadu et al., 2017).

c. Perawat

Perawat berperan dalam manajemen nyeri, edukasi pasien, pemantauan respons terapi, dan dukungan berkelanjutan bagi perempuan dengan endometriosis. Perawat juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan

pengobatan, mengidentifikasi keluhan psikososial, serta memfasilitasi komunikasi antara pasien dan anggota tim kesehatan lainnya. Peran ini penting karena endometriosis merupakan penyakit kronis yang membutuhkan pemantauan jangka panjang dan pendekatan berpusat pada pasien (Allaire et al., 2020; Becker et al., 2022).

d. Ahli Gizi

Ahli gizi berkontribusi melalui intervensi nutrisi dan modifikasi gaya hidup untuk mendukung pengendalian inflamasi dan meningkatkan kesejahteraan pasien. Pendekatan nutrisi yang tepat dapat membantu mengurangi gejala, memperbaiki status metabolik, dan mendukung terapi medis (Becker et al., 2022).

e. Apoteker

Apoteker berperan dalam optimalisasi terapi farmakologis, pencegahan masalah terkait obat, serta edukasi penggunaan obat secara aman dan efektif. Dalam penatalaksanaan endometriosis yang sering melibatkan terapi jangka panjang, apoteker membantu meningkatkan kepatuhan pasien dan meminimalkan efek samping melalui pendekatan *pharmaceutical care* yang kolaboratif (Becker et al., 2022; Ugwumadu et al., 2017).

f. Psikolog / Psikiater

Psikolog atau psikiater berperan dalam menangani dampak psikologis endometriosis, seperti kecemasan, depresi, stres kronis, dan gangguan kualitas hidup. Pendekatan psikologis, termasuk *cognitive behavioral therapy* dan dukungan *coping*, membantu pasien mengelola nyeri kronis dan beban emosional penyakit. Peran ini sangat penting mengingat endometriosis sering berdampak multidimensional terhadap kehidupan perempuan (Ugwumadu et al., 2017).

g. Fisioterapis

Fisioterapis berperan dalam manajemen nyeri non-farmakologis, khususnya pada nyeri muskuloskeletal dan nyeri panggul kronis yang sering menyertai endometriosis. Intervensi seperti terapi dasar panggul, latihan postural, dan teknik relaksasi terbukti membantu menurunkan intensitas nyeri dan meningkatkan fungsi fisik. Kolaborasi fisioterapis dalam tim interprofesi mendukung pendekatan holistik terhadap nyeri kronis (Adilbayeva & Kunz, 2024).

E. Penatalaksanaan Infertilitas secara Interprofesi

1. Konsep Dasar Infertilitas

Infertilitas adalah kondisi medis dalam sistem reproduksi di mana pasangan gagal mencapai kehamilan setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa penggunaan kontrasepsi, sehingga menimbulkan tantangan bagi pasangan yang ingin memiliki keturunan. Prevalensi infertilitas terus menjadi perhatian global, dengan estimasi bahwa sekitar 17 % orang dewasa, atau sekitar 1 dari 6 pasangan usia reproduktif (J. Feng et al., 2025).

Infertilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa dikarenakan pada pasangan pria maupun wanita, serta oleh faktor gaya hidup dan lingkungan. Dari sisi pria, penyebab utama meliputi gangguan spermatogenesis dan kualitas sperma, seperti oligospermia, azoospermia, varikokel, serta gangguan fungsi ejakulasi, yang dapat dipicu oleh faktor genetik, hormonal, atau paparan lingkungan. Faktor gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol, penggunaan narkoba, obesitas, serta paparan zat endokrin disruptor juga dikaitkan dengan penurunan konsentrasi dan motilitas sperma. Dari sisi wanita, penyebab infertilitas termasuk gangguan ovulasi (misalnya akibat sindrom ovarium polikistik atau disfungsi hormonal lainnya), obstruksi tuba fallopi, endometriosis, serta gangguan anatomi uterus yang menghambat fertilisasi atau implantasi. Selain itu, faktor pasangan seperti usia, stres kronis, aktivitas fisik tidak memadai, pola makan tidak sehat, serta kondisi medis kronis turut memengaruhi peluang konsepsi bagi kedua pasangan. Beberapa infeksi menular seksual yang berlangsung tanpa gejala juga dapat merusak saluran reproduksi pria dan wanita sehingga meningkatkan risiko infertilitas. Karena penyebabnya yang kompleks dan sering kali tumpang tindih, penilaian infertilitas mencakup evaluasi menyeluruh terhadap aspek pria, wanita, gaya hidup, dan lingkungan untuk strategi manajemen yang efektif (Imran et al., 2025; Szabó et al., 2025; Wahyuni & Setyarini, 2024).

2. Diagnosis

Diagnosis infertilitas merupakan proses evaluasi klinis yang sistematis untuk mengidentifikasi penyebab infertilitas. Evaluasi ini dimulai dengan anamnesis lengkap dan pemeriksaan fisik kedua pasangan untuk menilai riwayat menstruasi, riwayat kehamilan sebelumnya, kebiasaan seksual, gaya hidup, serta faktor risiko medis yang mungkin berkontribusi pada infertilitas. Analisis semen pada pria untuk menilai volume, konsentrasi, motilitas, dan morfologi sperma, karena faktor pria menyumbang proporsi besar kasus infertilitas (Phillips et al., 2023).

Jika hasil awal tidak menunjukkan penyebab yang jelas, pemeriksaan lanjutan pada wanita meliputi penilaian ovulasi (misalnya pengukuran hormon),

pencitraan struktur reproduksi seperti ultrasonografi transvaginal, evaluasi tubal dengan histerosalpingografi atau laparoskopi diagnostik, serta evaluasi endometrium atau saluran pelvis sesuai indikasi klinis. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi penyebab seperti gangguan ovulasi, disfungsi tuba, endometriosis, atau faktor lain, serta penyebab infertilitas yang tidak bisa dijelaskan (*unexplained infertility*), sehingga diagnosis menjadi landasan bagi rencana penatalaksanaan klinis yang individual dan efektif (Phillips et al., 2023).

3. Manajemen Penatalaksanaan Infertilitas

Strategi penatalaksanaan infertilitas mencakup modifikasi gaya hidup, terapi medis, tindakan bedah, hingga penggunaan teknologi reproduksi berbantu (*assisted reproductive technology / ART*), tergantung pada faktor penyebab, usia pasangan, durasi infertilitas, serta preferensi pasien. Intervensi awal sering kali berfokus pada optimalisasi gaya hidup seperti penurunan atau pengendalian berat badan, penghentian merokok dan konsumsi alkohol, pengelolaan stres, serta perbaikan status nutrisi karena faktor-faktor tersebut terbukti memengaruhi kualitas gamet dan keberhasilan konsepsi (Phillips et al., 2023).

Pada infertilitas akibat gangguan ovulasi, terapi farmakologis seperti penggunaan induksi ovulasi seperti clomiphene atau letrozole digunakan, sedangkan pada faktor tuba atau kelainan anatomis tertentu dapat dipertimbangkan tindakan bedah korektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemilihan terapi yang paling efektif namun tetap proporsional terhadap risiko dan manfaat klinis (Phillips et al., 2023).

Pada kasus infertilitas yang tidak responsif terhadap terapi konvensional atau melibatkan faktor pria berat, endometriosis lanjut, atau infertilitas yang tidak dapat dijelaskan, ART seperti *inseminasi intrauterin* (IUI) dan *fertilisasi in vitro* (IVF) menjadi pilihan utama. Proses ART memerlukan kolaborasi erat antarprofesi, termasuk dokter spesialis, perawat, embriolog, apoteker, ahli gizi, dan psikolog, untuk menjamin keamanan terapi hormonal, kepatuhan pengobatan, kesejahteraan psikologis, serta keberhasilan klinis. Pendekatan interprofesi dalam manajemen infertilitas terbukti meningkatkan kualitas perawatan, pengalaman pasien, dan hasil reproduksi, sekaligus meminimalkan risiko komplikasi seperti *ovarian hyperstimulation syndrome* (OHSS) dan beban psikososial yang sering dialami pasangan infertil (Phillips et al., 2023).

4. Penatalaksanaan Infertilitas dari Perspektif Interprofesi

Penatalaksanaan infertilitas memerlukan pendekatan interprofesi yang terintegrasi, karena penyebabnya yang multifaktorial serta dampaknya yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Kolaborasi antar profesi kesehatan dapat memastikan penilaian menyeluruh, perencanaan terapi

yang komprehensif, serta dukungan berkelanjutan bagi pasangan infertil. Dokter berperan besar dalam melakukan evaluasi medis, penegakan diagnosis, dan pemberian terapi berbasis bukti, termasuk terapi farmakologis, tindakan bedah, maupun rujukan ke teknologi reproduksi berbantu sesuai indikasi klinis. Namun, keberhasilan penatalaksanaan infertilitas tidak hanya ditentukan oleh intervensi medis semata, melainkan juga oleh keterlibatan profesi kesehatan lain yang saling melengkapi dalam satu tim kolaboratif.

a. Dokter

Dokter terutama dokter spesialis obstetri dan ginekologi, berperan sebagai koordinator utama tim interprofesi dalam melakukan evaluasi, diagnosis, dan rencana terapi infertilitas. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi melakukan skrining awal, evaluasi hormon, pemeriksaan anatomi, serta merencanakan intervensi medis dan teknologi reproduksi berbantu seperti inseminasi buatan atau *In Vitro Fertilization* (IVF). Selain itu, dokter bertanggung jawab untuk mengarahkan konsultasi dengan profesi lain di tim, termasuk ahli gizi, psikolog, atau profesi lain, sehingga pengelolaan pasien bersifat holistik dan bukan hanya medis semata (Budihastuti et al., 2024).

b. Bidan

Bidan berperan dalam edukasi reproduksi dan dukungan psikososial awal untuk pasangan infertil. Bidan membantu pasangan memahami topik terkait ovulasi, menstruasi, dan teknik konsepsi, sekaligus memberikan dukungan emosional dan pemantauan awal. Peran bidan juga penting ketika pasien berada dalam fase awal konsultasi atau ketika ada manifestasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi umum (Budihastuti et al., 2024).

c. Perawat

Perawat memiliki peran penting dalam pendampingan pasien sepanjang proses infertilitas, termasuk edukasi tentang proses terapi, penilaian respon pasien terhadap intervensi medis, pengaturan jadwal kunjungan, serta dukungan emosional yang berkesinambungan. Peran perawat juga mencakup koordinasi dengan dokter dan profesional lain untuk memastikan kontinuitas layanan dan membantu pasien memahami setiap langkah terapi yang sering kali panjang dan emosional (Latifah & Riyanti, 2025).

d. Ahli Gizi

Ahli gizi berkontribusi melalui evaluasi nutrisi dan rencana diet individual yang bertujuan meningkatkan peluang konsepsi, terutama pada kasus di mana faktor metabolik seperti obesitas atau malnutrisi memengaruhi fertilitas. Intervensi gizi yang tepat, termasuk diet seimbang, manajemen berat badan,

serta edukasi nutrisi sebelum konsepsi, terbukti berkaitan dengan peningkatan fungsi hormonal dan peluang kehamilan (Sibarani et al., 2025).

e. Apoteker

Apoteker memiliki peran penting dalam menjamin penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional pada penatalaksanaan infertilitas, terutama terkait terapi hormonal, obat induksi ovulasi, dan obat pendukung dalam teknologi reproduksi berbantu (*assisted reproductive technology*/ART). Apoteker berkontribusi dalam memberikan informasi obat kepada pasien dan tim kesehatan mengenai dosis, waktu penggunaan, potensi efek samping, interaksi obat, serta kepatuhan terapi, yang sangat krusial mengingat banyaknya regimen farmakoterapi yang kompleks dan jangka panjang dalam perawatan infertilitas (Palmer et al., 2021).

f. Psikolog/Psikiater

Infertilitas sering menyebabkan tekanan emosional, stres, cemas, hingga depresi pada pasangan. Psikolog atau psikiater memberikan dukungan psikososial, strategi coping, terapi perilaku, dan bantuan bagi pasien serta pasangan untuk memproses pengalaman emosional mereka. Intervensi ini terbukti meningkatkan kualitas hidup dan keterlibatan pasien dalam rencana perawatan, serta mengurangi kejadian putus terapi karena tekanan psikologis (Budihastuti et al., 2024).

g. Embriolog

Embriolog adalah profesi kunci dalam laboratorium teknologi reproduksi berbantu (ART) yang berperan secara langsung dalam proses pembuahan dan pengembangan embrio di luar tubuh, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam manajemen infertilitas yang melibatkan prosedur seperti *in vitro fertilization* (IVF) dan *intracytoplasmic sperm injection* (ICSI). Tugas embriolog mencakup penanganan gamet (ovum dan sperma), kultur dan pemantauan embrio, pemilihan embrio yang memiliki potensi terbaik untuk implantasi, serta cryopreservasi gamet dan embrio, yang semuanya menentukan keberhasilan klinis dari prosedur ART serta outcome kehamilan (Shirasawa & Terada, 2025).

Embriolog juga bertanggung jawab dalam mengimplementasikan standar kualitas dan keamanan laboratorium ART, termasuk *traceability* dan kontrol kualitas, untuk memastikan bahwa setiap tahap kultur embrio dilakukan sesuai protokol yang ketat. Peran ini sangat teknis dan spesifik, namun harus dilakukan dalam kerja sama yang erat dengan dokter spesialis fertilitas, perawat, dan profesional kesehatan lain untuk memastikan bahwa keputusan klinis tentang pemilihan embrio, timing transfer, dan tindak lanjut pasien

didasarkan pada informasi terbaik dan strategi kolaboratif (Shirasawa & Terada, 2025).

F. Simpulan

Gangguan reproduksi pada perempuan seperti PCOS, endometriosis, dan infertilitas bersifat kompleks dan multifaktorial, dengan dampak yang luas terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan kualitas hidup perempuan serta pasangan. Kompleksitas tersebut menuntut penatalaksanaan yang tidak hanya berfokus pada aspek klinis semata, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan individual pasien secara holistik dan berkelanjutan. Pendekatan interprofesi dalam penatalaksanaan gangguan reproduksi memungkinkan integrasi peran berbagai profesi kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat, apoteker, ahli gizi, psikolog, serta profesi pendukung lainnya, termasuk embriolog pada kasus infertilitas dengan teknologi reproduksi berbantu. Kolaborasi ini berperan penting dalam meningkatkan ketepatan diagnosis, efektivitas terapi, keamanan pengobatan, serta dukungan psikososial bagi pasien. Dengan demikian, penatalaksanaan PCOS, endometriosis, dan infertilitas dari perspektif interprofesi merupakan strategi esensial dalam pelayanan kesehatan reproduksi modern untuk mencapai hasil klinis yang optimal, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta mendukung pelayanan yang berpusat pada pasien dan berbasis bukti.

G. Referensi

- Adilbayeva, A., & Kunz, J. (2024). Pathogenesis of Endometriosis and Endometriosis-Associated Cancers. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(14). <https://doi.org/10.3390/ijms25147624>.
- Alenezi, N. R. K., Alanazi, S. A. N., Almatrafi, R. S. J., Alruwaili, A. T., Alanazi, I. M. B., Alenazi, H. A. Z., Alruwaili, F. A. S., Alanazi, M. G. G., Alruwaili, M. O. S., & Alenezi, A. F. A. (2024). The Role of Nurses in Managing Polycystic Ovary Syndrome. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*.
- Allaire, C., Long, A. J., Bedaiwy, M. A., & Yong, P. J. (2020). Interdisciplinary Teams in Endometriosis Care. *Seminars in Reproductive Medicine*, 38(2–3), 227–234. <https://doi.org/10.1055/s-0040-1718943>.
- Amalia, M., Vitania, W., Insaniyah, K. N., Antari, G. Y., Irawan, D. D., Hidayatunnikmah, N., & Sulastriningsih, K. (2025). *Buku Ajar Biologi Reproduksi*. PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta. www.nuansafajarcemerlang.com.

- Azam, S. S., Vasudevan, S., Bukhari, W. S., Thadhani, J., Tasneem, H., Singh, S., Chijioke, I., Mendes de Freitas, B., Thammitage, M. B. W., & Motwani, J. (2025). Reproductive Endocrine Disorders: A Comprehensive Guide to the Diagnosis and Management of Infertility, Polycystic Ovary Syndrome, and Endometriosis. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.78222>.
- Becker, C. M., Bokor, A., Heikinheimo, O., Horne, A., Jansen, F., Kiesel, L., King, K., Kvaskoff, M., Nap, A., Petersen, K., Saridogan, E., Tomassetti, C., Van Hanegem, N., Vulliamoz, N., & Vermeulen, N. (2022). ESHRE guideline: endometriosis. *Human Reproduction Open*, 2022(2). <https://doi.org/10.1093/hropen/hoac009>.
- Bouton, C., Journeaux, M., Jourdain, M., Angibaud, M., Huon, J. F., & Rat, C. (2023). Interprofessional Collaboration in Primary Care: What Effect on Patient Health? A Systematic Literature Review. *BMC Primary Care*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12875-023-02189-0>.
- Budihastuti, U. R., Laqif, A., Melinawati, E., Prakosa, T., Udiyanto, H., Priyanto, H., Darto, Ratnasari, A. A., Anggraeni, A., & Wijayanti, A. S. (2024). Kolaborasi Tenaga Medis dan Masyarakat dalam Mendukung Layanan Infertilitas. *Jurnal Abdidas*, 5(6), 989–993. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i6.1066>.
- Cîrstoiu, S.-E., & Mehedințu, C. (2023). Screening and Diagnosis of Polycystic Ovary Syndrome Corelated with Evidence-Based International Guidelines 2023 Recommendations. *Romanian Journal Preventive Medicine*, 2(3), 37–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rjpm2030037>.
- Dashti, S., Heidari, A. S., & Keshmiri, F. (2025). Effect of interprofessional Education on Interprofessional Professionalism Behavior and Self-efficacy in Communication Among the Infertility and Reproductive Medicine Team. *BMC Medical Education*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-025-07720-8>.
- Dubé-Zinatelli, E., Anderson, F., & Ismail, N. (2025). The Overlooked Mental Health Burden of Polycystic Ovary Syndrome: Neurobiological Insights Into PCOS-related Depression. *Frontiers in Neuroendocrinology*, 78. <https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2025.101203>.
- Ee, C. (2023). The Role of the Primary Care Physician in the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome. *Seminars in Reproductive Medicine*, 41(1–2), 20–25. <https://doi.org/10.1055/s-0043-1776419>.
- Esperat, M. C., Hust, C., Song, H., Garcia, M., & McMurry, L. J. (2023). Interprofessional Collaborative Practice: Management of Chronic Disease and Mental Health Issues

- in Primary Care. *Public Health Reports*, 138(1_suppl), 29S-35S. <https://doi.org/10.1177/00333549231155469>.
- Fauziah, M. S. (2025). Mengeksplorasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Mental pada Wanita dengan Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) dalam Perspektif Biopsikososial. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 3(4), 197–205. <https://doi.org/10.61132/observasi.v3i4.1890>.
- Feng, J., Wu, Q., Liang, Y., Liang, Y., & Bin, Q. (2025). Epidemiological Characteristics of Infertility, 1990–2021, and 15-year Forecasts: an Analysis Based on the Global Burden of Disease Study 2021. *Reproductive Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-025-01966-7>.
- Feng, Y., Wu, L., Liu, J., & Feng, Y. (2025). The Evolution of the Global Disease Burden of Polycystic Ovary Syndrome and the Role of Regional Heterogeneity in High Body Mass Index Exposure: a Spatiotemporal Analysis Based on the Global Burden of Disease 2021. *Frontiers in Reproductive Health*, 7. <https://doi.org/10.3389/frph.2025.1600995>.
- Gautam, R., Maan, P., Jyoti, A., Kumar, A., Malhotra, N., & Arora, T. (2025). The Role of Lifestyle Interventions in PCOS Management: A Systematic Review. *Nutrients*, 17(2), 1–42. <https://doi.org/10.3390/nu17020310>.
- Imran, M., Zia, R., Arshad, M., Fayyaz, F., Haider, T., Tabraiz, A., Arshad, I., Sharif, M. A., & Javed, B. (2025). Exploration of the Genetic and Environmental Determinants of Male Infertility: a Comprehensive Review. *Egyptian Journal of Medical Human Genetics*, 26(1). <https://doi.org/10.1186/s43042-025-00703-w>.
- Insaniyah, K. N., Sa'adi, A., & Widjiati, W. (2023). Impact of ethanol Extract of Basil Leaves (*Ocimum basilicum* L.) on Mast Cell Reduction and Prostaglandin E2 Levels in Female Mice as a Model for Endometriosis Development. *Journal of Medicinal and Chemical Sciences*, 6(12), 2941–2951. <https://doi.org/10.26655/JMCHEMSCI.2023.12.9>.
- James, L. W., Doll, J., Washburn, D. H., & Wilson-Alston, A. (2024). Interprofessional Collaborative Practice: Importance Across Populations and Settings. *The American Journal of Occupational Therapy*, 78.
- Kamil, H., Fuad, M., & Asnawi, A. (2025). Determinan Praktik Interprofessional Collaboration di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. *Journal of Medical Science*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.55572/jms.v6i1.216>.

- Kusumawati, W., & Wahyuni, A. (2025). Improving Awareness and Management of Polycystic Ovary Syndrome. *Science Midwifery*, 13(5), 1449–1456.
- Latifah, K. U., & Riyanti, F. (2025). Perawatan Pasangan Infertil dalam Meningkatkan Keberhasilan Kehamilan: Studi Literatur Pustaka. *Jurnal Lantera Ilmiah Keperawatan*, 3(1), 18–23. <https://doi.org/10.52120/jliper.v3i1.116>.
- Lebanova, H., Yanachkova, V., & Stoev, S. (2025). The Role of Pharmacists in Identifying and Preventing Drug-Related Problems in PCOS Management. *Pharmacy*, 13(4), 95. <https://doi.org/10.3390/pharmacy13040095>.
- Maulenkul, T., Kuandyk, A., Makhadiyeva, D., Dautova, A., Terzic, M., Oshibayeva, A., Moldaliyev, I., Ayazbekov, A., Maimakov, T., Saruarov, Y., Foster, F., & Sarria-Santamera, A. (2024). Understanding the Impact of Endometriosis on Women's Life: an Integrative Review of Systematic Reviews. *BMC Women's Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03369-5>.
- Monnin, N., Fattet, A. J., & Koscinski, I. (2023). Endometriosis: Update of Pathophysiology, (Epi) Genetic and Environmental Involvement. *Biomedicines*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/biomedicines11030978>.
- Moutzouroulia, A., Asimakopoulou, Z., Tzavara, C., Asimakopoulos, K., Adonakis, G., & Kaponis, A. (2025). The impact of infertility on the mental Health of Women Undergoing in Vitro Fertilization Treatment. *Sexual and Reproductive Healthcare*, 43. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2025.101072>.
- Palmer, S., Chen, A., Dennison, T., Czech, C., Auten, J., Buhlinger, K., & Muluneh, B. (2021). Impact of Oncology Pharmacists on the Knowledge, Attitude, and Practices of Clinicians to Enhance Patient Engagement of Self-Administered Oral Oncolytics. *Pharmacy*, 9(3), 130. <https://doi.org/10.3390/pharmacy9030130>.
- Percy, C., Turner, A., & Orr, C. (2024). Developing a Novel Web-Based Self-Management Support Intervention for Polycystic Ovary Syndrome: Mixed Methods Study With Patients and Health Care Professionals. *JMIR Formative Research*, 8. <https://doi.org/10.2196/52427>.
- Phillips, K., Olanrewaju, R. A., & Omole, F. (2023). Infertility: Evaluation and Management. *American FamilyPhysician*, 107(6), 623–630.
- Raja, J., Chandran, S., Rajendran, S. S., Naidu, V. N., Chinnappan, A., Khan, A. J. T., & Rajagopal, A. (2025). Harnessing the Power of Midwifery: Transforming Self-efficacy and Health Navigation Among Women with Polycystic Ovarian

- Syndrome. *Biomedical Informatics*, 21(8), 2724–2727. <https://doi.org/10.1210/er.2015-1104>.
- Salari, N., Nankali, A., Ghanbari, A., Jafarpour, S., Ghasemi, H., Dokaneheifard, S., & Mohammadi, M. (2024). Global prevalence of polycystic Ovary Syndrome in Women Worldwide: a Comprehensive Systematic Review and Meta-Analysis. In *Archives of Gynecology and Obstetrics* (Vol. 310, Issue 3, pp. 1303–1314). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. <https://doi.org/10.1007/s00404-024-07607-x>.
- Shirasawa, H., & Terada, Y. (2025). Embryologist Staffing in Assisted Reproductive Technology Laboratories: An International Comparative Review. *Reproductive Medicine and Biology*, 24(1). <https://doi.org/10.1002/rmb2.12628>.
- Sibarani, D. W., Kurniawati, W., Ungsianik, T., & Rachmawati, I. N. (2025). Hubungan Antara Asupan Nutrisi dengan Proses Prakonsepsi pada Pasien Infertilitas Kedekatan: A Systematic Review. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(7), 2743–2749. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i7.6847>.
- Su, P., Chen, C., & Sun, Y. (2025). Physiopathology of Polycystic Ovary Syndrome in Endocrinology, Metabolism and Inflammation. *Journal of Ovarian Research*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s13048-025-01621-6>.
- Szabó, A., Nyirády, P., & Kopa, Z. (2025). Impact of Lifestyle and Environmental Factors on Fertility. *Current Opinion in Urology*. <https://doi.org/10.1097/MOU.0000000000001339>.
- Teede, H. J., Tay, C. T., Laven, J. J. E., Dokras, A., Moran, L. J., Piltonen, T. T., Costello, M. F., Boivin, J., Redman, L. M., Boyle, J. A., Norman, R. J., Mousa, A., & Joham, A. E. (2023). Recommendations From the 2023 International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 108(10), 2447–2469. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgad463>.
- Ugwumadu, L., Chakrabarti, R., Williams-Brown, E., Rendle, J., Swift, I., John, B., Allen-Coward, H., & Ofuasia, E. (2017). The Role of the Multidisciplinary Team in the Management of Deep Infiltrating Endometriosis. *Gynecological Surgery*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/s10397-017-1018-0>.
- Wahyuni, E. S., & Setyarini, A. (2024). Factors Causing Primary Infertility In Couples Of Reproductive Age: Literature Review. *Health Access Journal*, 1(2), 39. <https://doi.org/10.31290/haj.v1i2.4520>.

H. Glosarium

Assisted Reproductive Technology (ART): Teknologi reproduksi berbantu yang digunakan untuk membantu terjadinya kehamilan, meliputi prosedur seperti inseminasi intrauterin (IUI), fertilisasi in vitro (IVF), dan intracytoplasmic sperm injection (ICSI).

Add-back Therapy: Pemberian hormon dosis rendah yang dikombinasikan dengan terapi agonis atau antagonis GnRH untuk mengurangi efek samping hipoestrogenik, seperti kehilangan massa tulang dan gejala vasomotor.

Anovulasi: Kondisi tidak terjadinya ovulasi yang dapat menyebabkan gangguan siklus menstruasi dan infertilitas, sering ditemukan pada perempuan dengan PCOS.

Endometriosis: Penyakit ginekologis kronis yang ditandai oleh keberadaan jaringan endometrium di luar kavum uteri, yang dapat menyebabkan nyeri panggul kronis, dismenore, dan infertilitas.

Endometrioma: Kista ovarium yang berisi jaringan endometriotik, sering disebut sebagai chocolate cyst, yang dapat memengaruhi fungsi ovarium dan fertilitas.

Endocrinopathy: Gangguan pada sistem endokrin yang memengaruhi produksi, regulasi, atau kerja hormon, termasuk gangguan hormonal yang berperan dalam PCOS.

Embriolog: Tenaga profesional di bidang laboratorium reproduksi yang bertanggung jawab terhadap penanganan gamet dan embrio pada prosedur teknologi reproduksi berbantu, termasuk kultur, pemilihan, dan kriopreservasi embrio.

Endometriosis Fertility Index (EFI): Skor prognostik yang digunakan untuk memperkirakan peluang kehamilan spontan pada perempuan dengan endometriosis setelah tindakan pembedahan.

Fertilisasi In Vitro (IVF): Prosedur ART di mana pembuahan ovum oleh sperma dilakukan di luar tubuh, kemudian embrio yang terbentuk ditransfer ke dalam uterus.

GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone): Hormon yang diproduksi hipotalamus dan berperan dalam mengatur sekresi hormon reproduksi, digunakan secara terapeutik dalam penatalaksanaan PCOS dan endometriosis.

Hiperandrogenisme: Kondisi kelebihan hormon androgen pada perempuan yang dapat menimbulkan gejala klinis seperti hirsutisme, jerawat, dan alopecia, sering dijumpai pada PCOS.

Infertilitas: Ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi.

Interprofessional Collaborative Practice (IPCP): Pendekatan kolaboratif dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai profesi kesehatan untuk bekerja bersama secara terkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perawatan pasien.

Interprofesi: Pendekatan pelayanan kesehatan yang menekankan kerja sama, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama antarprofesi kesehatan yang berbeda untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal.

Oligomenore: Kondisi siklus menstruasi yang jarang atau memanjang, sering dikaitkan dengan gangguan ovulasi pada PCOS.

Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS): Komplikasi potensial akibat stimulasi ovarium berlebihan pada terapi infertilitas, ditandai dengan pembesaran ovarium dan gangguan keseimbangan cairan.

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): Gangguan endokrin pada perempuan usia reproduktif yang ditandai oleh hiperandrogenisme, gangguan ovulasi, dan/atau gambaran ovarium polikistik.

Resistensi Insulin: Kondisi penurunan respons sel terhadap insulin yang berperan dalam patogenesis PCOS dan meningkatkan risiko diabetes melitus tipe 2.

Teknologi Reproduksi Berbantu: Istilah umum untuk berbagai prosedur medis dan laboratorium yang digunakan untuk membantu terjadinya kehamilan pada pasangan dengan infertilitas.

CHAPTER 4

PERAN PERAWAT DAN BIDAN DALAM KONSELING KESEHATAN SEKSUAL DAN PENCEGAHAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL

Sriama Muliani, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Memasuki tahun 2026, tantangan kesehatan reproduksi di Indonesia mengalami pergeseran yang signifikan. Fokus Nasional kini tidak hanya pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), tetapi juga pada perluasan akses layanan bagi kelompok remaja dan pencegahan komplikasi jangka panjang akibat perilaku seksual berisiko. Salah satu isu krusial saat ini adalah meningkatnya aktivitas seksual dini pada remaja yang tidak dibarengi dengan literasi kesehatan yang memadai, sehingga memicu tingginya angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) serta risiko penyakit menular seksual (Pratiwi, A., & Utami, S, 2024)

Kesehatan reproduksi saat ini menghadapi tantangan kompleks yang melampaui batas medis, mencakup dimensi sosial dan perilaku. Di tingkat global maupun nasional, isu utama yang muncul adalah tingginya angka kehamilan tidak diinginkan (KTD), akses layanan kesehatan reproduksi remaja yang belum merata, serta meningkatnya prevalensi Infeksi Menular Seksual (IMS). Fenomena "fenomena gunung es" pada kasus IMS menunjukkan bahwa banyak kasus tidak terdeteksi karena stigma sosial dan kurangnya literasi kesehatan seksual sehingga perlu ditingkatkan (Kementrian Kesehatan RI, 2024).

Berdasarkan laporan kesehatan nasional terbaru, angka kematian ibu (AKI) masih menjadi tantangan besar, di mana komplikasi reproduksi memberikan kontribusi signifikan, sedangkan data Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan kasus sifilis yang cukup tajam (naik hampir 70% dalam lima tahun terakhir) serta prevalensi HIV yang masih tinggi pada kelompok populasi kunci. Di Indonesia, diperkirakan terdapat lebih dari 500.000 orang hidup dengan HIV (ODHA), dengan penularan melalui hubungan seksual berisiko tetap menjadi jalur utama (KemenKes RI, 2024)

Strategi Global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Menular Seksual (IMS) 2022–2030 bertujuan untuk mengakhiri epidemi IMS pada tahun 2030, sejalan dengan penanggulangan HIV dan hepatitis

virus. Strategi ini berfokus pada pendekatan terpadu yang berpusat pada manusia dalam kerangka Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) dan Pelayanan Kesehatan Primer (PHC) (WHO,2024).

Kegagalan dalam menangani isu kesehatan reproduksi dan IMS berdampak jangka panjang, mulai dari kemandulan, kanker serviks (akibat HPV), hingga transmisi infeksi dari ibu ke anak (Triple Eliminasi). Penanganan yang cepat dan terintegrasi sangat krusial untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (BPS,2025).

Bidan dan perawat berdiri di baris terdepan sebagai *gatekeepers* kesehatan masyarakat. Dimana Bidan memiliki peran strategis dalam asuhan kebidanan yang berfokus pada siklus hidup perempuan, mulai dari skrining pra-nikah hingga deteksi dini IMS pada ibu hamil melalui program Triple Eliminasi. Sedangkan Perawat berperan krusial dalam manajemen kasus klinis, pemberian edukasi berkelanjutan kepada kelompok berisiko, serta memastikan kepatuhan pengobatan (*treatment adherence*) pada pasien dengan infeksi kronis seperti HIV (Indonesia, 2023).

Dalam sistem kesehatan modern yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023, bidan dan perawat tidak lagi bekerja secara terisolasi. Mereka merupakan bagian dari *Interprofessional Collaboration* (IPC). Dengan demikian diharapkan pencegahan terkait Kesehatan Reproduksi dan pencegahan IMS diharapkan dapat diatasi secara efektif.

B. Kesehatan Seksual & Infeksi Menular Seksual (IMS)

1. Kesehatan Seksual

a. Definisi

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan seksual adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial sehubungan dengan seksualitas; bukan sekadar tidak adanya penyakit atau disfungsi. Kesehatan seksual mencakup pendekatan positif terhadap seksualitas dan hubungan seksual yang aman, menyenangkan dan bebas dari paksaan, diskriminasi, serta kekerasan, dan mensyaratkan bahwa hak-hak seksual semua orang dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan seksual sebagai keadaan sejahtera secara fisik, emosional, mental, dan sosial yang berkaitan dengan seksualitas, bukan hanya ketiadaan penyakit, disfungsi, atau kelemahan (WHO, 2015).

Green dan Kreuter (2005) menyatakan bahwa kesehatan seksual merupakan bagian dari kesehatan reproduksi yang dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai, serta perilaku individu dalam mengekspresikan seksualitas secara bertanggung jawab.

Menurut Sarwono (2011), kesehatan seksual adalah kemampuan individu untuk menjalankan fungsi dan peran seksualnya secara sehat, sesuai dengan norma sosial, nilai budaya, dan moral yang berlaku dalam masyarakat.

b. Ruang Lingkup Kesehatan Seksual

1) Aspek Fisik/Biologis

Mencakup fungsi organ reproduksi, kesehatan hormonal, kesuburan, kehamilan, serta pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS (WHO, 2015).

2) Aspek Psikologis

Meliputi citra tubuh, identitas seksual, orientasi seksual, kepuasan seksual, serta kesehatan mental yang berkaitan dengan relasi intim (Hurlock, 2013).

3) Aspek Sosial dan Budaya

Berhubungan dengan norma sosial, nilai budaya, peran gender, serta kualitas hubungan interpersonal seperti komunikasi dan kepercayaan dalam hubungan seksual (Sarwono, 2011).

4) Hak dan Etika Seksual

Meliputi hak memperoleh informasi seksual, hak menentukan pilihan secara sadar (consent), serta hak bebas dari kekerasan dan diskriminasi seksual (WHO, 2015).

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesehatan Seksual

1) Faktor Individu

Usia, tingkat pendidikan, pengetahuan seksual, sikap, nilai agama, serta kondisi kesehatan fisik dan mental memengaruhi perilaku dan kesehatan seksual seseorang (Green & Kreuter, 2005).

2) Faktor Keluarga dan Lingkungan

Pola asuh orang tua, komunikasi dalam keluarga, pengaruh teman sebaya, serta lingkungan sekolah berperan penting dalam pembentukan sikap dan perilaku seksual (Santrock, 2018).

3) Faktor Sosial Budaya

Norma masyarakat, stigma seksual, ketimpangan gender, dan adat istiadat dapat memengaruhi cara individu mengekspresikan seksualitasnya (Sarwono, 2011).

4) Faktor Ekonomi dan Layanan Kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan, ketersediaan pendidikan seksual, serta kebijakan pemerintah turut menentukan tingkat kesehatan seksual masyarakat (WHO, 2015).

2. Infeksi Menular Seksual (IMS)

a. Definisi

Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Kontak ini mencakup seks vaginal, oral, maupun anal. IMS disebabkan oleh lebih dari 30 bakteri, virus, dan parasit yang berbeda (WHO, 2023)

b. Jenis-Jenis IMS, Etiologi, dan Faktor Predisposisi (Disease Control and Prevention (CDC), 2021)

Jenis Infeksi	Etiologi (Penyebab)	Faktor Predisposisi
Sifilis	Bakteri <i>Treponema pallidum</i>	Berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, adanya luka terbuka di area genital.
Gonore	Bakteri <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Aktivitas seksual aktif pada usia muda, riwayat IMS sebelumnya.
Klamidia	Bakteri <i>Chlamydia trachomatis</i>	Usia di bawah 25 tahun, kurangnya edukasi seksual.
Hepatitis B & HIV.	Virus (HBV & HIV)	Penggunaan jarum suntik bersama, hubungan seksual berisiko.
Trikomoniasis	Parasit <i>Trichomonas vaginalis</i>	Higienitas organ vital yang buruk, pasangan seks multipel.

c. Cara Penularan IMS

Penularan IMS tidak hanya terbatas pada hubungan seksual penetratif. Jalur penularannya meliputi (Kemenkes RI, 2022):

- 1) Kontak Seksual: Melalui cairan vagina, semen, atau kontak kulit-ke-kulit (pada kasus kutil kelamin atau herpes).
- 2) Transmisi Vertikal: Penularan dari ibu ke janin selama masa kehamilan atau saat proses persalinan.

- 3) Kontak Darah: Penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau transfusi darah yang tercemar (khusus untuk HIV, Hepatitis B, dan C).
- d. Penegakan Diagnosa

Proses diagnosis dilakukan melalui beberapa tahapan klinis (Workowski et al., 2021):

 - 1) Anamnesis: Tanya jawab mengenai riwayat seksual dan keluhan (seperti nyeri saat buang air kecil atau keputihan abnormal).
 - 2) Pemeriksaan Fisik: Inspeksi langsung pada organ genital untuk melihat adanya lesi, bintil, atau duh tubuh (cairan).
 - 3) Pemeriksaan Laboratorium:
 - a) Tes Serologi: Pemeriksaan darah untuk sifilis atau HIV.
 - b) NAAT (Nucleic Acid Amplification Test): Standar emas untuk mendeteksi klamidia dan gonore melalui sampel urin atau swab.
 - c) Mikroskopis: Pengamatan sampel cairan untuk melihat bakteri atau parasit secara langsung.
- e. Komplikasi

Jika tidak diobati, IMS dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang serius, antara lain (Mayo Clinic, 2023):

 - 1) Infertilitas: Peradangan pada saluran reproduksi (PID/Penyakit Radang Panggul pada wanita).
 - 2) Kehamilan Ektopik: Kehamilan di luar rahim yang mengancam nyawa.
 - 3) Kanker: Infeksi HPV (Human Papillomavirus) dapat menyebabkan kanker serviks, anus, dan tenggorokan.
 - 4) Komplikasi Neonatal: Kebutaan, pneumonia, atau kematian pada bayi baru lahir yang tertular dari ibunya.
 - 5) Peningkatan Risiko HIV: Adanya luka akibat IMS lain memudahkan virus HIV masuk ke dalam aliran darah.

C. Konseling Kesehatan Seksual

Pendekatan untuk Pendidikan dan konseling Kesehatan tidak sama pada semua umur karena kebutuhan dan masalah yang dialami juga berbeda. Berikut Pendidikan dan konseling Kesehatan seksual sesuai umur:

1. Anak-anak ($\pm 5-10$ tahun)

- a. Pendidikan:
 - 1) Pengenalan bagian tubuh dan fungsinya
 - 2) Konsep privasi tubuh
 - 3) Perlindungan diri dari kekerasan seksual
- b. Konseling:

Fokus pada rasa aman, kepercayaan diri, dan komunikasi terbuka dengan orang tua atau guru (UNESCO, 2018).

2. Remaja ($\pm 11-18$ tahun)

a. Pendidikan:

- 1) Pubertas dan perubahan fisik-psikologis
- 2) Hubungan sehat dan persetujuan (consent)
- 3) Pencegahan IMS dan kehamilan tidak direncanakan

b. Konseling:

Membantu remaja menghadapi tekanan teman sebaya, kebingungan identitas, serta pengambilan keputusan seksual yang bertanggung jawab (Santrock, 2018).

3. Dewasa Muda ($\pm 19-40$ tahun)

a. Pendidikan:

- 1) Kesehatan reproduksi
- 2) Perencanaan kehamilan
- 3) Seks aman dan kepuasan seksual

b. Konseling:

Fokus pada hubungan pasangan, pernikahan, fungsi seksual, dan kesehatan mental terkait seksualitas (WHO, 2015).

4. Dewasa dan Lansia (>40 tahun)

a. Pendidikan:

- 1) Perubahan fungsi seksual akibat usia
- 2) Menopause dan andropause
- 3) Penyakit kronis dan dampaknya pada seksualitas

b. Konseling:

Membantu adaptasi terhadap perubahan fisik, menjaga keintiman, dan meningkatkan kualitas hidup (Hurlock, 2013).

Selain dari segi kelompok umur, konseling Kesehatan seksual juga dilakukan pada beberapa kondisi kesehatan tertentu/Khusus. Konseling kesehatan seksual adalah proses komunikasi terapeutik yang bertujuan membantu individu memahami, menerima, dan mengelola aspek seksualitasnya secara sehat, aman, dan bermartabat. Pada kelompok berkebutuhan khusus, konseling harus disesuaikan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan kognitif klien (WHO, 2015).

WHO menegaskan bahwa setiap individu, termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama atas informasi dan layanan kesehatan seksual yang berkualitas, aman, dan bebas diskriminasi (WHO, 2015).

1. Kelompok berkebutuhan khusus dalam konteks Kesehatan seksual:

a. Penyandang disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual

- b. Remaja dengan masalah psikososial
- c. Perempuan hamil risiko tinggi
- d. Lansia
- e. Penyintas kekerasan seksual
- f. Pasien dengan penyakit kronis (HIV, kanker, diabetes)

2. Prinsip Konseling Kesehatan Seksual pada Kebutuhan Khusus (UNFPA, 2018)

- a. Berpusat pada klien (client-centered)
- b. Menghormati hak dan martabat manusia
- c. Non-diskriminatif dan inklusif
- d. Menjaga kerahasiaan (confidentiality)
- e. Menggunakan komunikasi terapeutik yang empatik

3. Peran Bidan dalam Konseling Kesehatan Seksual pada Kebutuhan Khusus

Menurut International Confederation of Midwives (ICM), bidan memiliki peran strategis dalam promosi, pencegahan, edukasi, serta konseling kesehatan seksual dan reproduksi sepanjang siklus kehidupan perempuan (ICM, 2019).

- a. Konseling pada Remaja dan Perempuan dengan Risiko Tinggi. Bidan berperan memberikan:
 - 1) Edukasi pubertas dan perubahan tubuh
 - 2) Konseling hubungan sehat dan pencegahan kehamilan tidak diinginkan
 - 3) Pencegahan dan deteksi dini IMS
- b. Konseling pada Perempuan Hamil dan Nifas dengan Kebutuhan Khusus. Bidan memberikan konseling terkait:
 - 1) Hubungan seksual yang aman selama kehamilan
 - 2) Perubahan hasrat dan fungsi seksual pascapersalinan
 - 3) Adaptasi psikoseksual ibu dan pasangan

WHO menyatakan bahwa konseling bidan sangat penting dalam menjaga kesejahteraan seksual ibu selama masa reproduksi (WHO, 2016).
- c. Konseling pada Penyandang Disabilitas
 Bidan berperan meluruskan stigma bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kebutuhan seksual serta memberikan (UNFPA, 2018):
 - 1) Informasi reproduksi yang mudah dipahami
 - 2) Konseling berbasis kemampuan individu

4. Peran Perawat dalam Konseling Kesehatan Seksual pada Kebutuhan Khusus

Perawat memiliki peran penting dalam pendekatan holistik terhadap kebutuhan seksual klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan (ICN, 2021).

- a. Konseling pada Pasien dengan Penyakit Kronis. Perawat memberikan konseling mengenai:
 - 1) Dampak penyakit dan terapi terhadap fungsi seksual

- 2) Penyesuaian hubungan intim
- 3) Dukungan psikologis dan peningkatan kualitas hidup
- b. Konseling pada Lansia. WHO (2015) menegaskan bahwa seksualitas tetap merupakan bagian penting kualitas hidup lansia. Perawat berperan:
 - 1) Memberikan edukasi perubahan seksual akibat penuaan
 - 2) Mengurangi stigma terhadap seksualitas lansia
 - 3) Mendukung komunikasi pasangan.
- c. Konseling pada Penyintas Kekerasan Seksual. Perawat berperan dalam:
 - 1) Konseling trauma-informed care
 - 2) Dukungan emosional dan pemulihan psikoseksual
 - 3) Rujukan layanan lanjutan

WHO menekankan pentingnya pendekatan empatik dan bebas penilaian dalam konseling korban kekerasan seksual (WHO, 2014).

5. Kolaborasi Bidan dan Perawat dalam Konseling Kesehatan Seksual

WHO menekankan bahwa kolaborasi antar tenaga kesehatan meningkatkan efektivitas layanan kesehatan seksual, terutama pada kelompok berkebutuhan khusus (WHO, 2015).

Kolaborasi ini mencakup:

- a. Asesmen kebutuhan seksual klien
- b. Edukasi berkelanjutan
- c. Rujukan dan tindak lanjut
- d. Pendekatan multidisiplin yang berkelanjutan

D. Pencegahan Penyakit Menular Seksual

Infeksi menular seksual merupakan penyakit yang memiliki risiko tinggi untuk menimbulkan komplikasi jangka Panjang yang tidak mudah untuk diatasi. IMS merupakan momok yang menakutkan pada individu, bukan saja karena komplikasi yang ditimbulkan tetapi juga merupakan aib yang tidak mudah diterima oleh Masyarakat.

1. Strategi pencegahan berdasarkan Tingkat Wilayah

Pemerintah Indonesia menerapkan strategi berjenjang untuk menekan angka prevalensi IMS (Direktorat Jenderal P2P Kemenkes, 2023):

Tingkat	Fokus Utama Pencegahan
Nasional	Penetapan regulasi (Permenkes), pengadaan logistik nasional (obat-obatan dan alat tes), serta kampanye nasional "Triple Eliminasi".

Daerah (Provinsi)	Koordinasi antar kabupaten/kota, pemetaan wilayah risiko tinggi (seperti area lokalisasi atau tempat hiburan), dan pengawasan distribusi logistik medis.
Kabupaten/Kota	Pelaksanaan teknis di Puskesmas, pembentukan kelompok warga peduli AIDS/IMS, dan penyediaan layanan Klinik IMS (Klinik VCT/CST) yang mudah diakses.

2. Cara-Cara Mencegah Penularan IMS

Secara umum, pencegahan IMS dapat diringkas melalui rumus "ABCDE" yang diakui secara internasional (Sumber: World Health Organization (WHO), 2023):

- a. A (Abstinence): Tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah.
- b. B (Be Faithful): Setia pada satu pasangan dan tidak berganti-ganti pasangan seksual.
- c. C (Condom): Menggunakan kondom secara benar dan konsisten setiap kali berhubungan seksual untuk meminimalkan risiko.
- d. D (No Drug): Menghindari penggunaan narkoba, terutama jarum suntik secara bersamaan, karena berkaitan erat dengan penularan HIV dan Hepatitis B.
- e. E (Education/Early Detection): Aktif mencari informasi kesehatan seksual dan melakukan deteksi dini (skrining) secara rutin jika berada dalam kelompok berisiko.

3. Peran Bidan dan Perawat dalam Pencegahan Infeksi

a. Peran Bidan (Kemenkes RI, 2022)

Bidan berfokus pada kesehatan reproduksi perempuan, ibu, dan bayi.

- 1) Skrining pada Ibu Hamil: Melakukan tes sifilis, HIV, dan Hepatitis B (Triple Eliminasi) pada setiap ibu hamil untuk mencegah penularan vertikal ke janin.
- 2) Edukasi Kesehatan Reproduksi: Memberikan konseling mengenai kebersihan organ reproduksi dan perilaku seksual sehat pada remaja dan calon pengantin.
- 3) Pelayanan KB: Mengintegrasikan edukasi IMS dalam pelayanan Keluarga Berencana, terutama promosi penggunaan kondom sebagai metode perlindungan ganda (dual protection).

b. Peran Perawat

Perawat berfokus pada asuhan keperawatan komprehensif dan pemberdayaan Masyarakat (Potter & Perry, 2021).

- 1) Penyuluhan Komunitas: Mengadakan promosi kesehatan di puskesmas atau sekolah mengenai bahaya IMS.
- 2) Pendampingan (Case Management): Membantu pasien yang terdiagnosis IMS untuk patuh pada pengobatan agar tidak terjadi penularan lebih lanjut kepada pasangan.
- 3) Trisula Pencegahan: Melakukan contact tracing (penelusuran pasangan seksual) pada pasien yang terinfeksi agar segera mendapatkan pengobatan.

E. Peran Perawat dan Bidan dalam Konseling Kesehatan Sosial dan Pencegahan IMS berdasarkan Kebijakan yang mengatur.

Peran Bidan dan Perawat dalam konseling kesehatan seksual dan pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Indonesia diatur secara spesifik dalam berbagai regulasi. Secara umum, kedua profesi ini memiliki kewenangan dalam upaya promotif (edukasi/konseling) dan preventif (pencegahan).

Kebijakan terkait peran Bidan dan Perawat terkait konseling Kesehatan seksual dan pencegahan infeksi menular seksual:

1. Peran Bidan

Bidan memiliki peran sentral terutama dalam kesehatan reproduksi perempuan dan pencegahan penularan infeksi dari ibu ke anak (PPIA/PMTCT).

- a. UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan: Menegaskan bahwa bidan berwenang memberikan imunisasi, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan konseling keluarga berencana yang mencakup aspek kesehatan seksual.
- b. Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan: Mengatur kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kontrasepsi.
- c. Permenkes No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan: Mewajibkan bidan melakukan skrining penyakit menular (HIV, Sifilis, Hepatitis B) pada ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan infeksi.

2. Peran Perawat

Perawat berfokus pada asuhan keperawatan yang komprehensif, termasuk pada kelompok risiko tinggi IMS.

- a. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Omnibus Law): Menggantikan UU Keperawatan sebelumnya, namun tetap mengakui peran perawat dalam upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan penyakit menular.

- b. Permenkes No. 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan: Menjelaskan tugas perawat dalam melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling dalam upaya preventif.
- c. PMK No. 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil: Perawat terlibat dalam konseling persiapan kehamilan yang mencakup pemeriksaan status infeksi organ reproduksi.

Kebijakan secara umum terkait pengendalian infeksi menular seksual (IMS) berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri Kesehatan sebagai berikut:

1. Permenkes No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS: Mengatur tentang Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS/VCT) serta Konseling dan Tes HIV atas Inisiasi Petugas Kesehatan (TIPK/PITC) yang bisa dilakukan oleh bidan dan perawat terlatih.
2. Permenkes No. 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak: Fokus pada prosedur teknis tenaga kesehatan dalam memutus rantai infeksi menular seksual dari ibu ke janin.

Selain dalam bentuk Peraturan pemerintah dan peraturan menteri Kesehatan juga telah tersusun dalam Undang. Berikut kebijakan terbaru terkait Kesehatan, kesehatan seksual dan Pencegahan infeksi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi yang mengatur peran bidan dan perawat terkait kesehatan reproduksi (Kespro) dan pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS).

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dalam UU ini, peran bidan dan perawat diatur dalam konteks Tenaga Kesehatan (Pasal 197 & 198) dan Upaya Kesehatan Reproduksi (Pasal 40-52).

- a. Pasal 198 (Pengelompokan Tenaga Kesehatan):
 - 1) Ayat (1) huruf b: Menetapkan Tenaga Keperawatan (Perawat) sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan.
 - 2) Ayat (1) huruf c: Menetapkan Tenaga Kebidanan (Bidan) sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan.
- b. Pasal 47 (Upaya Kesehatan Reproduksi):
 - 1) *"Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan reproduksi masyarakat yang setinggi-tingginya sepanjang siklus hidup."*
 - 2) Peran: Bidan dan perawat bertindak sebagai pelaksana pelayanan kesehatan primer dalam menjalankan upaya promotif dan preventif ini.
- c. Pasal 50 (Pencegahan Penyakit Menular/IMS):

- 1) Pasal ini mewajibkan Tenaga Kesehatan (termasuk Bidan dan Perawat) untuk melakukan deteksi dini, pemberian informasi, dan
- 2) Penatalaksanaan pada penyakit menular, termasuk IMS dan HIV/AIDS, untuk mencegah penularan lebih luas.

2. Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan

Reproduksi. Peraturan ini merupakan aturan turunan terbaru yang lebih teknis. Bidan dan perawat disebut secara spesifik dalam pembagian wewenang layanan.

a. Pasal 3 (Upaya Kesehatan Reproduksi Sesuai Siklus Hidup):

Menetapkan bahwa asuhan diberikan mulai dari masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, hingga pascapersalinan. Di sini, memiliki peran sentral.

b. Pasal 19 (Upaya Kesehatan Reproduksi Dewasa):

1) Ayat (1): *"Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi dewasa mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif."*

2) Bunyi Detail Peran: Perawat dan bidan di fasilitas kesehatan (Puskesmas/Klinik) berwenang memberikan konseling dan skrining kesehatan reproduksi.

c. Pasal 21 (Wewenang Khusus Bidan dalam Kespro):

1) Bidan memiliki kewenangan mandiri dalam memberikan:

- a) Penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan.
- b) Pelayanan keluarga berencana (KB).
- c) Deteksi dini dan skrining awal pada kasus gangguan reproduksi atau IMS pada perempuan.

d. Pasal 33 & 34 (Deteksi Dini & Skrining IMS):

1) Mengatur bahwa Tenaga Kesehatan (Bidan dan Perawat) wajib melakukan skrining IMS pada kelompok berisiko.

2) Bidan: Fokus pada skrining "Triple Eliminasi" (HIV, Sifilis, Hepatitis B) pada ibu hamil.

3) Perawat: Fokus pada manajemen kasus, pendampingan pengobatan (kuratif), dan edukasi pencegahan infeksi di masyarakat.

Berdasarkan aturan terbaru ini, peran bidan kini lebih difokuskan pada pencegahan di tingkat komunitas dan kesehatan ibu-anak, sedangkan perawat lebih luas pada manajemen klinis dan pemulihan (rehabilitatif) pasien dengan gangguan reproduksi atau IMS.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan aturan turunannya seperti Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, peran tenaga kesehatan (bidan dan perawat) kini lebih terintegrasi dalam siklus hidup manusia.

Berikut adalah rincian peran dan fungsi mereka dalam kesehatan reproduksi (Kespro) dan pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS):

a. Peran dan Fungsi Bidan

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan khusus dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi perempuan.

1) Kesehatan Reproduksi:

- a) Pemberi Layanan Primer: Melakukan asuhan pada masa sebelum hamil, kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.
- b) Konselor Keluarga Berencana (KB): Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta pelayanan alat kontrasepsi (termasuk pemasangan kontrasepsi jangka panjang seperti IUD/Implan).
- c) Kesehatan Remaja & Dewasa: Melakukan deteksi dini dan skrining kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup.

2) Pencegahan & Penanganan IMS:

- a) Skrining Triple Eliminasi: Melakukan tes wajib bagi ibu hamil untuk mendeteksi HIV, Sifilis, dan Hepatitis B guna mencegah penularan dari ibu ke anak (PPIA).
- b) Motivator Perilaku Sehat: Mengedukasi pasien tentang perilaku seksual aman dan penggunaan alat pelindung (kondom) pada kelompok berisiko.

b. Peran dan Fungsi Perawat

Perawat berfokus pada asuhan keperawatan secara umum yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

1) Kesehatan Reproduksi:

- a) Edukator & Motivator: Memberikan edukasi terkait kesehatan seksual, menjaga kebersihan organ reproduksi, dan manajemen gangguan sistem reproduksi.
- b) Asuhan Keperawatan: Membantu dalam pemulihan pasien dengan gangguan sistem reproduksi melalui pelayanan rawat inap maupun rawat jalan.

2) Pencegahan & Penanganan IMS:

- a) Manajemen Kasus IMS: Melakukan pengkajian, pendampingan kepatuhan pengobatan (khususnya untuk ODHA), dan manajemen gejala.
- b) Pencegahan Infeksi (PPI): Menerapkan *universal precaution* (kewaspadaan standar) untuk mencegah penularan infeksi di fasilitas kesehatan (seperti penggunaan APD dan sterilisasi alat).
- c) Konseling VCT/TIPK: (Jika tersertifikasi) Melakukan konseling sebelum dan sesudah tes HIV serta pelacakan kontak (partner notification).

Perbandingan Peran dalam Pencegahan IMS

Fitur	Bidan	Perawat
Fokus Utama	Kesehatan reproduksi perempuan & ibu-anak	Kesembuhan klinis & perawatan umum
Pencegahan IMS	Skrining pada ibu hamil (Triple Eliminasi)	Pendampingan pengobatan & edukasi umum
Kewenangan	Memberikan alat kontrasepsi (barrier)	Edukasi perubahan perilaku & PPI

F. Simpulan

Tantangan kesehatan reproduksi di Indonesia pada 2026 telah bergeser dari fokus semata pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) menuju agenda yang lebih luas, yaitu memperkuat akses layanan kesehatan reproduksi remaja dan mengendalikan dampak jangka panjang perilaku seksual berisiko. Meningkatnya aktivitas seksual dini yang tidak diimbangi literasi kesehatan seksual memicu tingginya kehamilan tidak diinginkan (KTD) serta memperbesar risiko Infeksi Menular Seksual (IMS). Fenomena “gunung es” pada IMS menegaskan bahwa kasus yang tercatat sering kali jauh lebih sedikit dibandingkan kasus sebenarnya akibat stigma, diskriminasi, dan rendahnya deteksi dini.

Kesehatan seksual dipahami sebagai kesejahteraan utuh fisik, emosional, mental, dan sosial yang mensyaratkan hubungan aman, menyenangkan, bebas paksaan dan kekerasan, serta penghormatan terhadap hak-hak seksual. Di sisi lain, IMS mencakup infeksi yang menular melalui kontak seksual maupun jalur lain seperti transmisi vertikal ibu-ke-bayi dan paparan darah, dengan konsekuensi serius bila tidak ditangani: infertilitas, PID, kehamilan ektopik, kanker (terutama terkait HPV), komplikasi neonatal, dan peningkatan risiko penularan HIV. Karena itu, pencegahan dan pengendalian IMS membutuhkan pendekatan komprehensif: edukasi dan konseling sesuai tahap usia, deteksi dini melalui skrining, penguatan perilaku aman (ABCDE), serta layanan klinis yang mudah diakses dan tidak menghakimi.

Bidan dan perawat memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan layanan kesehatan primer. Bidan memegang peran sentral dalam kesehatan reproduksi perempuan dan pencegahan penularan ibu-ke-anak melalui skrining dan tata laksana Triple Eliminasi (HIV, sifilis, hepatitis B), pelayanan KB dengan pesan perlindungan ganda, serta konseling sepanjang siklus hidup perempuan. Perawat berperan kuat dalam manajemen kasus klinis, pendampingan kepatuhan pengobatan (terutama pada ODHA), edukasi komunitas berkelanjutan, pelacakan

kontak, dan penerapan pencegahan infeksi di fasilitas kesehatan. Keduanya tidak lagi bekerja terpisah, melainkan dalam kerangka Interprofessional Collaboration (IPC) yang menekankan asesmen bersama, edukasi berkelanjutan, rujukan dan tindak lanjut, serta koordinasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, komunitas).

Seluruh upaya ini semakin kuat karena didukung kerangka kebijakan dan regulasi terbaru. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes No. 2 Tahun 2025 menegaskan upaya kesehatan reproduksi sepanjang siklus hidup serta kewajiban deteksi dini dan penatalaksanaan penyakit menular termasuk IMS. Dengan standar kebijakan yang semakin jelas, pencegahan IMS dan penguatan kesehatan reproduksi akan lebih efektif apabila diterapkan melalui pelayanan primer yang ramah remaja, berbasis hak dan etika, bebas stigma, serta terintegrasi melalui kolaborasi bidan–perawat dan jejaring lintas sektor. Ini menjadi kunci untuk menekan KTD, menurunkan beban IMS/HIV, serta mencegah dampak jangka panjang seperti infertilitas, kanker, dan penularan ibu-ke-anak.

G. Refrensi

- Badan Pusat Statistik. (2025). Profil Kesehatan Ibu dan Anak Indonesia 2024: Menuju Target SDGs 2030. BPS RI. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/health-profile-indonesia>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. <https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/default.htm>
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). (2023). Pedoman nasional penanganan infeksi menular seksual 2023. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://p2p.kemkes.go.id/>
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). Health program planning: An educational and ecological approach (4th ed.). McGraw-Hill.
- Hurlock, E. B. (2013). Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Erlangga.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- International Confederation of Midwives. (2019). Essential competencies for midwifery practice. ICM. <https://www.internationalmidwives.org/our-work/policy-and-practice/essential-competencies.html>

- International Council of Nurses. (2021). Nursing and sexual and reproductive health. ICN. <https://www.icn.ch/nursing-policy>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS*. Jakarta: Kemenkes RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5353>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak*. Jakarta: Kemenkes RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/113115/permenkes-no-52-tahun-2017>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Hamil, Masa Bersalin, Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual*. Jakarta: Kemenkes RI <https://peraturan.bpk.go.id/Download/375491/permenkes-no-21-tahun-2021.pdf>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/301566/Permenkes%20Nomor%2023%20Tahun%202022.pdf>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Hamil, Masa Sesudah Melahirkan, dan Pelayanan Kontrasepsi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/187389/permenkes-no-21-tahun-2021>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia 2021*. <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-2021.pdf>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan HIV/AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan IV Tahun 2023*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). <https://siha.kemkes.go.id/portal/perkembangan-kasus-hiv-aids-pims-di-indonesia>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314518/permenkes-no-2-tahun-2025>
- Kesuma, S. I. (2024). Transformation of midwives' independent practice in the era of Law No. 17 of 2023. *Vlum 5 Nomor 5. Journal of Law and Public Health*, 3(2). <https://dinastires.org/JLPH/article/view/1876>
- Mayo Clinic. (2023). Sexually transmitted diseases (STDs): Symptoms and causes. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sexually-transmitted-diseases-stds/symptoms-causes/syc-20351240>
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier. <https://www.elsevier.com/books/fundamentals-of-nursing/potter/978-0-323-67772-1>
- Pratiwi, A., & Utami, S. (2024). Analisis literasi kesehatan reproduksi dan perilaku seksual berisiko pada remaja perkotaan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(1), 45-58. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan*. Jakarta: Sekretariat Negara. <https://www.google.com/search?q=https://peraturan.bpk.go.id/Details/103607/uu-no-4-tahun-2019>
- Santrock, J. W. (2018). *Adolescence* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sarwono, S. W. (2011). *Psikologi remaja*. Rajawali Pers.
- UNESCO. (2018). *International technical guidance on sexuality education*. UNESCO Publishing.
- United Nations Population Fund. (2018). *Sexual and reproductive health of persons with disabilities*. UNFPA. <https://www.unfpa.org/resources/sexual-and-reproductive-health-persons-disabilities>
- Workowski, K. A., Bachmann, L. H., Chan, P. A., Johnston, C. M., Muzny, C. A., Park, I., Schwebke, J., Cha, S., & Bolan, G. A. (2021). Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. *MMWR Recommendations and Reports*, 70(4), 1–187. <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/rr/rr7004a1.htm>

- World Health Organization. (2014). Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-14.26>
- World Health Organization. (2015). Sexual health, human rights and the law. WHO Press.
- World Health Organization. (2015). Sexual health, human rights and the law. WHO. <https://www.who.int/health-topics/sexual-health>
- World Health Organization. (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-16.12>
- World Health Organization. (2023). Global health sector strategies on, respectively, HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections for the period 2022-2030. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240051935>
- World Health Organization. (2023). Sexually transmitted infections (STIs). [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-\(stis\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis))
- World Health Organization. (2024). Global strategy for the prevention and control of sexually transmitted infections: 2022–2030. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240053984>

H. Glosarium

Abstinence: Prinsip tidak melakukan hubungan seksual sama sekali bagi individu yang belum menikah sebagai upaya pencegahan utama IMS.

Akses Layanan: Ketersediaan dan kemudahan masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual.

Angka Kematian Ibu (AKI): Indikator kesehatan yang mengukur jumlah kematian perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Asuhan Kebidanan: Pelayanan profesional oleh bidan yang berfokus pada siklus hidup perempuan, mulai dari pra-nikah hingga masa nifas.

Cakupan Kesehatan Semesta (UHC): Sistem yang menjamin semua orang mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa kesulitan finansial.

Consent: Hak setiap individu untuk memberikan persetujuan secara sadar dalam menentukan pilihan seksualnya tanpa paksaan.

Contact Tracing: Proses penelusuran pasangan seksual dari pasien yang terinfeksi IMS untuk segera diberikan pengobatan guna memutus rantai penularan.

Etiologi: Studi atau ilmu yang mempelajari penyebab atau asal-usul suatu penyakit, dalam hal ini mikroorganisme penyebab IMS.

Faktor Predisposisi: Faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan atau risiko seseorang untuk tertular infeksi, seperti perilaku berganti pasangan.

Gatekeepers: Istilah untuk tenaga kesehatan (seperti bidan dan perawat) yang berada di baris terdepan dalam menjaga dan memantau kesehatan masyarakat.

Berbagai infeksi (bakteri, virus, atau parasit) yang ditularkan melalui kontak seksual vaginal, oral, maupun anal.

Interprofessional Collaboration (IPC): Kerjasama timbal balik antar berbagai profesi kesehatan (seperti bidan dan perawat) untuk mencapai tujuan kesehatan pasien yang optimal.

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD): Kondisi kehamilan yang terjadi pada saat yang tidak tepat atau tidak direncanakan oleh pasangan.

Kesehatan Seksual: Keadaan sejahtera secara fisik, emosional, mental, dan sosial yang berkaitan dengan seksualitas, bukan sekadar ketiadaan penyakit.

Konseling VCT (Voluntary Counseling and Testing): Layanan konseling dan tes HIV secara sukarela untuk mendeteksi status infeksi secara dini.

NAAT (Nucleic Acid Amplification Test): Standar emas pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi materi genetik bakteri penyebab klamidia dan gonore.

Pelayanan Kesehatan Primer (PHC): Pendekatan pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau dan menjadi kontak pertama individu dengan sistem kesehatan.

Penyakit Radang Panggul (PID): Komplikasi berupa peradangan pada organ reproduksi wanita akibat infeksi yang tidak tertangani, yang dapat memicu infertilitas.

Sustainable Development Goals (SDGs): Tujuan pembangunan berkelanjutan global, di mana poin ke-3 berfokus pada jaminan kehidupan yang sehat bagi semua orang.

Transmisi Vertikal: Jalur penularan infeksi dari ibu ke janin selama kehamilan atau proses persalinan.

Treatment Adherence: Kepatuhan pasien dalam menjalankan regimen pengobatan secara konsisten, terutama pada infeksi kronis seperti HIV.

Triple Eliminasi: Program nasional untuk memutus rantai penularan tiga penyakit (HIV, Sifilis, dan Hepatitis B) dari ibu ke anak secara serentak.

Universal Precaution: Langkah pencegahan standar (seperti penggunaan APD) untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien dari penularan infeksi di fasilitas medis.

CHAPTER 5

GIZI REPRODUKSI REMAJA UNTUK PENCEGAHAN ANEMIA DAN KEHAMILAN USIA DINI

Bdn. Ade Rahayu Prihartini, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi kritis dalam siklus kehidupan manusia, ditandai oleh percepatan pertumbuhan fisik, pematangan sistem reproduksi, serta perubahan psikologis dan sosial yang signifikan. Pada fase ini, kebutuhan gizi meningkat secara substansial untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Namun demikian, berbagai laporan nasional dan internasional menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi remaja masih menghadapi tantangan serius, khususnya pada remaja putri, yang berdampak langsung terhadap kesehatan reproduksi di masa kini dan masa mendatang (World Health Organization, 2018)

Salah satu masalah gizi yang paling menonjol pada kelompok remaja adalah anemia defisiensi besi. Anemia pada remaja putri memiliki prevalensi yang relatif tinggi dan sering kali tidak terdeteksi secara dini karena gejalanya yang tidak spesifik. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kebugaran fisik dan kemampuan kognitif remaja, tetapi juga berkaitan erat dengan penurunan kesiapan kesehatan reproduksi, terutama apabila remaja memasuki kehamilan pada usia yang belum matang secara biologis. (Keats et al., 2019) (Bhutta et al., 2013)

Dalam konteks kesehatan reproduksi, anemia pada remaja putri merupakan faktor risiko penting yang dapat memperburuk outcome kehamilan di kemudian hari. Status gizi yang buruk sebelum kehamilan telah terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya risiko anemia berat pada kehamilan, komplikasi persalinan, serta masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Oleh karena itu, pencegahan anemia tidak dapat ditunda hingga masa kehamilan, melainkan harus dimulai sejak masa remaja sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif kesehatan reproduksi (World Health Organization, 2016; Renfrew et al., 2018).

Permasalahan gizi pada remaja juga tidak dapat dipisahkan dari fenomena kehamilan usia dini yang masih terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Kehamilan pada masa remaja sering berkaitan dengan rendahnya literasi kesehatan, keterbatasan akses terhadap informasi serta layanan kesehatan reproduksi, dan kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung. Status gizi yang tidak optimal,

termasuk risiko anemia, dapat semakin meningkatkan kerentanan remaja terhadap dampak negatif kehamilan usia dini, baik dari sisi kesehatan fisik maupun aspek psikososial. Oleh karena itu, upaya pencegahan kehamilan dini perlu berjalan seiring dengan intervensi gizi reproduksi yang komprehensif (Lassi et al., 2019; Sigit et al., 2024).

Hubungan antara gizi reproduksi remaja, kejadian anemia, dan risiko kehamilan usia dini menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat multidimensional dan saling memengaruhi. Intervensi yang hanya menitikberatkan pada satu komponen, seperti suplementasi tanpa penguatan edukasi, atau edukasi tanpa dukungan perbaikan status gizi, umumnya menghasilkan dampak yang terbatas dan kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif dengan mengombinasikan intervensi gizi, pendidikan kesehatan reproduksi, pemberdayaan remaja, serta dukungan lingkungan sosial agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif. (Diana & Rachmah, 2021)(Reeves et al., 2017)

Pendekatan gizi reproduksi remaja yang holistik menempatkan remaja sebagai individu yang utuh, dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya yang memengaruhi status gizi dan perilaku kesehatannya. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma kesehatan masyarakat modern yang menekankan pentingnya intervensi berbasis daur kehidupan (life-course approach) untuk mencegah masalah kesehatan lintas generasi. Dalam konteks ini, gizi reproduksi remaja menjadi fondasi strategis dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan reproduksi dan pembangunan sumber daya manusia (World Health Organization, 2018; Sandall et al., 2016).

Peran tenaga kesehatan profesional menjadi sangat krusial dalam penerapan pendekatan holistik gizi reproduksi remaja. Bidan, perawat, ahli gizi, dan apoteker memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam upaya pencegahan anemia dan kehamilan usia dini melalui edukasi, deteksi dini, intervensi gizi, serta pendampingan remaja secara berkelanjutan. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional dalam layanan kesehatan remaja meningkatkan efektivitas intervensi dan keberlanjutan program kesehatan (O'Leary et al., 2019; World Health Organization, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, bab ini disusun untuk mengkaji secara mendalam gizi reproduksi remaja sebagai strategi utama dalam pencegahan anemia dan kehamilan usia dini. Pembahasan diarahkan pada penguatan landasan konseptual, sintesis bukti ilmiah terkini, serta relevansinya dengan praktik dan kebijakan kesehatan di Indonesia. Bab ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi dosen serta tenaga kesehatan profesional dalam

mengembangkan pendekatan gizi reproduksi remaja yang holistik, integratif, dan berbasis bukti.

B. Konsep Gizi Reproduksi Remaja Dalam Pendekatan Holistik

Gizi reproduksi remaja merupakan bagian integral dari kesehatan reproduksi yang menempatkan pemenuhan kebutuhan zat gizi sebagai fondasi bagi pertumbuhan, pematangan sistem reproduksi, dan kesiapan kesehatan reproduksi di masa dewasa. Pada fase remaja, terjadi peningkatan kebutuhan zat gizi makro dan mikro seiring dengan percepatan pertumbuhan dan perubahan hormonal. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tersebut dapat berdampak pada gangguan pertumbuhan, penurunan status kesehatan, serta meningkatnya risiko masalah kesehatan reproduksi, termasuk anemia dan komplikasi kehamilan di kemudian hari (World Health Organization, 2018; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Pendekatan holistik dalam gizi reproduksi remaja menekankan bahwa status gizi tidak hanya ditentukan oleh kecukupan asupan makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan. Pola makan remaja sering kali dipengaruhi oleh persepsi citra tubuh, tekanan sosial, serta paparan media, yang dapat mendorong perilaku makan tidak sehat. Oleh karena itu, intervensi gizi yang efektif perlu mempertimbangkan konteks kehidupan remaja secara menyeluruh, bukan hanya aspek biologis semata (Gibney et al., 2020; Hapsari et al., 2022).

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, gizi reproduksi remaja dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pencegahan masalah kesehatan lintas generasi. Status gizi yang baik pada remaja, khususnya remaja putri, berperan penting dalam menentukan kualitas kesehatan pra-kehamilan dan kehamilan di masa depan. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa kondisi gizi sebelum kehamilan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap outcome kehamilan dibandingkan intervensi yang diberikan setelah kehamilan terjadi (Bhutta et al., 2017; Keats et al., 2019).

Pendekatan holistik dalam gizi reproduksi remaja juga selaras dengan kerangka life-course approach yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Pendekatan ini menekankan bahwa intervensi kesehatan perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak usia dini untuk mencegah akumulasi risiko kesehatan di kemudian hari. Dalam konteks ini, gizi reproduksi remaja menjadi titik masuk strategis untuk memutus rantai masalah gizi dan kesehatan reproduksi lintas generasi (World Health Organization, 2016; Sandall et al., 2016).

Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah gizi akibat interaksi faktor biologis dan sosial yang terjadi secara bersamaan. Pada remaja putri, kehilangan zat besi selama menstruasi meningkatkan kebutuhan zat besi secara signifikan, sementara pola makan yang kurang seimbang serta rendahnya konsumsi pangan sumber zat besi dapat memperbesar risiko terjadinya anemia. Kerentanan ini semakin tinggi pada remaja yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah, karena keterbatasan akses terhadap pangan bergizi serta layanan kesehatan yang memadai. Temuan penelitian populasi di Indonesia juga menegaskan bahwa faktor lingkungan dan status sosial ekonomi berperan penting dalam menentukan prevalensi anemia pada remaja putri (Sigit et al., 2024; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Selain faktor biologis, dimensi psikososial juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk status gizi remaja. Tekanan sosial untuk memenuhi standar tubuh tertentu, kecenderungan melakukan praktik diet yang tidak sehat, serta minimnya dukungan keluarga dapat mendorong remaja mengembangkan pola makan yang berisiko dan tidak seimbang. Dalam jangka panjang, intervensi gizi yang hanya berfokus pada aspek asupan tanpa mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial cenderung kurang efektif dalam menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan (Diana & Rachmah, 2020; Hapsari et al., 2022).

Pendekatan holistik dalam gizi reproduksi remaja juga menekankan pentingnya integrasi edukasi gizi dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Pemahaman remaja tentang hubungan antara gizi, kesehatan reproduksi, dan risiko kehamilan usia dini menjadi kunci dalam membentuk perilaku sehat. Intervensi yang menggabungkan edukasi gizi dan kesehatan reproduksi terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja dibandingkan pendekatan yang terpisah (Lassi et al., 2019; World Health Organization, 2018).

Dalam kerangka pelayanan kesehatan, pendekatan holistik menuntut keterlibatan berbagai profesi kesehatan dalam mendukung gizi reproduksi remaja. Bidan, perawat, ahli gizi, dan apoteker memiliki peran yang saling melengkapi dalam melakukan asesmen status gizi, edukasi, intervensi nutrisi, serta pemantauan kepatuhan terhadap suplementasi. Kolaborasi interprofesional memungkinkan penyediaan layanan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan remaja (Reeves et al., 2017; O'Leary et al., 2019).

Konsep gizi reproduksi remaja dalam pendekatan holistik juga mencakup peran lingkungan sekolah dan komunitas sebagai ruang strategis intervensi. Sekolah merupakan setting yang efektif untuk menjangkau remaja secara luas melalui program edukasi gizi dan kesehatan reproduksi yang terstruktur. Bukti menunjukkan bahwa intervensi berbasis sekolah yang terintegrasi dengan layanan kesehatan

memberikan dampak positif terhadap status gizi dan perilaku kesehatan remaja (Lassi et al., 2019; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Dengan demikian, gizi reproduksi remaja dalam pendekatan holistik dapat dipahami sebagai upaya terpadu yang menggabungkan pemenuhan kebutuhan gizi, edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan remaja, serta dukungan lingkungan sosial dan kebijakan. Pendekatan ini memberikan kerangka konseptual yang kuat bagi pengembangan program dan kebijakan pencegahan anemia dan kehamilan usia dini yang berkelanjutan dan berbasis bukti (World Health Organization, 2016; Renfrew et al., 2018).

C. Hubungan Gizi Reproduksi Remaja Dengan Anemia Dan Kehamilan Usia Dini

Gizi reproduksi remaja memiliki keterkaitan erat dengan kejadian anemia dan risiko kehamilan usia dini melalui mekanisme biologis, perilaku, dan sosial yang saling berinteraksi. Pada masa remaja, kebutuhan zat gizi meningkat seiring dengan percepatan pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi. Ketidacukupan asupan zat gizi esensial, khususnya zat besi, asam folat, dan protein, berkontribusi terhadap terjadinya anemia yang berdampak langsung pada kesiapan kesehatan reproduksi remaja putri (World Health Organization, 2018; Keats et al., 2019).

Anemia pada remaja putri merupakan masalah kesehatan reproduksi yang sering kali bersifat laten dan kurang mendapatkan perhatian. Kondisi ini dapat menurunkan kapasitas fisik, konsentrasi belajar, serta daya tahan tubuh, sehingga memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas remaja. Dari perspektif reproduksi, anemia mencerminkan cadangan zat gizi yang tidak memadai untuk mendukung kehamilan yang sehat, sehingga meningkatkan risiko komplikasi apabila kehamilan terjadi pada usia yang masih muda (Bhutta et al., 2017; Renfrew et al., 2018).

Secara biologis, anemia defisiensi besi pada remaja putri berkaitan dengan meningkatnya kehilangan zat besi selama menstruasi yang tidak diimbangi oleh asupan zat besi yang memadai. Pola makan remaja yang cenderung rendah konsumsi sumber zat besi heme, seperti daging dan ikan, serta tingginya konsumsi pangan olahan dengan kandungan gizi rendah semakin memperburuk kondisi tersebut. Bukti menunjukkan bahwa kebiasaan makan seperti ini berkontribusi signifikan terhadap tingginya prevalensi anemia pada remaja di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama pada kelompok dengan akses pangan bergizi yang terbatas (Sigit et al., 2024; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023)..

Hubungan antara gizi reproduksi remaja dan kehamilan usia dini tidak hanya dimediasi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor perilaku dan sosial. Remaja dengan status gizi buruk sering kali berasal dari lingkungan dengan keterbatasan

akses pendidikan dan informasi kesehatan. Kondisi ini berhubungan dengan rendahnya literasi kesehatan reproduksi, yang pada gilirannya meningkatkan kerentanan terhadap perilaku berisiko, termasuk hubungan seksual tidak terlindungi dan kehamilan usia dini (Lassi et al., 2019; Hapsari et al., 2022).

Status gizi yang tidak optimal dapat memengaruhi perkembangan psikososial remaja, termasuk aspek kepercayaan diri, persepsi terhadap citra tubuh, serta kemampuan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan. Berbagai temuan menunjukkan bahwa remaja yang mengalami masalah gizi cenderung memiliki kerentanan psikososial yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat mendorong munculnya perilaku kesehatan yang kurang adaptif. Oleh karena itu, gizi reproduksi remaja perlu dipahami dalam kerangka ekosistem kesehatan yang lebih luas, tidak hanya sebagai persoalan kecukupan asupan nutrisi, tetapi juga sebagai bagian dari faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi kesehatan reproduksi secara menyeluruh (Diana & Rachmah, 2020; World Health Organization, 2016).

Kehamilan usia dini pada remaja dengan status gizi buruk membawa konsekuensi kesehatan yang lebih berat dibandingkan kehamilan pada usia dewasa. Remaja yang hamil masih berada dalam fase pertumbuhan, sehingga terjadi kompetisi nutrisi antara kebutuhan tubuh ibu dan janin. Kondisi ini meningkatkan risiko anemia berat, kekurangan energi kronis, serta komplikasi kehamilan dan persalinan, termasuk bayi dengan berat badan lahir rendah (Keats et al., 2019; Bhutta et al., 2017).

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa status gizi pra-kehamilan merupakan determinan penting outcome kehamilan dan kesehatan bayi. Intervensi gizi yang dilakukan sebelum kehamilan, khususnya pada masa remaja, memiliki dampak yang lebih besar dalam mencegah komplikasi dibandingkan intervensi yang dimulai setelah kehamilan terjadi. Oleh karena itu, pencegahan anemia dan perbaikan status gizi remaja merupakan strategi kunci dalam upaya menurunkan dampak negatif kehamilan usia dini (World Health Organization, 2016; Sandall et al., 2016).

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara gizi reproduksi remaja, anemia, dan kehamilan usia dini diperkuat oleh faktor sosial budaya dan ekonomi. Norma perkawinan usia muda di beberapa wilayah, keterbatasan akses layanan kesehatan remaja, serta ketimpangan sosial ekonomi berkontribusi terhadap tingginya risiko kehamilan usia dini pada remaja dengan status gizi yang kurang baik. Kondisi ini menuntut pendekatan pencegahan yang terintegrasi antara intervensi gizi, edukasi kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan sosial (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; Lassi et al., 2019).

Pendekatan gizi reproduksi remaja yang holistik dan integratif memungkinkan pemutusan mata rantai masalah anemia dan kehamilan usia dini secara lebih efektif.

Dengan menggabungkan perbaikan asupan gizi, edukasi kesehatan reproduksi, serta dukungan psikososial dan lingkungan, intervensi dapat diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki status gizi, tetapi juga untuk membentuk perilaku kesehatan yang berkelanjutan. Bukti menunjukkan bahwa pendekatan multidimensional memberikan hasil yang lebih konsisten dan berjangka panjang dibandingkan intervensi yang bersifat tunggal (Reeves et al., 2017; O'Leary et al., 2019).

Dengan demikian, hubungan antara gizi reproduksi remaja, anemia, dan kehamilan usia dini menegaskan pentingnya intervensi sejak dini yang berbasis bukti dan kolaborasi interprofesional. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk meningkatkan kesehatan remaja saat ini, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kualitas generasi mendatang (World Health Organization, 2018; Renfrew et al., 2018).

D. Bukti Ilmiah Intervensi Gizi Reproduksi Remaja

Intervensi gizi reproduksi remaja telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian nasional maupun internasional selama satu dekade terakhir, khususnya dalam upaya pencegahan anemia dan peningkatan kesiapan kesehatan reproduksi. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan secara tunggal umumnya memberikan dampak yang terbatas, sedangkan pendekatan yang terintegrasi—melalui kombinasi suplementasi, edukasi, serta dukungan lingkungan sosial—cenderung menghasilkan outcome yang lebih konsisten dan berkelanjutan (Bhutta et al., 2017; Diana & Rachmah, 2020).

1. Suplementasi Zat Besi dan Asam Folat pada Remaja

Suplementasi zat besi dan asam folat merupakan salah satu intervensi yang paling banyak diteliti dalam pencegahan anemia pada remaja putri. Tinjauan sistematis dan meta-analisis menunjukkan bahwa pemberian suplementasi zat besi secara rutin pada remaja putri efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin dan menurunkan prevalensi anemia, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah (Keats et al., 2019; World Health Organization, 2016).

Efektivitas suplementasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan konsumsi dan durasi intervensi. Beberapa studi menunjukkan bahwa kepatuhan remaja terhadap konsumsi suplemen sering kali rendah akibat efek samping gastrointestinal, kurangnya pemahaman manfaat, serta stigma sosial. Oleh karena itu, suplementasi perlu disertai dengan edukasi gizi dan pemantauan yang berkelanjutan agar memberikan dampak optimal (Diana & Rachmah, 2020; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

2. Intervensi Gizi Berbasis Sekolah

Edukasi gizi yang terintegrasi dengan pendidikan kesehatan reproduksi terbukti lebih efektif dibandingkan edukasi gizi atau kesehatan reproduksi secara terpisah. Pendekatan ini memungkinkan remaja memahami keterkaitan antara pola makan, status gizi, anemia, dan risiko kehamilan usia dini. Studi menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang menggabungkan kedua aspek tersebut meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan remaja secara signifikan (Lassi et al., 2019; Hapsari et al., 2022).

Pendekatan edukasi yang partisipatif dan kontekstual, seperti diskusi kelompok, simulasi, serta pemanfaatan media interaktif, terbukti lebih mudah diterima oleh remaja dibandingkan metode ceramah konvensional. Intervensi edukatif semacam ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat keterampilan remaja dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pemeliharaan kesehatan reproduksi dan status gizi mereka. Dengan demikian, strategi edukasi yang melibatkan partisipasi aktif menjadi komponen penting dalam program pencegahan anemia dan kehamilan usia dini. (World Health Organization(WHO), 2018)(Sigit et al., 2024)

3. Intervensi Gizi Berbasis Sekolah

Sekolah merupakan setting strategis untuk implementasi intervensi gizi reproduksi remaja karena memungkinkan jangkauan yang luas dan berkesinambungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program gizi berbasis sekolah, seperti pemberian tablet tambah darah, edukasi gizi, dan integrasi materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum, memberikan dampak positif terhadap penurunan prevalensi anemia dan peningkatan perilaku makan sehat pada remaja (Lassi et al., 2019; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Efektivitas intervensi berbasis sekolah meningkat ketika melibatkan guru, tenaga kesehatan, dan orang tua dalam pelaksanaannya. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat dukungan lingkungan bagi remaja untuk menerapkan perilaku gizi sehat di dalam dan di luar sekolah. Bukti menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif semacam ini lebih berkelanjutan dibandingkan intervensi yang hanya berfokus pada individu (Reeves et al., 2017; World Health Organization, 2016).

4. Intervensi Berbasis Komunitas dan Keluarga

Selain sekolah, komunitas dan keluarga memiliki peran penting dalam keberhasilan intervensi gizi reproduksi remaja. Intervensi berbasis komunitas yang melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan keluarga terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan program dan perubahan perilaku kesehatan remaja. Pendekatan ini relevan terutama di wilayah dengan keterbatasan akses

layanan kesehatan formal (Lassi et al., 2019; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Keterlibatan keluarga dalam intervensi gizi reproduksi remaja berperan penting dalam memperbaiki pola makan serta meningkatkan kepatuhan remaja terhadap program suplementasi. Dukungan orang tua dan lingkungan keluarga yang kondusif terbukti memperkuat keberhasilan intervensi gizi, sekaligus membantu memastikan bahwa pesan-pesan kesehatan reproduksi dapat dipahami dan diterapkan secara lebih berkelanjutan oleh remaja (Diana & Rachmah, 2020; Hapsari et al., 2022).

5. Pendekatan Multikomponen dan Kolaborasi Interprofesional

Bukti ilmiah terkini menunjukkan bahwa intervensi gizi reproduksi remaja yang bersifat multikomponen melalui kombinasi suplementasi, edukasi, serta dukungan lingkungan sosial cenderung memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan intervensi yang dilakukan secara tunggal. Pendekatan ini memungkinkan penanganan faktor biologis, perilaku, dan sosial secara simultan, sehingga dampaknya menjadi lebih komprehensif, konsisten, dan berkelanjutan (Bhutta et al., 2017; Diana & Rachmah, 2020).

Kolaborasi interprofesional antara bidan, perawat, ahli gizi, dan apoteker menjadi elemen kunci dalam implementasi intervensi multikomponen. Setiap profesi memiliki peran spesifik yang saling melengkapi, mulai dari asesmen status gizi, edukasi, pemberian dan pemantauan suplementasi, hingga pendampingan remaja secara berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa kerja tim interprofesional meningkatkan efektivitas program kesehatan remaja dan efisiensi sistem pelayanan kesehatan (Reeves et al., 2017; O'Leary et al., 2019).

6. Implikasi Bukti Ilmiah bagi Praktik dan Kebijakan

Bukti ilmiah yang ada menunjukkan bahwa intervensi gizi reproduksi remaja perlu dirancang secara integratif dan kontekstual agar efektif dalam mencegah anemia dan kehamilan usia dini. Implementasi intervensi berbasis bukti memerlukan dukungan kebijakan, pembiayaan yang memadai, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi global yang menekankan pentingnya intervensi preventif sejak usia remaja untuk meningkatkan kesehatan reproduksi lintas generasi (World Health Organization, 2016; Renfrew et al., 2018).

Dengan demikian, bukti ilmiah intervensi gizi reproduksi remaja menegaskan bahwa pencegahan anemia dan kehamilan usia dini tidak dapat dicapai melalui satu strategi tunggal. Pendekatan multikomponen yang holistik, didukung oleh kolaborasi interprofesional dan keterlibatan lingkungan sekolah serta komunitas, merupakan strategi yang paling menjanjikan untuk

meningkatkan kesehatan reproduksi remaja secara berkelanjutan (Bhutta et al., 2017; O'Leary et al., 2019).

E. Peran Profesi Kesehatan Dalam Gizi Reproduksi Remaja

Pendekatan gizi reproduksi remaja yang holistik dan integratif memerlukan keterlibatan aktif berbagai profesi kesehatan yang bekerja secara kolaboratif dan saling melengkapi. Kompleksitas permasalahan anemia dan kehamilan usia dini pada remaja tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu profesi saja, melainkan membutuhkan sinergi kompetensi klinis, edukatif, dan preventif dari bidan, perawat, ahli gizi, dan apoteker. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan remaja serta keberlanjutan program pencegahan berbasis komunitas (Reeves et al., 2017; O'Leary et al., 2019).

1. Peran Bidan dalam Gizi Reproduksi Remaja

Bidan memiliki peran strategis dalam gizi reproduksi remaja karena kompetensinya dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan pendekatan promotif-preventif. Dalam konteks pencegahan anemia dan kehamilan usia dini, bidan berperan dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan pesan-pesan gizi, melakukan skrining awal risiko anemia, serta memberikan konseling prakonsepsi yang berorientasi pada kesiapan kesehatan reproduksi di masa depan. Pendekatan ini sejalan dengan peran bidan sebagai pemberi asuhan berkelanjutan sepanjang daur kehidupan perempuan (World Health Organization, 2018; Sandall et al., 2016).

Selain edukasi, bidan berkontribusi dalam menjembatani akses remaja terhadap layanan kesehatan yang ramah dan aman. Pelayanan yang diberikan bidan sering kali menjadi pintu masuk bagi remaja untuk memperoleh informasi dan dukungan terkait kesehatan reproduksi dan gizi. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan bidan dalam program kesehatan remaja meningkatkan pemanfaatan layanan preventif serta deteksi dini masalah gizi dan kesehatan reproduksi (Renfrew et al., 2018; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

2. Peran Perawat dalam Pendekatan Gizi Reproduksi Remaja

Perawat memiliki peran penting dalam mendukung pendekatan holistik gizi reproduksi remaja melalui pemantauan berkelanjutan, edukasi kesehatan, dan pendampingan psikososial. Dalam praktik pelayanan kesehatan primer dan berbasis sekolah, perawat berfungsi sebagai penghubung antara remaja, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga memastikan kesinambungan asuhan dan tindak lanjut intervensi gizi. Pendekatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan remaja terhadap program suplementasi dan edukasi gizi (World Health Organization, 2016; O'Leary et al., 2019).

Peran perawat juga mencakup penguatan keterampilan hidup sehat remaja, seperti pembentukan kebiasaan makan seimbang dan pengelolaan kesehatan diri. Studi menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan perawat dalam edukasi dan pendampingan remaja memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku kesehatan dan penurunan faktor risiko anemia (Lassi et al., 2019; Hapsari et al., 2022). Dengan demikian, perawat berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan pendukung bagi perbaikan gizi reproduksi remaja.

3. Peran Ahli Gizi dalam Pencegahan Anemia dan Kehamilan Usia Dini

Ahli gizi memegang peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi gizi reproduksi remaja. Kompetensi ahli gizi dalam melakukan asesmen status gizi, perencanaan diet, serta edukasi gizi berbasis bukti menjadi landasan penting dalam pencegahan anemia. Intervensi yang dirancang oleh ahli gizi memungkinkan penyesuaian asupan zat gizi sesuai kebutuhan spesifik remaja, termasuk kebutuhan zat besi, asam folat, dan protein (Gibney et al., 2020; Keats et al., 2019).

Selain intervensi pada tingkat individu, ahli gizi juga berperan penting dalam pengembangan program gizi berbasis sekolah maupun komunitas yang berorientasi pada pencegahan anemia serta peningkatan literasi gizi remaja. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa keterlibatan ahli gizi dalam program kesehatan remaja berkontribusi terhadap efektivitas edukasi gizi dan mendukung keberhasilan perubahan perilaku makan secara lebih berkelanjutan (Diana & Rachmah, 2020; Lassi et al., 2019). Peran ini menjadi semakin penting dalam konteks pencegahan kehamilan usia dini yang memerlukan kesiapan gizi jangka panjang.

4. Peran Apoteker dalam Dukungan Intervensi Gizi Reproduksi Remaja

Apoteker memiliki kontribusi penting dalam memastikan keamanan, efektivitas, dan kepatuhan intervensi suplementasi gizi pada remaja, khususnya suplementasi zat besi dan mikronutrien. Dalam pendekatan gizi reproduksi remaja, apoteker berperan dalam memberikan edukasi terkait cara penggunaan suplemen yang benar, potensi efek samping, serta interaksi dengan obat lain yang mungkin dikonsumsi remaja. Pendekatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan keberhasilan program suplementasi (O'Leary et al., 2019; World Health Organization, 2016).

Selain itu, apoteker dapat berperan dalam pemantauan ketersediaan dan distribusi suplemen gizi di fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah. Peran ini penting untuk menjamin kesinambungan program pencegahan anemia pada remaja. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan apoteker dalam program

kesehatan masyarakat meningkatkan kualitas pengelolaan intervensi berbasis obat dan suplemen serta keselamatan pengguna (Sharma et al., 2019; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

5. Kolaborasi Interprofesional sebagai Kunci Keberhasilan

Kolaborasi interprofesional merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi gizi reproduksi remaja yang holistik. Sinergi peran antara bidan, perawat, ahli gizi, dan apoteker memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani faktor biologis, perilaku, dan sosial yang memengaruhi anemia dan kehamilan usia dini. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa kerja tim interprofesional meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi sistem kesehatan (Reeves et al., 2017; O'Leary et al., 2019).

Dalam praktiknya, kolaborasi interprofesional memerlukan kejelasan peran, komunikasi yang efektif, dan dukungan kebijakan yang memfasilitasi kerja tim lintas profesi. Pendidikan dan pelatihan interprofesional menjadi strategi penting untuk membangun kompetensi kolaboratif tenaga kesehatan dalam mendukung gizi reproduksi remaja. Dengan demikian, pendekatan kolaboratif tidak hanya meningkatkan hasil kesehatan remaja saat ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pencegahan masalah kesehatan reproduksi lintas generasi (World Health Organization, 2016; Renfrew et al., 2018).

F. Model Implementasi Gizi Reproduksi Remaja Di Indonesia

Implementasi gizi reproduksi remaja di Indonesia memerlukan model praktik yang kontekstual, adaptif, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan serta pendidikan nasional. Karakteristik geografis yang luas, keberagaman sosial budaya, serta variasi akses terhadap layanan kesehatan menjadikan pendekatan tunggal tidak memadai untuk menjawab permasalahan anemia dan kehamilan usia dini pada remaja. Oleh karena itu, model implementasi perlu disusun berbasis pendekatan holistik yang mengintegrasikan intervensi gizi, edukasi kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan remaja dan komunitas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; World Health Organization, 2018).

Sistem layanan kesehatan primer memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam implementasi gizi reproduksi remaja. Puskesmas dan jaringannya merupakan titik kontak awal yang memungkinkan deteksi dini anemia, pemberian edukasi gizi dan kesehatan reproduksi, serta rujukan yang tepat apabila diperlukan. Pendekatan integratif di layanan primer memungkinkan intervensi preventif dilakukan secara berkelanjutan dan terkoordinasi, sehingga lebih efektif dalam menurunkan risiko masalah kesehatan reproduksi pada remaja (World Health Organization, 2016; Renfrew et al., 2018).

Integrasi program gizi reproduksi remaja dengan layanan kesehatan berbasis sekolah menjadi salah satu model implementasi yang relevan di Indonesia. Sekolah menyediakan lingkungan yang kondusif untuk menjangkau remaja secara luas dan berkesinambungan melalui kegiatan edukasi gizi, pemberian tablet tambah darah, serta pendidikan kesehatan reproduksi. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa program berbasis sekolah yang terintegrasi dengan layanan kesehatan meningkatkan kepatuhan remaja terhadap intervensi gizi dan memperbaiki perilaku kesehatan secara signifikan (Lassi et al., 2019; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Selain sekolah, pendekatan berbasis komunitas merupakan komponen penting dalam implementasi gizi reproduksi remaja, terutama pada wilayah dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan formal. Keterlibatan kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta dukungan keluarga memungkinkan penyampaian edukasi gizi dan kesehatan reproduksi secara lebih kontekstual, sesuai dengan nilai dan kebutuhan lokal. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas berkontribusi terhadap keberlanjutan program serta memperkuat perubahan perilaku kesehatan remaja melalui dukungan sosial yang lebih luas (Diana & Rachmah, 2020; Hapsari et al., 2022).

Model implementasi gizi reproduksi remaja di Indonesia juga perlu mengintegrasikan pendekatan lintas sektor, khususnya antara sektor kesehatan dan pendidikan. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan penyelarasan program, optimalisasi sumber daya, serta penguatan pesan kesehatan yang diterima remaja di berbagai lingkungan. Pendekatan lintas sektor ini sejalan dengan rekomendasi global yang menekankan pentingnya integrasi kebijakan untuk mengatasi determinan sosial kesehatan secara komprehensif (World Health Organization, 2016; Reeves et al., 2017).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi strategi pendukung dalam implementasi gizi reproduksi remaja di era digital. Media digital dan platform daring dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan edukasi gizi dan kesehatan reproduksi yang menarik dan mudah diakses oleh remaja. Namun demikian, pemanfaatan teknologi perlu disertai dengan upaya peningkatan literasi digital agar informasi yang diterima remaja akurat dan tidak menyesatkan (World Health Organization, 2018; Sharma et al., 2019).

Dalam konteks kebijakan, implementasi gizi reproduksi remaja memerlukan dukungan regulasi dan pembiayaan yang memadai untuk menjamin keberlanjutan program. Kebijakan nasional yang mendukung integrasi layanan gizi dan kesehatan reproduksi remaja menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa intervensi tidak bersifat sporadis, melainkan terstruktur dan berkelanjutan. Bukti menunjukkan

bahwa dukungan kebijakan yang kuat berkontribusi terhadap peningkatan cakupan dan efektivitas program kesehatan remaja (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; World Health Organization, 2016).

Tantangan implementasi gizi reproduksi remaja di Indonesia meliputi keterbatasan sumber daya manusia, variasi kompetensi tenaga kesehatan, serta perbedaan konteks sosial budaya antarwilayah. Selain itu, stigma dan sensitivitas topik kesehatan reproduksi remaja masih menjadi hambatan dalam penyampaian edukasi yang komprehensif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan dan pendekatan sensitif budaya menjadi strategi penting dalam mengatasi tantangan tersebut (Hapsari et al., 2022; Renfrew et al., 2018).

Secara keseluruhan, model implementasi gizi reproduksi remaja di Indonesia perlu dirancang sebagai sistem terpadu yang menggabungkan layanan kesehatan primer, sekolah, komunitas, dan dukungan kebijakan. Pendekatan holistik dan integratif ini memberikan peluang lebih besar untuk menurunkan prevalensi anemia dan mencegah kehamilan usia dini secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia (World Health Organization, 2018; Lassi et al., 2019).

G. Etika, Budaya, Dan Hak Remaja Dalam Gizi Reproduksi

Pendekatan gizi reproduksi remaja tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan etika, budaya, dan hak asasi manusia, mengingat isu gizi dan kesehatan reproduksi menyentuh aspek personal dan sensitif dalam kehidupan remaja. Pelayanan dan intervensi yang tidak memperhatikan dimensi ini berpotensi menimbulkan resistensi, stigma, serta hambatan akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan holistik menuntut tenaga kesehatan untuk menerapkan prinsip etika dan sensitivitas budaya dalam setiap upaya peningkatan gizi reproduksi remaja (World Health Organization, 2018; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

1. Prinsip Etika dalam Intervensi Gizi Reproduksi Remaja

Prinsip etika dasar dalam pelayanan kesehatan, yaitu penghormatan terhadap otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan, memiliki relevansi yang kuat dalam intervensi gizi reproduksi remaja. Penghormatan terhadap otonomi remaja menuntut penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan sesuai dengan tingkat perkembangan remaja agar mereka dapat memahami dan berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan

keputusan terkait kesehatan dan gizinya (World Health Organization, 2016; Beauchamp & Childress, 2019).

2. Prinsip *beneficence* dan *non-maleficence*

Menuntut agar setiap intervensi gizi memberikan manfaat yang optimal sekaligus meminimalkan potensi dampak negatif, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks suplementasi zat besi, tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan keuntungan pencegahan anemia serta kemungkinan efek samping yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan remaja. Oleh karena itu, penerapan pendekatan berbasis bukti yang disertai komunikasi empatik menjadi kunci dalam menjaga efektivitas intervensi sekaligus memastikan prinsip etika tetap terpenuhi (Keats et al., 2019; Diana & Rachmah, 2020). Sensitivitas Budaya dalam Pendekatan Gizi Reproduksi Remaja

Budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola makan, persepsi tubuh, serta sikap terhadap kesehatan reproduksi pada remaja. Norma budaya dan nilai keluarga dapat menentukan jenis pangan yang dikonsumsi, praktik pantang makanan, serta penerimaan terhadap intervensi kesehatan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, sensitivitas budaya menjadi kompetensi penting bagi tenaga kesehatan dalam merancang dan melaksanakan program gizi reproduksi remaja (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; Hapsari et al., 2022).

Pendekatan yang sensitif budaya menuntut pemahaman terhadap nilai, norma, dan praktik lokal tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan keselamatan. Bukti menunjukkan bahwa intervensi gizi yang disesuaikan dengan konteks budaya setempat cenderung lebih mudah diterima serta memiliki keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan yang bersifat seragam. Dalam hal ini, keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat dalam program gizi reproduksi remaja menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan, memperkuat dukungan sosial, dan mendorong partisipasi aktif remaja (Lassi et al., 2019; Diana & Rachmah, 2020).

3. Hak Remaja atas Informasi dan Pelayanan Kesehatan

Hak remaja untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks gizi reproduksi, pemenuhan hak ini mencakup akses terhadap informasi yang benar tentang kebutuhan gizi, pencegahan anemia, serta konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dini. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan remaja harus bersifat ramah, menghormati privasi, dan menjamin kerahasiaan (World Health Organization, 2018; World Health Organization, 2016).

Keterbatasan akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja dapat memperburuk kerentanan terhadap masalah gizi dan kehamilan usia dini. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa remaja yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang responsif dan menghormati hak mereka cenderung memiliki perilaku kesehatan yang lebih baik dan tingkat pemanfaatan layanan yang lebih tinggi (Putri & Lestari, 2019; Lassi et al., 2019). Oleh karena itu, pemenuhan hak remaja menjadi prasyarat penting dalam keberhasilan intervensi gizi reproduksi.

4. Etika Pelayanan pada Kelompok Remaja Rentan

Kelompok remaja rentan, seperti remaja dari keluarga berpenghasilan rendah, remaja di wilayah terpencil, serta remaja dengan keterbatasan akses pendidikan, memerlukan perhatian khusus dalam intervensi gizi reproduksi. Pendekatan etis dalam pelayanan kepada kelompok ini menuntut perlindungan terhadap privasi, penghindaran stigma, serta penyediaan layanan yang inklusif dan mudah diakses. Pelayanan yang tidak sensitif terhadap kerentanan remaja berpotensi memperbesar kesenjangan kesehatan (Hapsari et al., 2022; World Health Organization, 2016).

Pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi interprofesional memungkinkan identifikasi kebutuhan khusus kelompok remaja rentan secara lebih komprehensif. Dengan mengintegrasikan intervensi gizi, edukasi, dan dukungan psikososial, tenaga kesehatan dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan berkeadilan. Bukti menunjukkan bahwa intervensi yang berorientasi pada keadilan sosial memberikan dampak positif terhadap outcome kesehatan remaja (Reeves et al., 2017; Renfrew et al., 2018).

5. Implikasi Etika bagi Praktik Interprofesional

Pendekatan interprofesional dalam gizi reproduksi remaja juga memiliki implikasi etika yang perlu diperhatikan. Kerja sama lintas profesi menuntut kejelasan peran, komunikasi yang transparan, serta penghormatan terhadap kompetensi masing-masing profesi. Praktik kolaboratif yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik peran dan menurunkan mutu pelayanan (O'Leary et al., 2019; Reeves et al., 2017).

Sebaliknya, kolaborasi interprofesional yang berlandaskan prinsip etika dan saling menghormati berkontribusi terhadap peningkatan kualitas asuhan dan keselamatan pengguna layanan. Dalam konteks gizi reproduksi remaja, praktik interprofesional yang etis menjadi fondasi penting bagi penerapan pendekatan holistik yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan terbaik remaja serta masyarakat (World Health Organization, 2016; Renfrew et al., 2018).

H. Rekomendasi Praktik Dan Kesimpulan Akhir Bab

Pendekatan gizi reproduksi remaja yang holistik dan integratif memerlukan rekomendasi praktik yang operasional agar dapat diterapkan secara efektif di berbagai konteks pelayanan kesehatan dan pendidikan. Rekomendasi ini disusun berdasarkan sintesis bukti ilmiah, konteks sistem kesehatan Indonesia, serta prinsip etika dan hak remaja yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Penerapan rekomendasi yang berbasis bukti diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan anemia dan kehamilan usia dini secara berkelanjutan (World Health Organization, 2016; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

1. Rekomendasi Praktik di Layanan Kesehatan dan Pendidikan

Pada tingkat layanan kesehatan primer, tenaga kesehatan perlu mengintegrasikan skrining status gizi dan anemia remaja ke dalam pelayanan rutin, disertai dengan edukasi gizi dan kesehatan reproduksi yang kontekstual dan berkesinambungan. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini masalah gizi serta perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran sebelum remaja memasuki usia reproduktif. Bukti menunjukkan bahwa intervensi preventif yang dilakukan sejak remaja memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar terhadap kesehatan reproduksi dibandingkan intervensi yang dimulai pada masa kehamilan (Bhutta et al., 2017; Keats et al., 2019).

Di lingkungan pendidikan, penguatan program gizi reproduksi remaja berbasis sekolah perlu menjadi prioritas melalui integrasi materi gizi dan kesehatan reproduksi dalam kurikulum serta pelaksanaan program suplementasi yang terpantau. Keterlibatan guru, tenaga kesehatan, dan orang tua dalam pelaksanaan program terbukti meningkatkan kepatuhan remaja dan keberlanjutan intervensi. Pendekatan lintas sektor ini sejalan dengan rekomendasi global yang menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor kesehatan dan pendidikan dalam promosi kesehatan remaja (Lassi et al., 2019; World Health Organization, 2018).

2. Penguatan Kolaborasi Interprofesional

Rekomendasi penting lainnya adalah penguatan kolaborasi interprofesional dalam perencanaan dan pelaksanaan program gizi reproduksi remaja. Bidan, perawat, ahli gizi, dan apoteker perlu bekerja dalam kerangka kerja tim yang jelas, dengan pembagian peran dan mekanisme komunikasi yang efektif. Kolaborasi semacam ini memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani faktor biologis, perilaku, dan sosial yang memengaruhi anemia dan kehamilan usia dini (Reeves et al., 2017; O'Leary et al., 2019).

Pengembangan kompetensi kolaboratif melalui pendidikan dan pelatihan interprofesional juga perlu diperkuat untuk memastikan kesiapan tenaga

kesehatan dalam bekerja secara tim. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang memiliki pengalaman pendidikan interprofesional lebih siap menerapkan praktik kolaboratif dan memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan (World Health Organization, 2016; Renfrew et al., 2018).

3. Arah Pengembangan Kebijakan dan Program

Dari perspektif kebijakan, penguatan gizi reproduksi remaja memerlukan dukungan regulasi yang mendorong integrasi layanan gizi dan kesehatan reproduksi dalam program kesehatan remaja. Kebijakan yang berorientasi preventif dan berbasis daur kehidupan perlu dikembangkan untuk memastikan kesinambungan intervensi dari masa remaja hingga usia dewasa. Pendekatan ini sejalan dengan upaya nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi kesehatan sejak dini (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; World Health Organization, 2018).

Selain itu, pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi dalam program gizi reproduksi remaja menjadi aspek penting untuk memastikan efektivitas serta efisiensi intervensi yang dilakukan. Ketersediaan data yang akurat dan berkelanjutan memungkinkan program diperbaiki secara adaptif sesuai dengan kebutuhan sasaran dan konteks lokal. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa program kesehatan remaja yang didukung oleh sistem evaluasi yang kuat memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang (Lassi et al., 2019; Diana & Rachmah, 2020).

4. Agenda Riset dan Pengembangan Ilmu

Meskipun bukti ilmiah mengenai intervensi gizi reproduksi remaja terus berkembang, masih terdapat kebutuhan akan penelitian implementasi yang mengkaji efektivitas program dalam konteks lokal Indonesia. Penelitian dengan pendekatan campuran (*mixed methods*) diperlukan untuk memahami faktor keberhasilan dan hambatan penerapan intervensi gizi reproduksi remaja di berbagai wilayah dan kelompok sosial (Reeves et al., 2017; Renfrew et al., 2018).

Pengembangan riset yang mengaitkan gizi reproduksi remaja dengan outcome jangka panjang, seperti kesehatan ibu dan anak serta produktivitas generasi mendatang, juga menjadi agenda penting. Hasil riset semacam ini diharapkan dapat memperkuat dasar pengambilan kebijakan dan praktik berbasis bukti dalam bidang kesehatan reproduksi remaja (World Health Organization, 2016; Bhutta et al., 2017).

5. Kesimpulan Akhir Bab

Gizi reproduksi remaja merupakan fondasi strategis dalam pencegahan anemia dan kehamilan usia dini yang berdampak luas terhadap kesehatan

individu dan kualitas generasi mendatang. Pendekatan holistik dan integratif yang menggabungkan intervensi gizi, edukasi kesehatan reproduksi, dukungan psikososial, serta kolaborasi interprofesional terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat parsial (World Health Organization, 2018; Lassi et al., 2019).

Dalam konteks Indonesia, implementasi gizi reproduksi remaja perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya masyarakat. Dukungan kebijakan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta keterlibatan sekolah, keluarga, dan komunitas menjadi prasyarat penting dalam keberhasilan program. Dengan demikian, gizi reproduksi remaja tidak hanya merupakan isu kesehatan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; Renfrew et al., 2018).

I. Referensi

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). New York: Oxford University Press.
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A., & Black, R. E. (2017). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: What can be done and at what cost? *The Lancet*, 389(10064), 451–462.
- Diana, R., & Rachmah, Q. (2020). Nutrition intervention of pregnant adolescents: a systematic review. *Nutrition & Food Science*, 51(2), 234–243. DOI: 10.1108/NFS-03-2020-0096
- Gibney, M. J., Lanham-New, S. A., Cassidy, A., & Vorster, H. H. (2020). *Gizi kesehatan masyarakat* (Edisi terjemahan terbaru). Jakarta: EGC.
- Hapsari, D. D. R., Sulistiawati, A., & Rahmadhony, A. (2022). Paparan media dan pengaruhnya terhadap pengetahuan perempuan tentang program keluarga berencana di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 13(2), 85–96.
- Keats, E. C., Haider, B. A., Tam, E., & Bhutta, Z. A. (2019). Multiple-micronutrient supplementation for women during pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3, CD004905.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kurniawati, D., & Nurhayati, E. (2020). Pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan usia subur. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(3), 123–131.
- Lassi, Z. S., Kedzior, S. G. E., Das, J. K., & Bhutta, Z. A. (2019). Community-based interventions to improve maternal and neonatal health outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6, CD007754.
- O’Leary, K. J., Sehgal, N. L., Terrell, G., & Williams, M. V. (2019). Interdisciplinary teamwork in hospitals: A review and practical recommendations. *Journal of Interprofessional Care*, 33(2), 117–126.
- Putri, R. A., & Lestari, S. (2019). Faktor determinan kesehatan reproduksi remaja putri di Indonesia. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 101–109.

- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6, CD000072.
- Renfrew, M. J., Cheyne, H., Craig, J., Duff, E., Dykes, F., Hunter, B., Lavender, T., Page, L., Ross-Davie, M., Spiby, H., & Downe, S. (2018). Sustaining quality midwifery care: A global perspective. *Midwifery*, 59, 1–5.
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 4, CD004667.
- Sharma, A. E., Rivadeneira, N. A., Barr-Walker, J., Stern, R. J., Johnson, A. K., Sarkar, U., & Martinez, L. (2019). Patient engagement in health care safety: An overview of current evidence. *Health Affairs*, 38(10), 1691–1698.
- World Health Organization. (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2018). Reproductive health: Evidence and guidance for adolescents. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2018). Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities. Geneva: WHO.

CHAPTER 6

KESEHATAN MENTAL DAN SEKSUALITAS DALAM TANTANGAN PELAYANAN HOLISTIK

Fina Sancaya Rini, S,ST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa remaja merupakan fase kehidupan yang ditandai oleh perubahan yang signifikan dan cepat, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Pada fase ini terjadi pematangan organ reproduksi, perubahan hormonal yang signifikan, serta perkembangan kognitif dan emosional yang memengaruhi cara individu berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan. Bersamaan dengan itu, remaja juga mulai membangun pemahaman tentang diri, identitas, relasi romantik, dan seksualitas. Proses ini menjadikan remaja sebagai kelompok yang memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi individu sehat dan produktif, sekaligus kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko kesehatan, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi dan kesehatan mental.

Kesehatan reproduksi remaja merupakan bagian integral dari kesehatan masyarakat dan pembangunan nasional. Konsep kesehatan reproduksi tidak hanya mencakup ketiadaan penyakit atau gangguan fungsi sistem reproduksi, tetapi juga kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu menjalani kehidupan reproduksi dan seksual secara aman. Kesehatan reproduksi remaja memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan erat dengan proses pencarian jati diri, pembentukan identitas seksual, serta kemampuan berinteraksi interpersonal yang sehat di lingkungannya.

Di Indonesia, upaya peningkatan kesehatan remaja telah menjadi perhatian dalam berbagai kebijakan nasional. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menempatkan remaja sebagai kelompok strategis dalam pembangunan manusia dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Kementerian Kesehatan mengembangkan berbagai program yang berorientasi pada pelayanan kesehatan remaja, seperti Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di fasilitas pelayanan kesehatan primer, serta penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai wahana promotif dan preventif di lingkungan pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjamin akses remaja terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan kesehatan remaja di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pendidikan kesehatan reproduksi sering kali masih berfokus pada aspek biologis dan pencegahan kehamilan saja, sementara dimensi psikologis dan sosial yang memengaruhi perilaku seksual remaja belum sepenuhnya terintegrasi. Topik seksualitas juga masih dianggap sensitif dan tabu dalam lingkungan sosial dan budaya, sehingga remaja mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi yang akurat dan berbasis ilmiah. Kondisi ini mendorong sebagian remaja mencari informasi dari sumber yang tidak terverifikasi, termasuk media digital, yang berpotensi meningkatkan risiko kesalahpahaman dan perilaku seksual berisiko.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, berbagai studi menunjukkan adanya peningkatan permasalahan kesehatan mental pada remaja, seperti stres, kecemasan, dan depresi. Permasalahan kesehatan mental ini tidak dapat dipisahkan dari isu kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja. Remaja dengan kondisi psikologis yang rentan cenderung mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan, pengendalian diri, serta penetapan batasan dalam berinteraksi di lingkungannya. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap perilaku seksual berisiko, kekerasan dalam pacaran, kehamilan tidak diinginkan, dan dampak psikososial jangka panjang lainnya. Pendekatan holistik dalam kesehatan reproduksi remaja menjadi sangat penting dalam menjawab masalah tersebut. Pendekatan ini memandang kesehatan reproduksi sebagai hasil interaksi antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan kultural, serta menempatkan kesehatan mental sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari seksualitas remaja. Dengan pendekatan holistik, intervensi kesehatan tidak hanya berfokus pada pencegahan penyakit, tetapi juga pada penguatan kapasitas individu, pengembangan keterampilan hidup, serta penciptaan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang remaja secara optimal.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan dan praktik dalam bidang kesehatan reproduksi remaja dengan perspektif holistik berbasis bukti ilmiah. Buku ini mengintegrasikan hasil penelitian dari jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, serta mengaitkannya dengan kebijakan dan program kesehatan remaja di Indonesia. Pembahasan dalam buku ini mencakup perkembangan remaja, kesehatan mental, seksualitas, perilaku seksual berisiko, pengaruh lingkungan sosial dan digital, serta strategi intervensi dan pelayanan kesehatan yang ramah remaja.

Diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang kesehatan dan pendidikan, tenaga kesehatan, konselor, pendidik, serta

pengambil kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan program kesehatan reproduksi remaja yang komprehensif. Melalui pemahaman yang utuh dan berbasis pendekatan holistik, upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pencegahan masalah kesehatan, tetapi juga pada pembentukan generasi muda Indonesia yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional.

B. Konsep Kesehatan Reproduksi Holistik dalam Kebidanan

Kesehatan reproduksi pada awalnya dipahami secara sempit sebagai aspek biologis yang berkaitan dengan fungsi organ reproduksi, kehamilan, dan persalinan. Pendekatan ini berkembang seiring meningkatnya pemahaman bahwa pengalaman reproduksi manusia tidak terlepas dari kondisi psikologis, interaksi sosial, dan konteks budaya (Engel, 1977). World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa kesehatan reproduksi dan seksual adalah kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, sehingga kesehatan mental dan seksualitas merupakan komponen yang saling berkaitan dari kesehatan manusia secara menyeluruh (WHO, 2015).

Kesehatan reproduksi holistik adalah pendekatan pelayanan yang memandang perempuan sebagai individu yang utuh, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam kebidanan, pendekatan ini dikenal sebagai asuhan kebidanan holistik. Pendekatan holistik meliputi:

1. Aspek biologis: kondisi fisik, hormonal, dan sistem reproduksi
2. Aspek psikologis: emosi, stres, kesehatan mental, dan pengalaman traumatis
3. Aspek sosial-budaya: dukungan keluarga, peran gender, dan norma masyarakat
4. Aspek spiritual: nilai, keyakinan, dan makna kehamilan atau kesehatan reproduksi

Pendekatan ini penting karena perubahan reproduksi sering diikuti perubahan psikologis yang signifikan, terutama pada masa kehamilan dan nifas (Dunkel Schetter and Tanner, 2012).

C. Evolusi Konsep Kesehatan Reproduksi

1. Pendekatan Biomedis Klasik

Pendekatan biomedis memfokuskan pelayanan kesehatan pada diagnosis dan pengobatan penyakit melalui intervensi medis berbasis bukti biologis. Dalam kesehatan reproduksi, pendekatan ini menekankan aspek anatomi, fisiologi, dan patologi sistem reproduksi (Engel, 1977). Meskipun efektif dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam memahami faktor psikososial yang memengaruhi perilaku kesehatan dan pengalaman subjektif pasien (Patel et al., 2018).

2. Pergeseran Menuju Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan model biomedis dengan memasukkan dimensi psikologis dan sosial dalam pemahaman kesehatan. Dalam konteks kesehatan reproduksi, pendekatan ini mengakui bahwa keputusan reproduksi dipengaruhi oleh emosi, relasi, norma budaya, dan kondisi sosial ekonomi (Starrs et al., 2018).

Pendekatan ini sejalan dengan kerangka Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) yang menempatkan individu sebagai subjek dengan hak, bukan sekadar objek layanan kesehatan (WHO, 2015).

D. Model Biopsikososial dalam Kesehatan Reproduksi

1. Model biopsikososial

Menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hasil interaksi dinamis antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Model ini menjadi dasar konseptual penting dalam praktik kesehatan reproduksi holistik (Engel, 1977). Secara biologis, kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh hormon, status gizi, penyakit kronis, dan efek samping obat. Secara psikologis, stres, trauma, dan gangguan mental berperan besar dalam fungsi seksual dan keputusan reproduksi. Secara sosial, relasi pasangan, keluarga, dan norma masyarakat turut membentuk pengalaman reproduksi (Patel et al., 2018).

2. Seksualitas dalam Kerangka Biopsikososial–Spiritual

Seksualitas merupakan konstruksi multidimensi yang dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Model biopsikososial menekankan bahwa fungsi seksual tidak hanya ditentukan oleh organ reproduksi dan hormon, tetapi juga oleh emosi, kognisi, pengalaman relasional, serta norma sosial dan budaya (Engel, 1977; Bancroft, 2009). Dalam konteks pelayanan holistik, dimensi spiritual dan nilai personal juga menjadi penting, terutama di masyarakat yang memiliki landasan religius dan budaya yang kuat. World Health Organization mendefinisikan kesehatan seksual sebagai suatu keadaan kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial yang berhubungan dengan seksualitas, bukan sekadar ketiadaan penyakit atau disfungsi (WHO, 2015). Definisi ini menegaskan bahwa gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan trauma psikologis, secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kesejahteraan seksual seseorang.

3. Hubungan Dua Arah antara Kesehatan Mental dan Seksualitas

Hubungan antara kesehatan mental dan seksualitas bersifat dua arah dan saling memengaruhi. Gangguan kesehatan mental terbukti memiliki prevalensi tinggi terhadap disfungsi seksual, baik pada aspek hasrat, gairah, orgasme,

maupun kepuasan seksual. Sebuah tinjauan sistematis menunjukkan bahwa individu dengan depresi, gangguan kecemasan, gangguan obsesif-kompulsif, gangguan stres pascatrauma, dan skizofrenia memiliki risiko lebih tinggi mengalami disfungsi seksual dibanding populasi umum (Atlantis & Sullivan, 2012). Sebaliknya, masalah seksual yang tidak tertangani dapat menjadi sumber stres psikologis yang signifikan dan berkontribusi pada muncul atau memburuknya gangguan mental. Disfungsi seksual sering dikaitkan dengan penurunan harga diri, perasaan malu, kecemasan performa, serta konflik dalam hubungan intim, yang pada akhirnya meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan (McCabe et al., 2016). Kondisi ini menunjukkan pentingnya deteksi dini dan pendekatan terpadu dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

4. Pengaruh Gangguan Mental terhadap Fungsi Seksual

Depresi merupakan gangguan mental yang paling sering dikaitkan dengan disfungsi seksual. Anhedonia, kelelahan, gangguan tidur, dan distorsi kognitif yang menyertai depresi dapat menyebabkan penurunan hasrat seksual dan kepuasan hubungan intim (Clayton et al., 2014). Selain itu, kecemasan yang berlebihan dapat memicu *performance anxiety* yang berdampak negatif pada respons seksual, khususnya pada fase gairah dan orgasme. Gangguan stres pascatrauma, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual atau kekerasan dalam hubungan intim, memiliki dampak yang lebih kompleks. Trauma dapat menyebabkan penghindaran aktivitas seksual, nyeri saat berhubungan, serta respons emosional negatif seperti takut dan disosiasi (Bigras et al., 2017). Oleh karena itu, pelayanan kesehatan reproduksi harus mempertimbangkan riwayat trauma dan menerapkan prinsip *trauma-informed care*.

E. Kesehatan Mental dalam Pelayanan Kebidanan

Gangguan kesehatan mental memiliki prevalensi tinggi pada usia reproduktif dan berkontribusi signifikan terhadap morbiditas global. Depresi dan kecemasan terbukti memengaruhi fungsi seksual, keinginan memiliki anak, serta kepatuhan terhadap layanan kesehatan reproduksi (Patel et al., 2018).

Sebaliknya, pengalaman reproduksi seperti kehamilan tidak direncanakan, infertilitas, komplikasi obstetri, dan kekerasan seksual dapat menjadi pemicu gangguan mental, termasuk depresi dan gangguan stres pascatrauma (WHO, 2015).

Kesehatan mental merupakan fondasi penting dalam asuhan kebidanan. Kondisi mental yang baik membantu perempuan:

1. Menghadapi kehamilan dan persalinan dengan lebih siap
2. Menjalin hubungan ibu dan bayi yang sehat
3. Mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi

Gangguan kesehatan mental, seperti depresi perinatal, sering tidak terdeteksi dalam pelayanan rutin. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan mental perinatal berkontribusi terhadap komplikasi kehamilan dan penurunan kualitas hidup ibu (Fisher *et al.*, 2012). Oleh karena itu, bidan perlu melakukan skrining sederhana kesehatan mental, seperti observasi perilaku, komunikasi terapeutik, dan rujukan bila diperlukan.

F. Seksualitas dalam Perspektif Kebidanan Holistik

1. Seksualitas dalam kebidanan tidak hanya berkaitan dengan fungsi biologis, tetapi juga mencakup persepsi diri, relasi pasangan, dan nilai budaya. Pemahaman seksualitas yang holistik membantu bidan memberikan edukasi yang:

- a. Tidak menghakimi
- b. Sensitif terhadap budaya
- c. Berbasis kebutuhan perempuan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kesehatan seksual berkaitan erat dengan kesehatan mental dan kualitas hidup perempuan (McCabe *et al.*, 2016). Oleh karena itu, bidan perlu membangun komunikasi terbuka dan aman agar pasien merasa nyaman mengungkapkan permasalahan seksualnya.

2. Seksualitas sebagai Aspek Kesehatan Menyeluruh

Seksualitas merupakan aspek fundamental kehidupan manusia yang mencakup identitas, orientasi, relasi intim, serta ekspresi emosional. WHO menekankan bahwa kesehatan seksual bukan sekadar bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup pengalaman yang aman, memuaskan, dan bermakna (WHO, 2015). Pendekatan yang hanya berfokus pada resiko dan penyakit justru memperkuat stigma dan menghambat akses layanan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan reproduksi holistik perlu memandang seksualitas sebagai bagian positif dari kesehatan manusia (Fisher *et al.*, 2010).

G. Tantangan Pelayanan Kesehatan Mental dan Seksualitas

1. Beberapa tantangan yang sering dihadapi bidan dalam memberikan pelayanan asuhan, antara lain:
 - a. Adanya Stigma / tabu di masyarakat yang membahas kesehatan mental dan seksualitas
 - b. Kurangnya keterampilan komunikasi terapeutik
 - c. Fokus pelayanan yang masih dominan pada aspek fisik, tidak secara psikologis
 - d. Keterbatasan sistem rujukan kesehatan mental
 - e. Pengaruh norma sosial dan budaya yang ada dimasyarakat

Stigma ini sering menyebabkan perempuan enggan mengungkapkan masalah psikologis dan seksual (Grabe, Hyde and Lindberg, 2007).

2. Tantangan Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Era Modern

Stigma sosial terhadap isu seksualitas dan kesehatan mental masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan reproduksi, terutama di masyarakat dengan norma budaya yang kuat. Stigma ini berdampak pada rendahnya keterbukaan pasien dan keterlambatan pencarian bantuan (Starrs et al., 2018). Selain itu, fragmentasi layanan antara kesehatan fisik dan mental menyebabkan pelayanan yang tidak berkesinambungan, sehingga kebutuhan pasien tidak tertangani secara komprehensif (Patel et al., 2018).

H. Contoh Studi Kasus Kebidanan dan peran bidan dalam praktik komplementer

1. Studi Kasus 1: Ibu Hamil dengan Kecemasan Tinggi

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sulit tidur dan sering merasa takut menghadapi persalinan. Pemeriksaan fisik dalam batas normal.

Analisis Kebidanan: Masalah utama adalah kecemasan kehamilan yang dapat berdampak pada kesejahteraan ibu dan janin. Asuhan Holistik yang bisa bidan dilakukan untuk kasus ini adalah:

- a. Komunikasi terapeutik dan edukasi kehamilan
- b. Teknik relaksasi napas dalam
- c. Praktik komplementer: relaksasi guided imagery dan aromaterapi lavender
- d. Dukungan keluarga dan rujukan bila gejala menetap

2. Studi Kasus 2: Ibu Nifas dengan Penurunan Minat Seksual

Seorang perempuan umur 30 tahun post partum 5 minggu, datang ke Klinik, dengan keluhan penurunan minat seksual dan merasa tidak percaya diri terhadap tubuhnya, setelah melahirkan anak pertamanya.

Analisis Kebidanan: Masalah terkait perubahan psikologis nifas dan citra tubuh. Asuhan Holistik yang bisa dilakukan adalah:

- a. Edukasi perubahan fisiologis dan psikologis nifas
- b. Konseling pasangan
- c. Praktik komplementer: pijat relaksasi nifas dan yoga ringan
- d. Dukungan emosional berkelanjutan

3. Peran Bidan dalam Praktik Komplementer

Praktik komplementer yang dapat diterapkan oleh bidan secara aman dan efektif meliputi:

- a. Relaksasi dan teknik napas
- b. Pijat kehamilan dan nifas

- c. Hypnotherapy/ meditasi
- d. Yoga ibu hamil
- e. Aromaterapi dengan indikasi tepat

Praktik ini bertujuan meningkatkan kenyamanan, menurunkan stres dan kecemasan, dan mendukung kesehatan mental perempuan (Stuart, 2014).

I. Simpulan

Kesehatan mental dan seksualitas merupakan bagian integral dari pelayanan kebidanan holistik. Bidan berperan penting dalam deteksi dini, edukasi, dan pemberian asuhan komprehensif yang memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini mendukung tercapainya kesehatan reproduksi perempuan secara optimal. Kesehatan mental dan seksualitas merupakan komponen esensial yang tidak terpisahkan dari kesehatan reproduksi perempuan. Pendekatan pelayanan kebidanan yang hanya berfokus pada aspek biologis terbukti belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan kesehatan reproduksi holistik yang mencakup dimensi biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual menjadi kebutuhan utama dalam praktik kebidanan saat ini.

Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap kesehatan mental, bidan dapat berperan dalam deteksi dini gangguan psikologis, pencegahan masalah kesehatan seksual, serta peningkatan kualitas hidup perempuan di setiap tahap daur kehidupan. Seksualitas dalam perspektif holistik perlu dipahami sebagai bagian alami dan bermakna dalam kehidupan perempuan, yang dipengaruhi oleh kondisi mental, relasi interpersonal, serta nilai budaya dan spiritual. Buku ajar ini menegaskan peran strategis bidan sebagai pemberi asuhan kebidanan yang profesional, empatik, dan berpusat pada perempuan. Integrasi komunikasi terapeutik, edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, serta penerapan praktik komplementer yang aman dan beretika merupakan upaya nyata dalam mendukung pelayanan kebidanan holistik. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa Diploma Tiga Kebidanan mampu mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan kebidanan yang humanis, bermutu, dan berkelanjutan.

J. Referensi

- Atlantis, E. and Sullivan, T. (2012) Sexual dysfunction related to psychiatric disorders: a systematic review. *Journal of Sexual Medicine*, 9(10), pp.2383–2397.
- Bigras, N. et al. (2017) The impact of PTSD on sexual functioning. *Journal of Sex Research*, 54(7), pp.1–13.
- Clayton, A.H. et al. (2014) Antidepressant-induced sexual dysfunction. *Journal of Clinical Psychiatry*, 75(9), pp. e1071–e1080.
- Dunkel Schetter, C. and Tanner, L. (2012) 'Anxiety, depression and stress in pregnancy', *Current Opinion in Psychiatry*, 25(2), pp. 141–148.
- Engel, G.L. (1977) The need for a new medical model. *Science*, 196(4286), pp.129–136.
- Fisher, J., Cabral de Mello, M., Patel, V., Rahman, A., Tran, T., Holton, S. and Holmes, W. (2012) 'Prevalence and determinants of common perinatal mental disorders', *Bulletin of the World Health Organization*, 90(2), pp. 139–149.
- Grabe, S., Hyde, J.S. and Lindberg, S.M. (2007) 'Body objectification and depression in adolescents', *Psychology of Women Quarterly*, 31(2), pp. 164–175.
- McCabe, M.P. et al. (2016) Sexual dysfunction and mental health. *Lancet Psychiatry*, 3(3), pp.1–11.
- Stuart, G.W. (2014) *Principles and practice of psychiatric nursing*. 10th edn. St. Louis: Elsevier.
- World Health Organization (2015) *Sexual health, human rights and the law*. Geneva: WHO.
- World Health Organization (2022) *Consolidated guideline on HIV, viral hepatitis and STI prevention, diagnosis, treatment and care*. Geneva: WHO.
- World Health Organization (2022) *World mental health report: Transforming mental health for all*. Geneva: WHO.

K. Glosarium

- WHO: World Health Organization
- RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- PKPR: Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
- UKS: Usaha Kesehatan Sekolah
- SRHR: Sexual and Reproductive Health and Rights

CHAPTER 7

STRATEGI PROMOSI KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI MEDIA DIGITAL DAN EDUKASI KOMUNITAS

Dr. Queen Khoirun Nisa' Mairo, SST.Bdn., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan reproduksi mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang utuh terkait sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya, serta bukan sekadar bebas dari penyakit atau kecacatan (WHO, 2025). Pendekatan holistik pada kesehatan reproduksi tidak hanya menekankan aspek klinis, tetapi juga determinan sosial, budaya, dan psikologis yang memengaruhi pilihan hidup seseorang sepanjang siklus kehidupan (WHO, 2025). Urgensi promosi kesehatan reproduksi terletak pada meningkatnya risiko kesehatan yang berkonsekuensi pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, seperti kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, serta ketidakpastian pengambilan keputusan reproduktif pada remaja, ibu hamil, dan pasangan usia subur (Rosyidah, 2024; Agatta *et al.*, 2025).

Promosi kesehatan reproduksi bersifat preventif dan promotif, mendukung individu untuk mengambil keputusan yang informasional dan bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya, dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya di masing-masing komunitas (Nisa *et al.*, 2025). Pengetahuan yang kurang baik tentang isu reproduksi sering berakar pada keterbatasan akses informasi, mitos sosial, dan stigma budaya yang menghalangi diskusi secara terbuka tentang topik yang sensitif ini (Frontiers, 2024).

Era digital telah mengubah pola komunikasi dan akses informasi kesehatan. Intervensi digital yang berbasis teknologi, termasuk aplikasi mobile, media sosial, platform edukasi interaktif, dan layanan kesehatan online, menawarkan peluang besar untuk memperluas jangkauan promosi kesehatan reproduksi dengan cara yang lebih menarik, personal, dan mudah diakses masyarakat secara luas, terutama generasi muda (Rohman & Aniroh, 2025). Bukti dari kajian internasional mengindikasikan bahwa intervensi digital dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik reproduksi sehat di kalangan remaja dengan efektivitas signifikan bila dirancang secara kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Akan tetapi, teknologi juga menimbulkan tantangan baru, seperti kesenjangan digital antara kelompok masyarakat, risiko penyebaran informasi, dan kebutuhan konten yang sensitif budaya dan bahasa agar edukasi kesehatan reproduksi dapat diterima

secara luas. Paradigma promosi kesehatan reproduksi kini harus menggabungkan pendekatan digital dan komunitas sehingga strategi edukasi tidak hanya cepat dan luas, tetapi juga relevan dan inklusif secara sosial-budaya.

Kelompok sasaran promosi kesehatan reproduksi sangat beragam, mulai dari remaja, ibu hamil, pasangan usia subur, hingga kelompok komunitas tertentu lainnya. Pada remaja, risiko seperti perilaku seksual berisiko, kehamilan di luar rencana, dan transmisi infeksi seksual sering merupakan puncak dari rendahnya literasi kesehatan reproduksi dan tekanan sosial, termasuk pengaruh teman sebaya. Di banyak komunitas baik pedesaan dan perkotaan, remaja seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses informasi yang akurat dan ramah usia, yang kemudian dapat memicu sikap negatif terhadap layanan kesehatan reproduksi (Frontiers, 2024).

Ibu hamil juga menghadapi tantangan berupa akses layanan prenatal yang memadai serta informasi yang tepat mengenai persiapan kehamilan, nutrisi, dan komplikasi potensial, yang semuanya penting untuk hasil kehamilan yang sehat. Sedangkan pasangan usia subur, terutama yang merencanakan kehamilan, memerlukan edukasi terintegrasi mengenai kesehatan pra-konsepsi, nutrisi, serta manajemen risiko reproduksi yang komprehensif.

Tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, apoteker, dan ahli gizi memiliki peran strategis dalam promosi kesehatan reproduksi. Bidan dan perawat berada di garis depan pelayanan kesehatan primer, memberikan edukasi dan dukungan langsung kepada individu serta keluarga terkait isu reproduksi, gizi, dan perencanaan keluarga. Peran ini menjadi lebih kuat ketika dikombinasikan dengan pemanfaatan media digital untuk menyebarkan informasi yang valid, interaktif, dan mudah dipahami oleh beragam kelompok sasaran (Rosyidah, 2024). Edukasi berbasis komunitas, termasuk pelatihan kader kesehatan, diskusi kelompok, dan kegiatan partisipatif lainnya, memperkuat pesan promosi kesehatan dengan memanfaatkan kearifan lokal serta dukungan sosial dalam komunitas (Sakti *et al.*, 2025). Model integratif ini mendorong kolaborasi antara tenaga kesehatan dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku kesehatan yang berkelanjutan.

Promosi kesehatan reproduksi di era digital dan komunitas menuntut kemampuan profesional kesehatan untuk tidak hanya memberikan informasi klinis, tetapi juga memfasilitasi komunikasi efektif melalui platform digital maupun interaksi tatap muka dalam komunitas. Integrasi ini memastikan pesan kesehatan reproduksi tidak hanya sampai ke target sasaran, tetapi juga dipahami, diterima, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

B. Konsep Dasar Promosi Kesehatan Reproduksi Holistik

1. Definisi dan Prinsip Kesehatan Reproduksi Holistik

Kesehatan reproduksi tidak hanya merujuk pada aspek fisik dari sistem reproduksi, tetapi mencakup keadaan *well-being* yang utuh secara fisik, mental, dan sosial tanpa sekadar bebas dari penyakit atau cacat (WHO, 2025). Definisi ini menunjukkan orientasi yang sejalan dengan pendekatan holistik yang melihat individu secara menyeluruh dalam konteks kehidupannya, bukan hanya gejala klinis semata. Pendekatan holistik menekankan keseimbangan antara berbagai dimensi manusia serta kebutuhan keseluruhan individu dalam mencapai kesehatan reproduksi optimal. Misalnya, dalam konteks pelayanan medis di Indonesia, model perawatan holistik telah diidentifikasi sebagai kebutuhan karena pendekatan biomedis konvensional seringkali fokus semata pada aspek fisik tanpa mempertimbangkan faktor emosional, sosial, atau budaya yang turut memengaruhi kesehatan perempuan (Tepy et al., 2024).

Prinsip holistik dalam kesehatan reproduksi mencakup keterpaduan intervensi klinis dengan dukungan psikososial serta penghargaan terhadap nilai budaya komunitas. Pendekatan ini juga memperhatikan pemberdayaan individu dan komunitas untuk membuat keputusan yang informatif dan menghormati hak serta kebebasan reproduktif mereka (WHO, 2025). Di konteks penelitian, konsep kesehatan reproduksi holistik ini juga sejalan dengan pembahasan tentang *reproductive justice*, yang menekankan kesejahteraan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi, serta hak asasi dalam praktik kesehatan reproduksi (Rosyidah, 2024).

2. Dimensi Biologis, Psikologis, Sosial, Budaya, dan Spiritual

Pendekatan holistik dalam kesehatan reproduksi menuntut pemahaman multidimensi terhadap manusia. Secara biologis, kesehatan reproduksi mencakup fungsi fisiologis dan organ reproduksi yang sehat, termasuk menstruasi, kehamilan, persalinan, serta pencegahan dan pengobatan penyakit terkait (WHO, 2025). Namun, aspek ini tidak berdiri sendiri. Dimensi psikologis, seperti kesejahteraan emosional dan kemampuan menghadapi transisi kehidupan reproduktif, merupakan elemen penting untuk mendukung kualitas hidup individu secara keseluruhan (Wulansari, 2025).

Selain itu, faktor sosial juga memainkan peran besar dalam menentukan kesehatan reproduksi. Norma sosial, struktur keluarga, akses layanan kesehatan, serta pendidikan kesehatan berkontribusi pada sejauh mana individu dapat mengakses dan memanfaatkan informasi serta layanan kesehatan reproduksi. Kajian promosi kesehatan di kalangan remaja menunjukkan bahwa dukungan

sosial dan akses informasi berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan serta praktek kesehatan reproduksi yang sehat (Sonjati et al., 2025).

Dimensi budaya juga tidak bisa diabaikan, karena keyakinan lokal dan praktik tradisional dapat memengaruhi sikap serta perilaku terhadap kesehatan reproduksi. Intervensi promosi kesehatan yang gagal mempertimbangkan konteks budaya seringkali tidak efektif atau bahkan berkonflik dengan nilai komunitas (Umaroh & Karjoso, 2025). Terakhir, dimensi spiritual, yang kadang kurang diangkat secara eksplisit dalam literatur kesehatan publik, juga merupakan bagian dari kesejahteraan manusia. Kesejahteraan spiritual dapat menguatkan sistem nilai dan makna hidup individu, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan dan perilaku kesehatan mereka.

3. Promosi Kesehatan sebagai Upaya Preventif dan Promotif Berkelanjutan

Promosi kesehatan reproduksi merupakan strategi preventif dan promotif yang bertujuan mencegah masalah kesehatan reproduksi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup kegiatan edukasi, peningkatan akses informasi, dan pembentukan lingkungan yang mendukung keputusan kesehatan yang informatif (Sunarsih et al., 2020). Dalam konteks remaja, promosi kesehatan reproduksi mampu meningkatkan pemahaman serta sikap positif terhadap perilaku hidup sehat yang berkaitan dengan seksual dan reproduksi (Sumaryani & Purwaningsih, 2025).

Strategi edukasi yang berkelanjutan dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sekolah, keluarga, dan fasilitas kesehatan, dapat memperkuat pesan kesehatan dan mendorong perubahan perilaku jangka panjang. Pendekatan edukatif ini juga membuka ruang dialog yang lebih luas tentang isu sensitif, seperti kontrasepsi, hubungan seksual yang aman, serta hak-hak reproduksi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (WHO, 2025).

4. Posisi Promosi Kesehatan Reproduksi dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Dalam sistem pelayanan kesehatan, promosi kesehatan reproduksi seharusnya menjadi komponen integral yang berjalan paralel dengan layanan medis klinis. Layanan kesehatan yang hanya terfokus pada intervensi klinis tanpa disertai promosi pendidikan dan pencegahan akan cenderung kurang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas (Agatta *et al.*, 2025). Promosi kesehatan reproduksi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mengurangi beban morbiditas dan mortalitas akibat komplikasi kehamilan, infeksi menular seksual, atau masalah kesehatan lain yang dapat dicegah melalui edukasi dan dukungan komunitas.

Posisi ini tercermin dalam upaya pengembangan program kesehatan berbasis komunitas maupun digital yang mengutamakan akses informasi yang

mudah dan inklusif, sehingga individu dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak terkait kesehatan reproduksi mereka. Keterpaduan antara layanan medis dan promosi kesehatan bersifat sinergis, di mana dukungan komunitas, tenaga kesehatan terlatih, serta media edukasi berkontribusi pada kesadaran, pencegahan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi.

C. Landasan Teoretis Promosi Kesehatan Reproduksi

1. Health Promotion Model (HPM)

Health Promotion Model (HPM) adalah sebuah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Nola J. Pender untuk memahami faktor-faktor penentu perilaku promosi kesehatan dan merancang intervensi yang efektif guna meningkatkan kesehatan individu dan populasi (Pender *et al.*, 2011). HPM menekankan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh karakteristik individu, pengalaman sebelumnya, persepsi tentang manfaat dan hambatan tindakan sehat, serta pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang berinteraksi secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari seseorang (Pender *et al.*, 2011; Amir, 2025). Penelitian penerapan HPM di bidang kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wanita usia subur terhadap penggunaan kontrasepsi implant, yang pada gilirannya berkontribusi pada perubahan sikap dan perilaku terkait keputusan reproduksi (Amir, 2025).

HPM memandang individu sebagai makhluk biopsikososial yang secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan kesehatan yang dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dan faktor perilaku spesifik yang berkaitan dengan tindakan promosi kesehatan (Pender *et al.*, 2011). Dengan demikian, model ini menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk memahami motivasi dan proses perubahan perilaku dalam promosi kesehatan reproduksi, seperti keputusan untuk menggunakan kontrasepsi, pemeriksaan kesehatan reproduksi berkala, dan perilaku seksual protektif.

2. Health Belief Model (HBM)

Health Belief Model (HBM) adalah salah satu teori perilaku paling banyak digunakan dalam ilmu kesehatan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku individu dalam konteks kesehatan. Dikembangkan pada tahun 1950-an oleh Rosenstock dan rekan-rekannya, HBM menyatakan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap ancaman suatu kondisi kesehatan dan persepsi terhadap manfaat dan hambatan tindakan preventif yang tersedia (Rosenstock, 1974 dalam *Health Belief Model*, 2025). Model ini terdiri dari beberapa konstruk kognitif utama, seperti *perceived susceptibility* (persepsi

kerentanan), *perceived severity* (persepsi keparahan), *perceived benefits* (manfaat yang dirasakan), *perceived barriers* (hambatan yang dirasakan), *self-efficacy*, dan *cues to action* (pemicu tindakan).

Dalam konteks kesehatan reproduksi, HBM telah digunakan untuk memahami perilaku seperti pencegahan perilaku seksual berisiko pada remaja dan partisipasi dalam pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) di kalangan wanita usia subur (Kustin & Handayani, 2025; Titisari et al., 2018). Penelitian lain menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan berbasis HBM dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi, yang kemudian berkorelasi dengan perubahan perilaku yang lebih sehat (Harahap *et al.*, 2024).

HBM berkontribusi pada perencanaan promosi kesehatan reproduksi dengan menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran akan risiko reproduksi, menurunkan hambatan terhadap tindakan kesehatan, serta meningkatkan efikasi diri dalam menerapkan perilaku protektif. Walaupun HBM sering dikritik karena kurang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, model ini tetap berperan penting sebagai fondasi untuk memprediksi dan mempengaruhi perilaku reproduksi sehat ketika digabungkan dengan pendekatan kontekstual lainnya.

3. Teori Self-Care

Teori *Self-Care* yang dikembangkan oleh Dorothea E. Orem merupakan teori keperawatan yang menekankan kemampuan individu untuk melakukan perawatan terhadap diri sendiri sebagai bagian dari proses mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatannya (Orem, 1959–2001). Dalam teori ini, individu dianggap memiliki kemampuan *self-care agency* yang memungkinkan mereka mengambil tindakan proaktif terhadap kesehatan mereka, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi. *Self-care* mencakup tindakan seperti pengelolaan gizi, pengawasan kesehatan reproduksi secara mandiri, serta kepatuhan terhadap program pencegahan seperti skrining dan penggunaan kontrasepsi.

Orem menegaskan bahwa ketika individu tidak mampu melakukan *self-care* karena keterbatasan fisik, psikologis, atau pengetahuan, intervensi tenaga kesehatan dibutuhkan dalam bentuk dukungan edukatif atau sistem perawatan parsial/ kompensatoris (Orem's Self-Care Deficit Theory). Implementasi teori *self-care* dalam promosi kesehatan reproduksi bertujuan memberdayakan individu agar lebih aktif, bertanggung jawab, dan berpengetahuan dalam menjaga kesehatannya sendiri, suatu pendekatan yang sangat relevan dalam konteks pemberdayaan pasien dan pendidikan kesehatan berbasis media digital maupun komunitas.

4. Teori Pemberdayaan dan Perubahan Perilaku Berbasis Komunitas

Teori pemberdayaan (*community empowerment*) berfokus pada proses di mana komunitas diberi alat, pengetahuan, dan kekuatan untuk mengambil keputusan yang memengaruhi kesehatan mereka serta mengontrol faktor-faktor yang menentukan kesehatan tersebut (WHO, 2025). Pendekatan ini melampaui sekadar keterlibatan komunitas dalam kegiatan kesehatan; komunitas secara aktif memiliki dan mengendalikan proses perubahan, mengambil peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi promosi kesehatan.

Pemberdayaan komunitas dalam promosi kesehatan reproduksi sering diwujudkan melalui pelatihan kader, kelompok dukungan sebaya (*peer support*), dan kampanye komunitas yang memperkuat kontrol sosial dalam perilaku kesehatan positif. Pendekatan ini bertujuan menciptakan perubahan struktur sosial, norma, dan nilai yang mendukung perilaku reproduksi sehat, sekaligus meningkatkan kapasitas komunitas untuk mengatasi tantangan kesehatan di masa depan.

5. Integrasi Teori Perilaku dalam Perencanaan Promosi Kesehatan Reproduksi

Integrasi berbagai teori perilaku seperti HPM, HBM, *self-care*, dan pemberdayaan komunitas merupakan strategi ideal dalam merancang program promosi kesehatan reproduksi yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan teori terintegrasi memungkinkan perencana program memahami perilaku kesehatan dari berbagai dimensi: kognitif, sosial, budaya, dan struktural, sehingga intervensi dapat lebih tepat sasaran dan berdampak luas.

Sebagai contoh, program edukasi digital yang memanfaatkan perangkat media sosial dapat dirancang berdasarkan prinsip HPM dan HBM untuk meningkatkan motivasi individu, dilengkapi materi *self-care* untuk memberdayakan individu dalam pengelolaan kesehatannya, serta disertai pendekatan komunitas untuk menciptakan dukungan sosial dan lingkungan yang kondusif bagi perubahan perilaku jangka panjang. Dengan demikian, penggunaan teori perilaku secara terpadu memperkaya strategi promosi kesehatan dan meningkatkan kemungkinan perubahan perilaku yang konsisten dan berkelanjutan di masyarakat.

D. Media Digital sebagai Strategi Promosi Kesehatan Reproduksi

1. Literasi Kesehatan Digital (*Digital Health Literacy*)

Literasi kesehatan digital (*digital health literacy*) merupakan kemampuan individu untuk mencari, menemukan, memahami, mengevaluasi, dan menerapkan informasi kesehatan yang diperoleh melalui media digital secara efektif guna membuat keputusan kesehatan yang tepat (World Health Organization; American Library Association, 2017; *eHealth Literacy* di PSNet).

Konsep ini merupakan pertemuan antara literasi digital dan literasi kesehatan, di mana seseorang tidak hanya mampu menggunakan teknologi digital, tetapi juga mampu menilai kredibilitas dan relevansi informasi kesehatan yang mereka akses secara online (Ban *et al.*, 2023).

Dalam konteks promosi kesehatan reproduksi, literasi kesehatan digital menjadi prasyarat penting bagi target sasaran, terutama remaja dan pasangan usia subur, agar mereka dapat memilah informasi yang akurat dari hoaks atau informasi kurang ilmiah yang beredar di internet (Hafid *et al.*, 2025; Rosyidah, 2025). Program pelatihan literasi digital telah terbukti meningkatkan pemahaman remaja tentang isu kesehatan reproduksi dengan strategi simulasi, ceramah, dan roleplay, yang membantu peserta memahami konten dengan lebih tepat dan aplikatif.

2. Jenis dan Karakteristik Media Digital untuk Edukasi Kesehatan

a. Website Edukasi Kesehatan

Website kesehatan merupakan platform digital berbasis teks, gambar, dan multimedia yang menyediakan informasi terstruktur mengenai isu kesehatan. Contohnya situs resmi lembaga kesehatan atau portal khusus promosi kesehatan reproduksi yang memuat panduan kontrasepsi, pencegahan infeksi menular seksual, serta artikel edukatif lain yang dapat diakses kapan saja. Intervensi berbasis *web* telah menunjukkan efek positif dalam peningkatan pengetahuan tentang keluarga berencana dan alat kontrasepsi, yang ditunjukkan oleh peningkatan skor pengetahuan setelah partisipan terlibat dalam media edukasi berbasis web.

b. Media Sosial

Media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan WhatsApp telah menjadi saluran utama penyebaran informasi kesehatan di era digital. Platform ini bersifat interaktif dan memungkinkan pesan kesehatan disampaikan melalui posting, video pendek, *infografik*, dan sesi tanya jawab live. Studi menunjukkan bahwa media sosial efektif dalam menjangkau audiens luas, termasuk remaja, dan dapat meningkatkan pengetahuan serta *engagement* terhadap isu kesehatan reproduksi ketika konten disajikan secara menarik dan komunikatif. Namun, studi juga menunjukkan bahwa paparan pada media sosial harus diiringi kemampuan menilai kualitas konten karena potensi informasi yang kurang akurat atau *misinformation* dapat berdampak negatif pada persepsi dan perilaku kesehatan.

c. Aplikasi Kesehatan dan Teleedukasi

Aplikasi kesehatan dan layanan *teleedukasi* memanfaatkan kemampuan teknologi mobile untuk mengirimkan konten edukatif, pengingat kesehatan,

dan konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan. Aplikasi tersebut sering kali dilengkapi modul interaktif, kuis pendidikan, dan *chatbot* yang memandu pengguna melalui pertanyaan dan langkah-langkah pencegahan atau perawatan reproduksi. Teknologi ini memberikan akses yang lebih personal dan real-time, sehingga pengguna dapat belajar secara mandiri dengan dukungan fitur yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

3. Prinsip Pengembangan Konten Kesehatan Reproduksi yang Efektif dan Etis

Konten edukasi kesehatan reproduksi harus dikembangkan berdasarkan prinsip *evidence-based*, akurat, mudah dipahami, sensitif budaya, dan sesuai dengan etika kesehatan. Materi yang dikomunikasikan harus jelas mengandung referensi ilmiah, memperhatikan sensitivitas bahasa dan kebudayaan, serta sesuai dengan batasan usia audiens, khususnya untuk konten yang menyasar remaja. Penyajian konten juga harus mempertimbangkan hak privasi pengguna dan memastikan keamanan data pribadi, terutama pada platform yang memerlukan pendaftaran atau pertukaran informasi pribadi.

Pengembangan konten yang etis juga mencakup keterlibatan tenaga kesehatan profesional dalam penyusunan materi agar tidak terjadi penyebaran informasi tidak tepat yang dapat merugikan kesehatan reproduksi masyarakat. Kejujuran, objektivitas, dan akurasi informasi adalah kunci yang harus dipatuhi oleh pengembang konten dan penyedia media digital.

4. Pendekatan Komunikasi Persuasif dan Visual Edukatif

Pendekatan komunikasi persuasif dan visual edukatif memegang peran penting dalam keberhasilan strategi promosi kesehatan reproduksi melalui media digital. Informasi yang disampaikan secara persuasif mampu memengaruhi sikap dan mendorong perubahan perilaku kesehatan, misalnya dengan memanfaatkan cerita (*storytelling*) yang relevan, pesan positif, dan ajakan bertindak yang jelas. Visual edukatif seperti infografik, video penjelasan pendek, animasi, dan konten multimedia lainnya terbukti meningkatkan daya tarik serta pemahaman audiens terhadap materi kesehatan reproduksi dibandingkan hanya teks biasa. Komunikasi visual yang baik memudahkan audiens memahami konsep kesehatan kompleks, serta meminimalisir hambatan informasi yang bisa terjadi karena rendahnya kemampuan membaca atau literasi kesehatan.

5. Kelebihan dan Keterbatasan Media Digital dalam Promosi Kesehatan

Kelebihan:

- a. Jangkauan luas: Media digital mampu menyampaikan pesan kesehatan ke audiens yang luas dengan biaya efektif dan cepat menjangkau kelompok yang sebelumnya sulit diakses, seperti remaja di daerah terpencil.

- b. Interaktif dan responsif: Fitur *feedback*, komentar, dan *analytics* memungkinkan penyelenggara program mengevaluasi efektivitas konten dan menyesuaikannya secara real-time.
- c. Akses fleksibel: Informasi dapat diakses kapan saja oleh individu sesuai kebutuhan mereka, meningkatkan kesempatan belajar mandiri.

Keterbatasan:

- a. Kesenjangan digital: Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses setara terhadap teknologi digital, yang bisa menyebabkan *digital divide* dalam akses kesehatan reproduksi.
- b. Risiko *misinformation*: Konten yang tidak tervalidasi dapat menyebar dengan cepat, sehingga menimbulkan kesalahpahaman atau perilaku risiko terkait kesehatan reproduksi.
- c. Privasi dan keamanan data: Penggunaan platform digital berpotensi melibatkan pertukaran data pribadi yang rawan disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik.

E. Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Komunitas

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan

Edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas merupakan strategi yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat agar dapat mengambil peran aktif dalam mengatasi isu-isu kesehatan reproduksi yang relevan dengan konteks sosial-budaya mereka. Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana individu dan komunitas memperoleh keterampilan, sumber daya, dan kepercayaan diri untuk mengatur isu-isu kesehatan mereka sendiri serta membuat keputusan yang informatif tentang kesehatan reproduksi (WHO, 2025). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kapasitas komunitas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi inisiatif kesehatan mereka sendiri secara berkelanjutan.

Beberapa studi pengabdian masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas melalui edukasi kesehatan reproduksi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan kesehatan, serta menurunkan stigma terkait isu reproduksi yang sering dianggap tabu di lingkungan lokal. Misalnya, pendekatan edukatif di Desa Bunde berhasil mendorong keterbukaan diskusi mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap positif di antara peserta setelah intervensi edukasi (Fadhilah, 2025).

2. Edukasi Berbasis Keluarga, Sekolah, dan Komunitas

Edukasi kesehatan reproduksi yang efektif berbasis komunitas melibatkan bukan hanya individu, tetapi juga sistem sosial utama seperti keluarga dan sekolah. Keluarga sering menjadi lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku reproduktif, khususnya melalui komunikasi orang tua-anak tentang nilai, norma, dan strategi pencegahan risiko kesehatan reproduksi. Intervensi pemberdayaan ibu melalui kelompok PKK di Desa Jabung berhasil meningkatkan pengetahuan ibu tentang kesehatan reproduksi anak dan peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini, yang merupakan salah satu masalah kesehatan reproduksi bagi remaja (Astutik & Apsari, 2024).

Sekolah juga merupakan arena penting untuk edukasi kesehatan reproduksi, terutama bagi remaja. Program berbasis sekolah dengan pendekatan *peer education* (pendidikan sebaya) telah terbukti efektif dalam membantu remaja memahami isu-isu kompleks yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi karena materi disampaikan oleh pihak yang dipandang dekat dan relevan oleh para peserta (Pertiwi & Mariyam, 2025).

Pendekatan komunitas, misalnya melalui kader kesehatan lokal dan kelompok dukungan sebaya, memperkuat pesan edukatif di luar lingkungan formal. Pembentukan komunitas remaja peduli kesehatan reproduksi di Universitas Bengkulu menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam kelompok komunitas dapat meningkatkan kepedulian dan pengetahuan mereka terhadap isu kesehatan reproduksi, yang bukan hanya bermanfaat bagi diri mereka tetapi juga sebagai agen perubahan dalam komunitas yang lebih luas.

3. Peran Kader Kesehatan dan Tokoh Masyarakat

Kader kesehatan komunitas dan tokoh masyarakat merupakan aktor penting dalam pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi. Kader kesehatan, yang biasanya merupakan warga lokal yang terlatih, berfungsi sebagai penghubung antara komunitas dan sistem kesehatan formal, serta pendorong tindakan kesehatan di tingkat akar rumput. Pelatihan kader untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi telah terbukti meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi yang akurat dan relevan kepada kelompok masyarakat, termasuk remaja dan orang tua (Wulansari, 2025).

Tokoh masyarakat seperti pemimpin adat, kepala desa, dan agama memiliki pengaruh besar terhadap sikap dan nilai dalam komunitas. Keterlibatan tokoh-tokoh ini dalam program edukasi penting untuk mengatasi hambatan budaya dan menyesuaikan pesan kesehatan dengan nilai-nilai lokal. Hal ini relevan terutama di komunitas yang menganggap isu kesehatan reproduksi sebagai hal sensitif atau tabu, sehingga dukungan sosial dari tokoh masyarakat dapat mendorong keterbukaan dan partisipasi aktif warga.

4. Pendekatan Budaya, Nilai Lokal, dan Kearifan Komunitas

Pendekatan edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas tidak dapat lepas dari konteks budaya dan nilai lokal. Kearifan lokal merupakan sumber daya penting dalam merancang materi edukatif yang diterima dengan baik oleh komunitas. Sebuah studi eksperimen di Desa Danau Usung menunjukkan bahwa penggunaan modul edukasi yang memadukan cerita rakyat, diskusi tokoh adat, serta permainan tradisional sebagai media edukasi secara signifikan meningkatkan literasi kesehatan reproduksi remaja di wilayah pedesaan (Anita, 2025).

Pendekatan penggabungan kearifan budaya lokal ini membantu memecah hambatan sosial dan stigma yang sering menghambat diskusi terbuka tentang isu reproduksi. Dengan menyisipkan nilai-nilai budaya, peserta tidak hanya menerima informasi baru, tetapi juga melihat relevansi informasi tersebut dengan kehidupan sehari-hari dan tradisi mereka, sehingga kemungkinan perubahan perilaku menjadi lebih tinggi.

5. Strategi Edukasi pada Kelompok Rentan dan Spesifik

Kelompok rentan seperti remaja putri, anak usia sekolah, atau pasangan usia subur memiliki kebutuhan edukasi yang spesifik dalam konteks kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja putri, misalnya, telah ditargetkan melalui program berbasis partisipatif yang menggunakan diskusi kelompok, simulasi, dan edukasi multimedia, yang terbukti meningkatkan pengetahuan secara signifikan serta mampu menjadi upaya pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan perilaku berisiko lain (Marpaung, 2025).

Strategi edukasi yang efektif untuk kelompok rentan juga melibatkan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, seperti penggunaan permainan edukatif, pelatihan interaktif, serta forum diskusi yang aman dan mendukung. Di Desa Lantoyaya, misalnya, edukasi interaktif berbasis game terbukti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja dalam memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi (Longgupa *et al.*, 2025).

Selain itu, program edukasi harus mempertimbangkan situasi kehidupan spesifik kelompok sasaran, termasuk status sosial, akses terhadap layanan kesehatan, serta hambatan ekonomi atau geografis yang dapat membatasi partisipasi mereka. Pendekatan yang sensitif terhadap dinamika kehidupan kelompok rentan akan memperbesar dampak edukasi kesehatan reproduksi di tingkat komunitas.

F. Integrasi Media Digital dan Edukasi Komunitas dalam Promosi Kesehatan Reproduksi

1. Model Promosi Kesehatan Reproduksi Integratif (Digital–Komunitas)

Promosi kesehatan reproduksi kini tidak lagi berpijak pada satu pendekatan tunggal, tetapi bergerak menuju model integratif yang menggabungkan kekuatan teknologi digital dan pendekatan komunitas berbasis lokal. Pendekatan integratif ini memadukan jangkauan luas dan kecepatan distribusi informasi dari media digital dengan kedalaman interaksi sosial dan dukungan komunitas di lingkungan lokal, sehingga mampu menjawab kebutuhan promotif dan preventif secara lebih komprehensif (Adediran *et al.*, 2024).

Model ini menempatkan media digital sebagai saluran informasi, edukasi, dan dialog dua arah, sementara komunitas berfungsi sebagai ruang di mana informasi tersebut dikontekstualisasikan, diperkuat, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, materi kesehatan reproduksi tidak hanya disampaikan secara masif melalui platform digital, tetapi juga didukung oleh kegiatan tatap muka, diskusi kelompok, dan advokasi lokal yang memudahkan pemahaman dan perubahan perilaku (Rosyidah, 2024).

Pendekatan ini sejalan dengan tren global penggunaan teknologi digital dalam promosi kesehatan reproduksi yang semakin berkembang, seperti dalam kajian systematic review yang menunjukkan potensi besar alat edukasi digital untuk mencapai target populasi yang luas, terutama di kalangan remaja.

2. Sinkronisasi Pesan dan Metode Edukasi

Kunci keberhasilan integrasi media digital dan edukasi komunitas adalah sinkronisasi pesan dan metode edukasi sehingga konten yang disampaikan secara daring dapat didukung dan diperkuat melalui komunikasi tatap muka di komunitas. Sinkronisasi ini mencakup kesesuaian materi edukasi di media digital dengan nilai-nilai lokal dan konteks komunitas, sehingga pesan yang sama tidak terkesan kontradiktif ketika disampaikan di kedua ruang tersebut. Strategi sinkronisasi dimulai dengan *needs assessment* yang komprehensif terhadap kelompok sasaran untuk mengetahui kebutuhan informasi, preferensi akses media, serta hambatan budaya atau sosial yang berlaku di komunitas. Kemudian, hasil assessment tersebut dijadikan dasar untuk menyusun materi digital yang kompatibel dengan modul kegiatan komunitas seperti diskusi kelompok, penyuluhan langsung, atau forum orang tua-anak.

Selain itu, sinkronisasi cara penyampaian juga penting. Jika media digital sering menggunakan pendekatan visual dan multimedia untuk menjangkau remaja, kegiatan komunitas dapat menggunakan metode interaktif seperti diskusi

dialogis, role play, atau simulasi kasus untuk memperdalam pemahaman dan konsolidasi pesan yang sama secara kontekstual.

3. Penguatan Self-Efficacy dan Komitmen Perubahan Perilaku

Integrasi digital-komunitas dalam promosi kesehatan reproduksi tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi semata, tetapi juga menguatkan *self efficacy*, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk mengambil tindakan yang bermanfaat bagi kesehatannya, serta komitmen perubahan perilaku. Strategi ini vital karena perubahan perilaku tidak hanya terjadi karena tahu informasi, tetapi juga karena individu percaya bahwa mereka mampu melakukan perubahan tersebut dan didukung lingkungan sosialnya.

Media digital dapat dirancang untuk meningkatkan self-efficacy melalui konten yang bersifat motivasional, tutorial interaktif, dan testimoni positif dari sesama anggota komunitas atau pengguna layanan. Misalnya, video edukasi dengan studi kasus yang relevan bagi remaja yang menunjukkan langkah-langkah konkret dalam pengambilan keputusan sehat dapat meningkatkan rasa percaya diri pemirsa dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Di sisi komunitas, kegiatan peer support seperti support group, kelompok diskusi remaja atau forum orang tua dapat memberikan dukungan sosial yang kuat untuk memperkuat komitmen perubahan perilaku. Dalam setting ini, anggota komunitas berbagi pengalaman, memberikan dorongan, serta mengakui upaya positif dari individu lain, yang pada akhirnya membantu memperkuat keyakinan mereka untuk mempertahankan perilaku sehat.

4. Contoh Penerapan dan Praktik Baik Promosi Kesehatan Reproduksi

Beberapa praktik baik integrasi media digital dan edukasi komunitas telah diterapkan di berbagai konteks sebagai model sukses. Di Indonesia, kegiatan pengabdian masyarakat yang memadukan pendekatan digital dengan dialog komunitas menunjukkan keberhasilan signifikan dalam meningkatkan pemahaman remaja putri tentang kesehatan reproduksi dan literasi digital (Rosyidah, 2024). Implementation seperti pelatihan kader lokal untuk menjadi promotor digital menunjukkan bagaimana peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan media digital dapat memperkuat pesan komunitas. Dalam kegiatan tersebut, kader kesehatan dilatih untuk membuat konten kampanye kesehatan sederhana yang kemudian dibagikan melalui platform digital dan didiskusikan dalam kegiatan komunitas offline, seperti pertemuan RW atau kelompok remaja. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan penggunaan teknologi oleh masyarakat umum. Selain itu, program pendidikan kesehatan reproduksi yang melibatkan pembuatan konten digital oleh siswa dan remaja di sekolah yang kemudian dipresentasikan dan

didiskusikan bersama keluarga dan tenaga kesehatan di komunitas juga menunjukkan dampak positif terhadap kesadaran dan perubahan sikap terhadap isu-isu seperti pernikahan dini, pencegahan infeksi menular seksual, dan rencana keluarga (Selly *et al.*, 2025).

Model seperti *Reach A Hand Uganda* juga memperlihatkan bagaimana platform digital yang terintegrasi dengan kegiatan komunitas dapat memperluas jangkauan informasi serta menciptakan jaringan dukungan antar-pengguna, dengan menawarkan konten yang tidak hanya informatif tetapi juga relevan secara budaya serta didukung oleh advokasi lokal.

G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Promosi Kesehatan Reproduksi

Promosi kesehatan reproduksi merupakan elemen penting dalam meningkatkan kesehatan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Tenaga kesehatan termasuk bidan, perawat, apoteker, dan ahli gizi berperan strategis dalam edukasi, pencegahan, serta penguatan perilaku sehat sepanjang siklus kehidupan reproduksi. Peran ini semakin optimal bila diwujudkan melalui pendekatan holistik dan kolaborasi interprofesional yang efektif.

1. Peran Bidan

Bidan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan reproduksi di banyak sistem kesehatan, terutama pada tahap antenatal, persalinan, dan pascanatal (Mattison *et al.*, 2020). Mereka tidak hanya memberikan layanan klinis, tetapi juga bertindak sebagai edukator dan fasilitator perubahan perilaku kesehatan pada perempuan dan keluarga. Bidan sering kali menjadi sumber informasi utama bagi perempuan mengenai perencanaan kehamilan, pencegahan komplikasi, gizi antenatal, dan pencegahan penyakit menular seksual (Prasetyo, 2025).

Di Puskesmas dan fasilitas primer lainnya, bidan juga terlibat dalam penyuluhan dan konseling reproduksi untuk remaja dan pasangan usia subur, misalnya, edukasi tentang pencegahan kelainan genetik melalui saran mengenai pola hidup sehat dan pentingnya deteksi dini (Winatasari *et al.*, 2025). Dalam konteks promosi kesehatan reproduksi, bidan berperan meningkatkan kesadaran akan hak-hak reproduktif serta membantu perempuan membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab terkait kesehatan mereka, termasuk pemilihan metode kontrasepsi dan dukungan selama kehamilan. Hal ini menjadikan bidan sebagai aktor kunci dalam pengurangan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kualitas hidup keluarga.

2. Peran Perawat

Perawat memiliki peran multifaset dalam promosi kesehatan reproduksi. Selain memberikan perawatan dasar, perawat sering bertindak sebagai edukator

kesehatan, konselor pasien, koordinator pelayanan, dan advokat kesehatan di komunitas. Dalam konteks promosi kesehatan reproduksi, perawat memberikan penyuluhan tentang kesehatan seksual, pencegahan infeksi menular seksual, serta dukungan psikososial bagi klien di berbagai setting pelayanan kesehatan. Mereka juga sering terlibat dalam kegiatan edukasi sekolah dan kelompok remaja, yang terbukti membantu memperkuat pemahaman dan sikap positif terhadap perilaku sehat (Afrianti *et al.*, 2017).

Perawat juga memainkan peran penting dalam pengelolaan kasus kompleks serta *follow-up* klien, termasuk memantau kepatuhan terhadap rekomendasi kesehatan reproduksi dan memberi dukungan kontinuitas perawatan yang semuanya merupakan aspek penting dari strategi promotif dan preventif. Kolaborasi perawat dengan bidan, dokter, dan profesi lain juga menjadi elemen penting dalam merancang layanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pasien.

3. Peran Apoteker

Apoteker memiliki peran yang berkembang dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk dalam promosi kesehatan reproduksi melalui komunikasi obat dan edukasi terapi. Sebagai ahli sediaan farmasi, apoteker memberikan informasi tentang penggunaan obat yang aman dan tepat, termasuk kontrasepsi hormonal, suplemen nutrisi selama kehamilan, serta peringatan tentang teratogenitas atau interaksi obat yang memengaruhi kesehatan reproduksi (Kurniasih *et al.*, 2022).

Kolaborasi apoteker dengan tenaga kesehatan lain berkontribusi pada optimalisasi penggunaan obat, pengurangan efek samping, serta peningkatan kepatuhan pasien terhadap terapi yang direkomendasikan. Studi literatur menunjukkan bahwa interaksi positif antara apoteker dan tim kesehatan lain dapat meningkatkan kualitas perawatan dan hasil klinis, termasuk dalam manajemen terapi jangka panjang (Kurniasih *et al.*, 2022).

Peran apoteker juga meluas ke edukasi masyarakat melalui kegiatan kampanye kesehatan, konsultasi farmasi, dan penyebaran informasi berbasis bukti terkait risiko obat selama masa reproduksi. Hal ini mendukung upaya promotif yang berkelanjutan serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan kesehatan masyarakat yang lebih luas.

4. Peran Ahli Gizi

Ahli gizi memainkan peran penting dalam promosi kesehatan reproduksi melalui pemberian edukasi dan konseling nutrisi yang tepat, terutama pada fase prakonsepsi, kehamilan, dan postpartum. Intervensi edukasi nutrisi yang dikombinasikan dengan informasi kesehatan reproduksi telah terbukti

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik gizi serta reproduksi di kalangan ibu hamil (Permatasari *et al.*, 2021).

Ahli gizi bertanggung jawab memberikan saran diet yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis individu, termasuk penekanan terhadap asupan zat gizi esensial seperti zat besi, folat, dan protein guna mendukung perkembangan janin dan mengurangi risiko komplikasi seperti anemia atau stunting (Permatasari *et al.*, 2021).

Dalam kerangka promosi kesehatan reproduksi, ahli gizi juga mendukung perubahan perilaku makan untuk pencegahan obesitas, diabetes gestasional, dan masalah metabolik lain yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Peran ini semakin relevan bila disinergikan dengan tenaga kesehatan lain dalam tim interprofesional.

5. Kolaborasi Interprofesional dalam Pendekatan Holistik

Kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai profesi kesehatan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program kesehatan reproduksi. Menurut literatur, interprofessional collaboration (IPC) adalah proses di mana tenaga kesehatan dari latar belakang profesi berbeda bekerja bersama dengan pasien, keluarga, dan komunitas demi memberikan perawatan berkualitas tinggi (Salimi *et al.*, 2022). Tim interprofesional yang efektif meningkatkan koordinasi layanan, mengurangi duplikasi tugas, serta memastikan pesan kesehatan yang konsisten dan bersinergi. Pendekatan semacam ini juga memungkinkan setiap profesional memberikan spesialisasi terbaiknya, misalnya, bidan sebagai fasilitator kehamilan, perawat sebagai edukator lintas setting perawatan, apoteker sebagai konsultan terapi obat, dan ahli gizi sebagai penasihat nutrisi, yang secara kolektif meningkatkan hasil kesehatan reproduksi (Salimi *et al.*, 2022).

Kolaborasi yang baik memerlukan komunikasi yang efektif, pemahaman peran setiap profesional, serta penghormatan terhadap kontribusi masing-masing disiplin ilmu. Pendidikan interprofesional sejak tahap pelatihan profesional juga direkomendasikan untuk memperkuat kemampuan kerja tim dan kolaborasi di lapangan klinis (Baecher-Lind *et al.*, 2022).

H. Etika dan Tantangan Promosi Kesehatan Reproduksi di Era Digital

Promosi kesehatan reproduksi di era digital menawarkan peluang besar untuk memperluas akses informasi dan layanan kesehatan, namun juga menghadirkan serangkaian tantangan etika yang kompleks. Dalam dunia di mana informasi dapat diakses dalam hitungan detik, penting untuk memastikan bahwa komunikasi

dilakukan secara etis, privasi pengguna dilindungi, dan tantangan seperti hoaks dan misinformasi dapat diatasi secara efektif.

1. Etika Komunikasi Kesehatan Reproduksi

Etika komunikasi kesehatan reproduksi berkaitan dengan nilai-nilai moral dan prinsip profesional yang mengatur cara informasi kesehatan disampaikan kepada masyarakat. Komunikasi yang etis mencakup kejujuran, tanggung jawab, transparansi, serta penghormatan terhadap martabat dan hak individu. Etika komunikasi menjadi krusial karena pesan kesehatan reproduksi sering melibatkan isu sensitif seperti seksualitas, kontrasepsi, kehamilan, dan identitas gender, yang dapat memengaruhi pandangan dan keputusan kehidupan seseorang (Rusly & Rahmawati, 2025).

Menurut prinsip etika komunikasi, tenaga kesehatan harus menyajikan informasi yang akurat, berbasis bukti ilmiah, serta sensitif terhadap nilai budaya dan norma masyarakat sasaran. Informasi yang disampaikan melalui media digital harus mempertimbangkan konteks sosial budaya, serta tidak menimbulkan ketakutan, stigma, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu (WHO, 2013). Kode etik profesi kesehatan seperti yang digariskan oleh World Health Organization menekankan bahwa edukasi kesehatan harus menghormati otonomi pasien dan hak mereka untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar.

2. Privasi, Keamanan Data, dan Perlindungan Pengguna

Salah satu tantangan terbesar dalam promosi kesehatan reproduksi digital adalah perlindungan privasi dan keamanan data pengguna. Informasi terkait kesehatan reproduksi seringkali tergolong sangat sensitif, karena mencakup data pribadi mengenai status kesehatan, riwayat medis, perilaku seksual, serta keputusan reproduktif seseorang. Penyalahgunaan atau kebocoran data semacam itu dapat menyebabkan stigma, diskriminasi, bahkan trauma psikologis bagi pengguna.

Selain itu, tidak semua platform digital diwajibkan tunduk pada standar perlindungan data kesehatan yang ketat seperti yang berlaku untuk sistem kesehatan resmi. Ini berarti data yang dikumpulkan oleh aplikasi, media sosial, atau layanan edukasi kesehatan belum tentu dilindungi oleh hukum kesehatan seperti peraturan perlindungan data pasien dalam layanan kesehatan formal (Sintyasari & Risdawati, 2025). Di banyak negara berkembang, regulasi perlindungan data kesehatan masih dalam tahap pengembangan dan implementasi, sementara perusahaan teknologi sering beroperasi dalam ekosistem global yang berbeda-beda yurisdiksinya. Paradigma ini memunculkan tantangan dalam penegakan hukum dan standar privasi yang konsisten, sehingga

membutuhkan kolaborasi kebijakan antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan penyedia teknologi digital.

3. Hoaks dan Misinformasi Kesehatan

Sebagai lanskap informasi terbuka, internet juga menjadi saluran penyebaran hoaks dan misinformasi kesehatan, termasuk dalam topik kesehatan reproduksi. Misinformasi ini dapat berupa klaim palsu tentang kontrasepsi, terapi tidak terbukti secara ilmiah, serta narasi tentang risiko kesehatan yang tidak berdasarkan bukti medis. Sebuah kajian naratif menemukan ratusan narasi menyesatkan tentang berbagai aspek kesehatan reproduksi yang tersebar di media sosial dan situs online, dari informasi yang memberikan gambaran keliru tentang metode kontrasepsi hingga pengetahuan yang salah tentang kehamilan dan kanker (Rosen & Stern, 2025).

Misinformasi semacam ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap rekomendasi kesehatan resmi, mendorong perilaku yang berisiko, serta memperparah ketidaksetaraan akses informasi yang benar secara ilmiah. Contohnya, jika informasi palsu membuat hormon kontrasepsi tampak secara tidak akurat sangat berbahaya, hal itu dapat menurunkan kepercayaan remaja ataupun pasangan usia subur terhadap penggunaan kontrasepsi yang efektif.

4. Strategi Pencegahan dan Penanganan Tantangan

Untuk menghadapi tantangan etika, privasi, serta hoaks di era digital, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi kesehatan, komunitas akademik, serta platform teknologi digital.

a. Pendidikan Literasi Kesehatan Digital

Meningkatkan literasi kesehatan digital di kalangan masyarakat dan tenaga kesehatan merupakan strategi penting untuk membekali individu dengan kemampuan mengidentifikasi sumber informasi yang sah serta mengevaluasi kredibilitas konten kesehatan. Literasi digital membantu mencegah penyebaran hoaks dan mendorong konsumen informasi untuk memilih sumber berdasarkan bukti ilmiah daripada opini yang tidak terverifikasi.

b. Standar Etika dan Regulasi Perlindungan Data

Pembuatan dan penegakan standar etika komunikasi digital serta regulasi perlindungan data kesehatan sangat penting. Pemerintah perlu memperkenalkan peraturan yang jelas terkait hak atas privasi data kesehatan, perlindungan hukumnya, serta tanggung jawab penyedia teknologi digital dalam mengelola data sensitif. Standar semacam ini harus mencakup prinsip transparansi, persetujuan informasi (*informed consent*), serta hak untuk menarik data pribadi dari sistem digital kapan pun diminta pengguna.

c. Moderasi Konten dan Pengawasan Algoritma

Platform digital perlu menerapkan sistem moderasi konten yang kuat serta mekanisme pelaporan yang efektif untuk mengurangi hoaks dan misinformasi. Selain itu, algoritma sistem harus dirancang untuk mendorong konten yang berbasis bukti ilmiah, bukan hanya konten populer atau viral yang belum terverifikasi. Kolaborasi antara pakar kesehatan dan teknolog sangat penting dalam proses ini.

d. Kolaborasi Interprofesional

Peningkatan kolaborasi antarprofesi kesehatan, regulator, serta komunitas digital juga diperlukan untuk merumuskan pedoman penerapan etika dalam promosi kesehatan reproduksi digital. Pendekatan ini harus mengintegrasikan perspektif medis, sosial budaya, hukum, dan teknologi, sehingga strategi yang diterapkan komprehensif dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

I. Monitoring dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan Reproduksi

Monitoring dan evaluasi (M&E) merupakan komponen penting dalam setiap program promosi kesehatan reproduksi karena menyediakan informasi sistematis tentang pencapaian tujuan, efektivitas strategi yang digunakan, serta dampak yang dihasilkan. Proses ini tidak hanya membantu memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana, tetapi juga menyediakan data yang dibutuhkan untuk perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis bukti (Oyediran, Makinde & Mullen, 2014).

1. Indikator Keberhasilan Promosi Kesehatan

Indikator keberhasilan program adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai apakah tujuan program tercapai. Indikator ini biasanya dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, yaitu indikator input, proses, output, outcome, dan dampak.

- a. Indikator input mencakup sumber daya yang tersedia untuk program, seperti data sasaran, jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, sarana prasarana edukasi, serta anggaran yang dialokasikan untuk promosi kesehatan reproduksi.
- b. Indikator proses mencerminkan bagaimana kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, misalnya persentase materi edukasi yang disampaikan sesuai standar, frekuensi kegiatan penyuluhan, atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi kesehatan reproduksi.
- c. Indikator output biasanya berhubungan dengan hasil langsung dari kegiatan, seperti jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan, jumlah materi distribusi, atau pencapaian target partisipasi kelompok rentan.

- d. Indikator outcome atau hasil jangka menengah menilai perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik sasaran program (Rukmady et al., 2022).
- e. Indikator dampak mencerminkan perubahan jangka panjang dalam kondisi kesehatan masyarakat, seperti penurunan angka kehamilan tidak diinginkan, penurunan angka infeksi menular seksual, atau peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dalam populasi target. Untuk indikator ini, penggunaan survei populasi seperti survei demografi dan kesehatan atau sistem informasi kesehatan rutin sering diperlukan karena data dampak tidak dapat diukur dalam jangka pendek (Broaddus-Shea *et al.*, 2019).

2. Evaluasi Proses, Hasil, dan Dampak

Evaluasi adalah proses sistematis yang bertujuan mengukur efektivitas dan efisiensi program melalui analisis komprehensif terhadap berbagai indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dibedakan menjadi tiga tipe utama: proses, hasil (*outcome*), dan dampak.

- a. Evaluasi proses menilai bagaimana kegiatan program dijalankan, apakah tepat sasaran, dan sesuai standar operasional yang berlaku. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan memberikan rekomendasi perbaikan operasional.
- b. Evaluasi hasil berfokus pada output dan outcome yang dihasilkan oleh program. Misalnya, perubahan dalam tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi setelah intervensi edukasi, atau perubahan sikap terhadap perilaku seksual aman, dapat diukur melalui survei pretest–posttest atau kuesioner terstandar yang dilakukan sebelum dan sesudah program.
- c. Evaluasi dampak menilai efek jangka panjang dari program terhadap indikator kesehatan masyarakat yang lebih luas. Contohnya termasuk penurunan angka kehamilan remaja di wilayah intervensi, peningkatan cakupan layanan skrining kanker serviks, atau penurunan infeksi menular seksual dalam populasi target. Evaluasi dampak seringkali memerlukan pendekatan desain kuasi-eksperimental atau data longitudinal untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi bukan karena faktor luar program (Broaddus-Shea *et al.*, 2019).

Monitoring dan evaluasi yang direncanakan dari awal merupakan bagian integral dari manajemen program karena membantu memastikan bahwa upaya promotif dan preventif dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Integrasi M&E sejak desain program juga memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan dan menciptakan akuntabilitas di semua level implementasi (Oyediran, Makinde & Mullen, 2014).

3. Pemanfaatan Data Digital dan Umpan Balik Komunitas

Pemanfaatan data digital saat ini menjadi komponen penting dalam M&E program promosi kesehatan reproduksi. Data digital memungkinkan pengumpulan, analisis, dan visualisasi data secara real-time, sehingga memudahkan pemantauan status kegiatan dan efek yang ditimbulkan. Sistem informasi kesehatan elektronik, survei digital, dan aplikasi pelaporan dapat digunakan untuk melacak indikator aktivitas secara berkelanjutan, mempercepat proses evaluasi, serta menyediakan dasar untuk intervensi strategis yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, umpan balik komunitas menjadi elemen penting dalam evaluasi program karena memberikan perspektif langsung tentang pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap program yang berjalan. Umpan balik ini dapat dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus, survei kepuasan, atau forum komunitas yang melibatkan peserta program dan pelaksana di level lokal. Pendekatan partisipatif seperti ini tidak hanya meningkatkan kualitas data evaluatif tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan komunitas terhadap program kesehatan reproduksi.

Keterlibatan masyarakat dalam monitoring juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, di mana masyarakat mampu menilai sendiri kemajuan program serta memberikan masukan yang relevan untuk perbaikan strategi intervensi.

4. Perbaikan Berkelanjutan Program Promosi Kesehatan

Perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) merupakan hasil yang diharapkan dari proses monitoring dan evaluasi yang efektif. Perbaikan ini melibatkan peninjauan berkala terhadap data yang dikumpulkan, analisis indikator kunci, identifikasi area masalah, serta penetapan tindakan korektif. Model perbaikan ini juga terkadang memanfaatkan siklus *Plan-Do-Study-Act* (PDSA) yang memastikan setiap perubahan diikuti dengan evaluasi hasil sebelum diadopsi secara lebih luas.

Melalui perbaikan berkelanjutan, program promosi kesehatan reproduksi dapat terus berevolusi sesuai dengan dinamika kebutuhan sasaran, perkembangan indikator kesehatan, serta tantangan sosial-budaya yang muncul. Perbaikan ini juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas intervensi, kepuasan peserta program, serta keberlanjutan dampaknya dalam jangka panjang.

J. Simpulan

Bab ini telah membahas berbagai aspek penting dalam promosi kesehatan reproduksi holistik, mulai dari landasan teoretis program, strategi media digital dan komunitas, peran tenaga kesehatan, hingga masalah etika dan tantangan di era digital. Dalam pendekatan holistik, kesehatan reproduksi dipandang sebagai aspek yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, sosial, budaya, serta hak dan pilihan individu (Agatta, Marhaeni & Said, 2025). Pendekatan ini menuntut integrasi ilmu perilaku, pemberdayaan komunitas, serta pemanfaatan media digital secara bertanggung jawab untuk mencapai perubahan perilaku yang berkelanjutan dan berdampak luas. Integrasi media digital dan edukasi komunitas juga terbukti efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan reproduksi, terutama di kalangan remaja, dengan memadukan jangkauan luas digital dan pertemuan tatap muka yang kontekstual (Rosyidah, 2024).

Monitoring dan evaluasi sebagai komponen manajemen program menyediakan data yang dapat dipakai untuk menyesuaikan strategi dan meningkatkan efektivitas intervensi, menggambarkan bahwa program yang direncanakan dengan baik dapat beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat sasaran. Dalam praktiknya, evaluasi tidak hanya melihat perubahan pengetahuan tetapi juga dampak jangka panjang terhadap perilaku dan outcome kesehatan yang lebih luas. Tantangan etika dalam penggunaan media digital juga dibahas, termasuk pentingnya komunikasi yang akurat dan penghormatan terhadap privasi serta perlindungan data pengguna. Dominasi hoaks dan misinformasi juga memerlukan strategi sistematis untuk pemantauan konten dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Secara keseluruhan, pendekatan holistik dalam promosi kesehatan reproduksi menempatkan pemberdayaan individu dan komunitas sebagai inti dari perubahan perilaku, sekaligus mengharuskan kolaborasi lintas disiplin ilmu dan penggunaan evidensi ilmiah dalam penyusunan kebijakan dan program. Model ini berfokus pada pemahaman holistik terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi di berbagai tahap kehidupan dan pada berbagai kelompok populasi.

1. Implikasi Praktis bagi Tenaga Kesehatan

Bagi tenaga kesehatan, termasuk bidan, perawat, apoteker, dan ahli gizi. Pemahaman terhadap konsep promosi kesehatan reproduksi holistik memiliki sejumlah implikasi praktis penting:

- a. Pendekatan Edukatif yang Adaptif: Praktisi harus mampu menyusun materi edukasi yang responsif terhadap kebutuhan individu dan komunitas, memanfaatkan media digital dan tatap muka agar informasi dapat diakses secara efektif oleh berbagai kelompok usia dan latar sosial. Hal ini telah

ditunjukkan pada beberapa program penyuluhan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi setelah intervensi edukatif terpadu.

- b. Kolaborasi Interprofesional: Integrasi peran berbagai profesi kesehatan akan memperkuat pendekatan holistik. Misalnya, bidan tidak hanya memberi layanan klinik tetapi juga menjadi penggerak edukasi komunitas, sementara apoteker dan ahli gizi mendukung dengan informasi terapi obat dan nutrisi yang tepat pada strategi medis reproduksi tertentu. Kolaborasi ini merupakan aspek penting dalam memastikan layanan yang komprehensif dan berkualitas.
- c. Pemanfaatan Data dan Evaluasi: Tenaga kesehatan harus terampil dalam mengumpulkan dan menggunakan data hasil monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan program dengan indikator yang jelas seperti perubahan perilaku, peningkatan akses layanan, atau penurunan angka masalah reproduksi spesifik. Data digital yang akurat menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.
- d. Komunikasi Etis dan Sensitif Budaya: Praktisi harus selalu memperhatikan etika komunikasi, termasuk menghormati keragaman budaya dan norma dalam menyampaikan informasi medis dan edukatif, serta menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pasien atau peserta edukasi.

2. Arah Pengembangan Promosi Kesehatan Reproduksi Holistik

Melihat perkembangan tantangan kesehatan masyarakat dan teknologi, arah pengembangan promosi kesehatan reproduksi holistik perlu memperhatikan beberapa hal:

- a. Integrasi Inovasi Digital: Peran digital akan terus berkembang, termasuk aplikasi mobile, AI yang sensitif budaya, dan sistem edukasi gamifikasi yang telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan remaja. Pengembangan dan evaluasi tools seperti ini dapat memperluas jangkauan program.
- b. Kurikulum Pendidikan Formal dan Nonformal: Integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum sekolah, pelatihan tenaga pendidikan, serta program pendidikan keluarga dapat memperkuat pemahaman sejak dini, sehingga tindakan preventif bisa lebih efektif dalam jangka panjang.
- c. Pendekatan Berbasis Hak dan Inklusif: Program di masa depan perlu menekankan *rights-based approach* yang menghormati hak reproduksi individu dari berbagai latar sosial, gender, dan status ekonomi, serta memperhatikan kelompok yang rentan atau marginal.

- d. Penelitian dan Evaluasi Lanjutan: Evaluasi efektivitas intervensi yang lebih rigour dan cakupan populasi yang beragam akan memperkaya bukti ilmiah dan memandu praktik terbaik dalam program promotif.

Dengan demikian, promosi kesehatan reproduksi holistik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan pemberdayaan, kolaborasi lintas sektor, dan adaptasi strategi sesuai dinamika sosial dan teknologi.

K. Referensi

- Adediran, F. E., Igbokwe, J. C., & Daraojimba, R. E. (2024). *Integrating reproductive health into community development and social work: Strategies for effective engagement and empowerment. Open Access Research Journal of Multidisciplinary Studies*, 7(1), 102–110.
- Agatta, S. K., Marhaeni, C. C., & Said, I. (2025). *Reproductive health in the context of health promoting university (HPU). Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Ambali, D. D., Uly, N., & Alim, A. (2025). *Pendidikan dan komunikasi dalam kesehatan reproduksi remaja: Systematic literature review. Jurnal Promotif Preventif*.
- American Library Association. (2017). *Digital literacy defined*.
- Amir, S. (2025). *Penerapan Health Promotion Model terhadap pengetahuan wanita usia subur tentang kontrasepsi implant. Jurnal Penelitian Perawat Profesional*.
- Anita, D. N. (2025). *Edukasi kesehatan reproduksi berbasis kearifan lokal untuk remaja di Desa Danau Usung. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*.
- Astutik, H., & Apsari, D. D. (2024). *Pemberdayaan ibu dalam kelompok PKK melalui pelatihan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*.
- Baecher-Lind, L., Fleming, A. C., Bhargava, R., Cox, S. M., Everett, E. N., Forstein, D. A., ... & Sutton, J. M. (2022). *Enhancing interprofessional collaboration and interprofessional education in women's health. Med Educ Online*.
- Ban, S., Kim, Y., & Seomun, G. (2023). *Digital health literacy: A concept analysis. Digital Health Journal*.
- Broadus-Shea, E. T., et al. (2019). *A systematic review of monitoring and evaluation indicators for sexual and reproductive health in humanitarian settings. Conflict and Health*, 13, 43.

- Christina Rony Nayoan & Gilbert Yesaya Haninuna. (2023). *Monitoring dan evaluasi pelatihan kader posyandu remaja*. Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat, 4(1).
- Fadhilah, I. (2025). *Pemberdayaan masyarakat Desa Bunde dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan seksualitas melalui edukasi kebidanan*. Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Frontiers. (2024). *Unveiling barriers to reproductive health awareness among rural adolescents: a systematic review*. *Frontiers in Reproductive Health*.
- Hafid, N. F., Hamzah, Z. R., & Anma, A. R. (2025). *Edukasi literasi digital kesehatan untuk remaja*. *Community Development Journal*.
- Harahap, N. H., Hadi, A. J., & Ahmad, H. (2024). *Efektivitas pendidikan kesehatan menggunakan pendekatan Health Belief Model terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi remaja*. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia.
- Hartati, D., & Astuti, A. W. (2024). *Health services strategy of adolescent sexual reproductive health in developing countries*. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*.
- Infopublik.id. (2025). *Peran vital bidan dalam kesehatan reproduksi dan peningkatan kualitas SDM*. Retrieved from <https://infopublik.id>
- Kurniasih, A., Sinta, I., Syania, S., Andini, H., & Pudji Setiawati, E. (2022). *Peran apoteker dalam kolaborasi interprofesi: studi literatur*. *Majalah Farmaseutik*.
- Kustin, K., & Handayani, Y. (2025). *Health Belief Model tentang upaya pencegahan perilaku seks bebas pada remaja*. ARTERI: Jurnal Ilmu Kesehatan.
- Longgupa, L. W., Nurmiaty, N., Muliani, et al. (2025). *Pemberdayaan remaja tentang kesehatan reproduksi melalui pelatihan interaktif*. *Jurnal Masyarakat Mandiri*.
- Marpaung, S. H. (2025). *Edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja putri untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan*. *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Mattison, C. A., Lavis, J. N., Wilson, M. G., Hutton, E. K., & Dion, M. L. (2020). *A critical interpretive synthesis of the roles of midwives in health systems*. *Health Research Policy and Systems*.
- Nisa, A. A., Khairinnisa, A. N. S., Rahmatammuna, R. N., et al. (2025). *Reproductive Health Education Based on Positive Youth Development through Youth*

Posyandu. Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education.

Orem, D. E. (1959–2001). *Self-Care Deficit Nursing Theory*. [Grand nursing theory].

Oyediran, K. A., Makinde, O. A., & Mullen, S. (2014). *Monitoring and Evaluation of Sexual and Reproductive Health Programmes*. In *Confronting the Challenge of Reproductive Health in Africa: A Textbook for Students and Development Practitioners*. BrownWalker Press.

Pender, N.J., Murdaugh, C.L. and Parson, M.A (2011). *Health Promotion in Nursing Practice*. 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Permatasari, T. A. E., Rizqiya, F., Kusumaningati, W., Suryaalamshah, I. I., & Hermiwahyoeni, Z. (2021). *The effect of nutrition and reproductive health education of pregnant women in Indonesia*. *BMC Pregnancy Childbirth*.

Pertiwi, K. R., & Mariyam, S. (2025). *Peer-based health educator sebagai approach pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah*. *Humanism: Journal of Community Empowerment*.

Prasetyo, R. H. (2025). *Peran 'Aisyiyah dalam promosi kesehatan reproduksi perempuan terhadap implementasi*. *Litera Inti Aksara*.

Rohman, A. A., & Aniroh, U. (2025). *Strategi peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja melalui media video animasi*. *Journal of Holistics and Health Sciences*, 7(1), 215–223.

Rosen, L., & Stern, M. (2025). *Online misleading information about women's reproductive health: A narrative review*. *Journal of General Internal Medicine*, 40, 1123–1131.

Rosyidah, R. (2024). *Peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi dan literasi digital bagi remaja putri melalui pendekatan psikoedukatif komunitas*. *DedikasiMU: Journal of Community Service*.

Rosyidah, R. (2025). *Peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi dan literasi digital remaja*. *DedikasiMU Journal*.

Rukmady, G., Purnamasari, N. P., Mallapiang, F., & Sadarang, R. A. I. (2022). *Evaluasi program edukasi kesehatan reproduksi terhadap perilaku remaja*. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas*, 2(1), 60–66.

Rusly, N. F., & Rahmawati, F. N. (2025). *Edukasi kesehatan reproduksi dalam format digital: gaya komunikasi di platform TikTok*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1).

- Sakti, P. M., Hartini, D. A., & Ra'bung, A. S. (2025). *Pemberdayaan komunitas melalui edukasi terintegrasi untuk mencegah pernikahan dini. Jurnal Masyarakat Mandiri.*
- Salimi, S., et al. (2022). *"Interprofessional Collaboration" among pharmacists, physicians and nurses: Hybrid concept analysis. International Journal of Nursing and Midwifery Research.*
- Sintyasari, D., & Risdawati, I. (2025). *Urgensi reformasi hukum kesehatan di era digital: Antara etika, privasi data, dan perlindungan hak pasien. Indonesia Journal of Business Law, 4(2).*
- Sonjati, E., Arisara, G., Afriani, D., & Khoirunnisa, T. (2025). The effect of health promotion on adolescents' knowledge of reproductive health. *HealthCare Nursing Journal.*
- Sumaryani, S., & Purwaningsih, H. (2025). Adolescents and reproductive health: promoting healthy habits for reproductive well-being. *Journal of Community Service and Empowerment.*
- Sunarsih, T., Astuti, E. P., Shanti, E. F. A., & Ambarwati, E. R. (2020). Health promotion model for adolescent reproductive health. *Electronic Journal of General Medicine, 17(3)*, em212.
- Tepy, D., Afrilia, E. M., Faadhilah, A., & Damayanti, W. (2024). Holistic approaches in women's reproductive health care: integrating conventional medicine and complementary therapies. *Majority Science Journal.*
- Titisari, I. A., Riyanti, E., & Prabamurti, P. N. (2018). *Aplikasi Health Belief Model pada partisipasi wanita usia subur dalam pemeriksaan IVA. Jurnal Kesehatan Masyarakat.*
- Umaroh, A. K., & Karjoso, T. K. (2025). *Komunikasi kesehatan tentang kesehatan reproduksi dan seksual komprehensif. PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat.*
- Winatasari, et al. (2025). *Peran bidan dalam pencegahan kelainan genetik melalui edukasi dan konseling reproduksi. Jurnal Ners Universitas Pahlawan.*
- World Health Organization & PSNet. (2025). *Digital health literacy and health promotion.*
- World Health Organization. (2013). *Ethics and health communication.* Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025.* Geneva: WHO.

World Health Organization. (2025). *Community empowerment – health promotion*. Retrieved from <https://www.who.int/teams/health-promotion>

World Health Organization. (2025). *Sexual and reproductive health and rights*. Retrieved from <https://www.who.int/health-topics/sexual-and-reproductive-health-and-rights>

Wulansari, M., Atikah, S., Sasmita, A., & Ardiningtyas, L. (2025). *Pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi: Literature review. Jurnal Ventilator*.

L. Glosarium

Akuntabilitas

Tanggung jawab penyelenggara program/tenaga kesehatan untuk dapat mempertanggungjawabkan proses, penggunaan sumber daya, dan hasil program secara transparan.

Analitik (analytics)

Fitur pada platform digital untuk memantau jangkauan konten, interaksi pengguna, dan performa kampanye secara terukur.

Cues to action (pemicu tindakan)

Faktor yang mendorong seseorang bertindak melakukan perilaku sehat (misalnya kampanye, pengingat aplikasi, dukungan teman/keluarga) dalam kerangka HBM.

Determinasi sosial (social determinants)

Faktor sosial yang memengaruhi kesehatan, seperti pendidikan, ekonomi, akses layanan, norma sosial, dan dukungan keluarga.

Evidence-based (berbasis bukti)

Materi dan rekomendasi kesehatan yang disusun berdasarkan penelitian ilmiah yang valid dan pedoman resmi, bukan opini atau mitos.

Follow-up (tindak lanjut)

Kegiatan lanjutan setelah edukasi/konseling, misalnya pemantauan perilaku, rujukan, penguatan pesan, atau kunjungan ulang.



PROFIL PENULIS



Sitawati, S.ST., M. Keb, Lahir di Pare-pare, 28 Februari 1994. Telah menamatkan pendidikan Diploma III kebidanan di StiKes Bina Bangsa Majene pada tahun 2015, Diploma IV Bidan Pendidik di StiKes Mega Rezky Makassar pada tahun 2017 dan pendidikan Magister Ilmu Kebidanan di Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Saat ini adalah dosen tetap di Prodi S1 Kebidanan dan sedang aktif dalam melakukan pengajaran dengan mengampu Mata kuliah Asuhan Remaja dan Asuhan Kehamilan. Prinsip Hidup: Kejarlah dan gapailah apa yang kamu inginkan, tapi mulailah semuanya dari rasa syukur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: masyita3399@gmail.com



Maria F. Nining Kosad, SST., M.Kes. Lahir di Kupang, 10 November 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan. Pendidik pada Program Studi Kedokteran, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjra Madah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2006. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun Pengalaman bekerja Sebagai Bidan PTT di Desa Seki Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Tahun 1995–1997, Bidan PTT merangkap Kepala Puskesmas. Pembantu di desa Kuanheum Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Propinsi NTT Tahun 1997–1998. Tahun 2001–sekarang Sebagai Dosen pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Gender dan PUG, Askeb Komunitas dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: 10niningkosad11@gmail.com



PROFIL PENULIS



Khafidhiyah Nur Insaniyah, S.Tr.Keb. M.Kes. Lahir di Surabaya, 06 September 1995. Pendidikan yang telah ditempuh jenjang D-III pada program studi Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan lulus tahun 2016. Dilanjut D-IV pada program studi Kebidanan di Universitas STRADA dan lulus tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada program studi Ilmu Kesehatan Reproduksi di Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan penulis diawali menjadi asisten bidan pada tahun 2017. Saat ini penulis bekerja di STIKes Maharani Malang pada program studi S1 Kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail :

khafidhiyah@stikesmahrani.ac.id



Sriama Muliani, S.ST., M.Kes. Lahir di Lombok Timur NTB, 30 Oktober 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi DIV Kebidanan Klinik, Politeknik Kementrian Kesehatan Mataram tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai Laboran, dan Menjadi Dosen sejak tahun 2012, Sebagai Anggota GPPM sejak 2017 sampai dengan 2025, sebagai Anggota GPM 2025 sampai dengan sekarang, Ketua Program Studi DIII Kebidanan sejak 2022 sampai sekarang. Saat ini penulis bekerja di UNIV Nahdlatul Wathan Mataram mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan KB, Fundamental Kebidanan, Pelayanan Kontrasepsi dan Kesehatan Keluarga, dan Asuhan Kebidanan Neonatus. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian Masyarakat, aktif dalam OP, aktif dalam kepanitiaan didalam dan diluar kampus, penyusun soal UKOM Nasional dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sriamamuliani12@gmail.com



PROFIL PENULIS



Bdn. Ade Rahayu Prihartini, S.ST., M.Kes. lahir di Sindang-Indramayu pada tanggal 26 September 1986. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu Diploma III Kebidanan STIKes Cirebon (2007), Diploma IV Poltekes Bhakti Pertiwi Husada Cirebon (2009), Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia (2013) dan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Bina Bangsa (2025). Riwayat pekerjaan penulis yaitu tahun 2007 – 2020 bekerja di Poltekes Bhakti Pertiwi Husada Cirebon, tahun 2020-2024 bekerja di STIKes YLPP Cirebon, dan saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Bangsa, Serang-Banten

sebagai Dosen di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, penulis mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas dan Asuhan Kebidanan pada Remaja, Pranikah dan Prakonsepsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, narasumber seminar, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, penulis saat ini aktif sebagai anggota HPTKes Provinsi Banten Divisi Akreditasi periode 2025-2029.

Penulis dapat dihubungi melalui email: nenkdiva@gmail.com



Fina Sancaya Rini, S,ST.M.Kes. Lahir di Sukoharjo 15 Mei 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Kebidanan di Akademi kebidanan Al- Ikhlas Lulus Tahun 2009, kemudian melanjutkan Diploma IV Bidan Pendidik Pada Universitas Respati Indonesia Jakarta lulus Tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keshatan Masyarakat peminatan Kesehatan Reproduksi pada Universitas Respati Indonesia Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2014., Saat ini sedang melanjutkan Studi S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Negri Semarang. Riwayat

pekerjaan diawali pada tahun 2009 menajdi bidan di Rumah Bersalin Insani, kemudian tahun 2012 mulai bekerja sebagai dosen di Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor sampai dengan tahun 2017. Saat ini penulis bekerja di Akademi Kebidanan Al-Ikhlas Cisarua Bogor, dan mengampu beberapa mata kuliah inti kebidanan yaitu: Askeb komunitas, Kesehatan Reproduksi & KB, Sosial Budaya dalam kebidanan, Komunikasi dalam praktik kebidanan dan pengantar asuhan kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar naional/internasional serta menjabat sebagai ketua lembaga penelitian danpengabdian masyarakat (LPPM). Penulis dapat dihubungi melalui email:finasancayarini@gmail.com

PROFIL PENULIS



Queen Khoirun Nisa' Mairo, Terlahir di Kota Tangerang tahun 1982 dan telah menyelesaikan S2 Kebidanan di Univeritas Padjajaran Bandung pada Februari 2013, Pendidikan Profesi Bidan di September 2022 dan pada Mei 2025 telah menyelesaikan program Doktorat pada fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Aktif bekerja sebagai Dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya sejak 2007.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Kebidanan, Kesehatan Reproduksi dan KIA. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku dengan

harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca.

Email Penulis: queenmairo82@poltekkes-surabaya.ac.id

Pesan Untuk Pembaca: Buku ini hadir sebagai ikhtiar kecil dalam berbagi gagasan, untuk membantu pembaca memahami konsep dan penerapan KESEHATAN REPRODUKSI HOLISTIK dengan PENDEKATAN INTEGRATIF. Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penyajiannya, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat sebagai rujukan dalam pembelajaran dan pengembangan keilmuan.

Sinopsis

Buku bunga rampai "Kesehatan Reproduksi Holistik: Pendekatan Integratif bagi Bidan, Perawat, Apoteker, dan Ahli Gizi" menghadirkan rangkaian pembahasan yang menempatkan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kesejahteraan manusia yang utuh tidak hanya fisik, tetapi juga mental, sosial, budaya, dan spiritual sepanjang siklus kehidupan. Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks, di mana isu kesehatan reproduksi sering beririsan dengan determinan sosial, literasi kesehatan, ketimpangan akses layanan, serta perubahan perilaku di era digital.

Melalui perspektif lintas profesi, bunga rampai ini menegaskan bahwa kesehatan reproduksi tidak dapat ditangani secara terpisah. Bidan berperan strategis dalam pelayanan kesehatan perempuan dan ibu-anak, perawat memperkuat asuhan holistik serta kesinambungan layanan, apoteker memastikan keamanan penggunaan obat dan suplemen pada fase reproduktif (prakonsepsi–kehamilan–menyusui), dan ahli gizi menuntun intervensi nutrisi yang tepat untuk mencegah anemia, KEK, stunting, serta komplikasi kehamilan. Kolaborasi interprofesional menjadi benang merah yang menghubungkan peran tiap profesi agar layanan tidak terfragmentasi, pesan kesehatan konsisten, dan keputusan klinis lebih aman serta efektif.

Buku ini juga membahas tantangan kontemporer seperti kesehatan reproduksi remaja, kehamilan tidak direncanakan, infeksi menular seksual, manajemen laktasi, serta program pencegahan stunting pada 1000 HPK, dengan menekankan pentingnya edukasi berbasis komunitas yang peka budaya dan penguatan literasi kesehatan. Di era digital, buku ini mengulas bagaimana media digital, tele-edukasi, dan sistem informasi kesehatan dapat memperluas akses promosi kesehatan reproduksi, sekaligus mengingatkan risiko etika, privasi, dan misinformasi yang perlu dikelola secara profesional.

Disusun dengan pendekatan yang aplikatif dan kontekstual, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, praktisi kesehatan, dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih manusiawi, terintegrasi, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Dengan demikian, bunga rampai ini tidak hanya menawarkan pengetahuan, tetapi juga strategi dan inspirasi untuk memperkuat kesehatan reproduksi sebagai investasi utama bagi kualitas generasi masa depan.

Buku bunga rampai “Kesehatan Reproduksi Holistik: Pendekatan Integratif bagi Bidan, Perawat, Apoteker, dan Ahli Gizi” menghadirkan rangkaian pembahasan yang menempatkan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kesejahteraan manusia yang utuh tidak hanya fisik, tetapi juga mental, sosial, budaya, dan spiritual sepanjang siklus kehidupan. Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks, di mana isu kesehatan reproduksi sering beririsan dengan determinan sosial, literasi kesehatan, ketimpangan akses layanan, serta perubahan perilaku di era digital.

Melalui perspektif lintas profesi, bunga rampai ini menegaskan bahwa kesehatan reproduksi tidak dapat ditangani secara terpisah. Bidan berperan strategis dalam pelayanan kesehatan perempuan dan ibu-anak, perawat memperkuat asuhan holistik serta kesinambungan layanan, apoteker memastikan keamanan penggunaan obat dan suplemen pada fase reproduktif (prakonsepsi–kehamilan–menyusui), dan ahli gizi menuntun intervensi nutrisi yang tepat untuk mencegah anemia, KEK, stunting, serta komplikasi kehamilan. Kolaborasi interprofesional menjadi benang merah yang menghubungkan peran tiap profesi agar layanan tidak terfragmentasi, pesan kesehatan konsisten, dan keputusan klinis lebih aman serta efektif.

Buku ini juga membahas tantangan kontemporer seperti kesehatan reproduksi remaja, kehamilan tidak direncanakan, infeksi menular seksual, manajemen laktasi, serta program pencegahan stunting pada 1000 HPK, dengan menekankan pentingnya edukasi berbasis komunitas yang peka budaya dan penguatan literasi kesehatan. Di era digital, buku ini mengulas bagaimana media digital, tele-edukasi, dan sistem informasi kesehatan dapat memperluas akses promosi kesehatan reproduksi, sekaligus mengingatkan risiko etika, privasi, dan misinformasi yang perlu dikelola secara profesional.

Disusun dengan pendekatan yang aplikatif dan kontekstual, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, praktisi kesehatan, dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih manusiawi, terintegrasi, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Dengan demikian, bunga rampai ini tidak hanya menawarkan pengetahuan, tetapi juga strategi dan inspirasi untuk memperkuat kesehatan reproduksi sebagai investasi utama bagi kualitas generasi masa depan.

ISBN 978-634-7556-44-8



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

